

Buku Referensi

PERAN BIDAN DALAM PENDAMPINGAN PERSALINAN ALAMI

Emi Br Barus • Yanti • Yeni Fitrianingsih
Zaitun Hilwa • Sherly Angellina
Lasria Simamora



BUKU REFERENSI

PERAN BIDAN DALAM

PENDAMPINGAN PERSALINAN

ALAMI

Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb

Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb

Dr. Yeni Fitrianingsih, SST., Mkes

Bd. Zaitun Hilwa, S.Tr.Keb., M.K.M

Sherly Angellina, S.SiT., M.Keb

Lasria Simamora, SST., MKM



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PERAN BIDAN DALAM PENDAMPINGAN PERSALINAN ALAMI

Penulis: Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb

Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb

Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST., Mkes

Bd. Zaitun Hilwa, S.Tr.Keb., M.K.M

Sherly Angellina, S.SiT., M.Keb

Lasria Simamora, SST., MKM

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-96041-7-8

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi ini yang berjudul **"Peran Bidan dalam Pendampingan Persalinan Alami"** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebidanan, khususnya dalam memperkuat peran bidan sebagai pendamping profesional dalam proses persalinan yang aman, nyaman, dan alami bagi ibu.

Persalinan alami merupakan pendekatan yang menekankan proses fisiologis tanpa intervensi medis yang tidak perlu, dengan tetap mengedepankan keselamatan ibu dan bayi. Dalam konteks ini, bidan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam memberikan pelayanan klinis, tetapi juga dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, dan kolaborasi lintas profesi untuk memastikan pengalaman persalinan yang positif bagi setiap ibu.

Buku ini terdiri dari enam bab yang disusun secara sistematis, dimulai dari edukasi antenatal tentang manfaat persalinan alami, strategi manajemen nyeri non-farmakologis, hingga edukasi pascapersalinan. Setiap bab mengacu pada hasil penelitian terkini dan praktik berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam pelayanan kebidanan sehari-hari.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang berkomitmen dalam mendukung persalinan yang humanis dan berbasis bukti.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I EDUKASI IBU HAMIL TENTANG MANFAAT PERSALINAN ALAMI.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Edukasi Kesehatan	1
C. Konsep Persalinan.....	2
D. Edukasi Pada Ibu Hamil Tentang Persalinan Alami	4
E. Manfaat Persalinan Alami	5
F. Peran Bidan Dalam Memberikan Edukasi Pada Ibu Hamil Tentang Persalinan Alami ...	6
G. Penutup.....	7
Referensi	8
BAB II STRATEGI PENAGANAN NYERI NON-FARMAKOLOGI PERSALINAN	10
A. Pendahuluan.....	10
B. Nyeri Persalinan	11
C. Konsep Dasar Nyeri Persalinan	12
D. Prinsip Dasar Penanganan Nyeri Persalinan dengan Non Farmakologi	15
E. Teknik Relaksasi Dan Pernapasan.....	18
F. Terapi Fisik untuk mengurangi nyeri.....	19
G. Teknik Stimulasi Sensorik Dan Terapi Alami	21
H. Teknik Stimulasi Sensorik Dan Terapi Alami	21
I. Penutup.....	23
Referensi	24
BAB III PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN JANIN SELAMA PERSALINAN	26
A. Pendahuluan.....	26
B. Tahapan Persalinan dan Fokus Pemantauan	26
C. Metode Pemantauan Kesehatan Ibu	29
D. Metode Pemantauan Kesehatan Janin	30
E. Tanda-tanda Gawat Janin	32
F. Partograf	33
G. Penutup.....	37
Referensi	39
BAB IV DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK IBU SELAMA PROSES PERSALINAN	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Perubahan Psikologis Ibu Menjelang Persalinan Dan Saat Proses Persalinan	41
C. Masalah Psikologis yang Sering Terjadi pada Masa Persalinan	43
D. Faktor Penyebab Masalah Psikologis dalam Persalinan	46
E. Dukungan Psikologis dalam Pemulihan Pasca Melahirkan	51

F. Mengatasi Gangguan Psikologis saat Persalinan	52
G. Penutup.....	54
Referensi	55
BAB V KOLABORASI TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PERSALINAN ALAMI	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Konsep Dasar Kolaborasi dalam Persalinan Alami	58
C. Peran Khusus Profesi Kesehatan dalam Tim Kolaboratif	59
D. Strategi Efektif dalam Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan	61
E. Implementasi Praktis Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami.....	62
F. Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Tenaga Kesehatan	64
G. Studi Kasus Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami	66
H. Evaluasi dan Monitoring Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami.....	67
I. Prospek dan Rekomendasi Kebijakan Kolaborasi dalam Persalinan Alami.....	69
J. Penutup.....	71
Referensi	73
BAB VI EDUKASI PASCA PERSALINAN UNTUK PEMULIHAN IBU DAN BAYI.....	76
A. Pendahuluan.....	76
B. Pemulihan Fisik Ibu Pasca-persalinan	77
C. Asuhan Psikologis Ibu Pasca-persalinan.....	79
D. Edukasi Menyusui	80
E. Perawatan Bayi Baru Lahir	82
F. Edukasi Pencegahan Infeksi Pasca-persalinan	83
G. Pola Istirahat dan Aktivitas Pasca-persalinan.....	85
H. Nutrisi Pasca-persalinan	86
I. Edukasi tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pasca-persalinan	88
J. Kolaborasi dan Dukungan Sosial	89
K. Monitoring dan Evaluasi Edukasi Pasca-persalinan	91
L. Penutup.....	93
Referensi	95
Profil Penulis	98
Sinopsis Buku	101

BAB I

EDUKASI IBU HAMIL

TENTANG MANFAAT PERSALINAN ALAMI

A. Pendahuluan

Pada masa-masa akhir kehamilan, seorang ibu hamil tentu mempertimbangkan mengenai metode melahirkan yang paling tepat sesuai kondisi tubuh nya. Persalinan normal atau alami biasanya menjadi pilihan pertama bila tidak ditemukan risiko-risiko yang mungkin menyulitkan persalinan, bagi ibu hamil yang belum pernah melahirkan pasti akan merasa takut dan cemas dalam menghadapi persalinannya.

Peran keluarga atau orang terdekat sangat dibutuhkan untuk berjalan baiknya suatu proses persalinan. Sementara itu peran bidan dalam memberikan asuhan selama hamil dan persalinan sangat mendukung proses persalinan yang awalnya fisiologis tetap berjalan dengan normal atau tidak terjadi komplikasi yang dapat mengancam jiwa atau kematian ibu karena proses persalinan dengan cara memberikan edukasi atau Pendidikan Kesehatan pada ibu dalam menghadapi persalinan alami atau persalinan normal

B. Konsep Edukasi Kesehatan

Edukasi merupakan bagian dari komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam pendidikan kesehatan secara sistematis. Secara umum, edukasi adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia, kemudian mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan lebih baik. Menurut Notoadmodjo (2017), edukasi atau pendidikan kesehatan merupakan aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional edukasi Kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan Kesehatan mereka sendiri

Tujuan Edukasi kesehatan memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Tercapainya perbaikan perilaku pada sasaran dalam memelihara dan membina perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

2. Perilaku sehat yang sesuai dengan konsep hidup sehat terbentuk pada individu, keluarga, dan masyarakat secara fisik, sosial, maupun mental sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian.
3. Menurut WHO, edukasi kesehatan bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan (Efendi & Makkhfudli, 2009).

Jadi tujuan edukasi kesehatan adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya kesehatan agar tercapainya perilaku menuju sehat yang optimal sehingga derajat kesehatan mental, sosial, dan fisik dapat meningkat dan terwujudnya masyarakat produktif secara ekonomi maupun sosial.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memberikan edukasi kesehatan agar sasaran tercapai (Maulana, 2014):

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap cara pandang seseorang mengenai informasi baru. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka menerima informasi baru akan semakin mudah.

2. Tingkat Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, juga semakin mudah pula seseorang dalam menerima informasi.

3. Adat Istiadat

Pada umumnya masyarakat masih menganggap bahwa menjunjung tinggi adat istiadat adalah suatu hal yang utama dan adat istiadat tidak bisa dilanggar oleh apapun.

4. Kepercayaan Masyarakat

Informasi yang diberikan oleh orang yang berpengaruh, akan lebih diperhatikan masyarakat, karena masyarakat sudah memiliki rasa percaya terhadap informan tersebut.

5. Ketersediaan Waktu di Masyarakat

Menyampaikan informasi juga harus memperhatikan waktu. Untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam melakukan penyuluhan, waktu harus disesuaikan dengan aktifitas masyarakat (Maulana, 2014).

C. Konsep Persalinan

Persalinan normal atau alami adalah sebuah proses pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar uterus melalui vagina secara spontan { Manuaba, 1998; Wiknjosastro dkk, 2005}. Persalinan dan kelahiran normal adalah

proses pengeluaran janinyang terjadi pada kehamilan cukup bulan {37-42 minggu}, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin {Saifuddin, 2007}.

Faktor yang Mempengaruhi Persalinan (Power, Passeur, Passenger). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan antara lain:

1. Power

His adalah salah satu kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah. Pada presentasi kepala, bila his sudah cukup kuat, kepala akan turun dan mulai masuk ke dalam rongga panggul (Wiknjosastro dkk, 2005). Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunteer secara bersamaan (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 2004).

2. Passenger

Malpresentasi atau malformasi janin dapat mempengaruhi persalinan normal (Taber, 1994). Pada faktor passenger, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. Karena plasenta juga harus melalui jalan lahir, maka ia dianggap sebagai penumpang yang menyertai janin (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 2004).

3. Passage away

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina). Meskipun jaringan lunak khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relatif kaku (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 2004).

4. Position

Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Posisi tegak memberi sejumlah keuntungan. Mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berdiri, berjalan, duduk dan jongkok (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 2004).

5. Psychologic Respons

Proses persalinan adalah saat yang menegangkan dan mencemaskan bagi wanita dan keluarganya. Rasa takut, tegang dan cemas mungkin mengakibatkan proses kelahiran berlangsung lambat. Pada kebanyakan wanita, persalinan dimulai saat terjadi kontraksi uterus pertama dan dilanjutkan dengan kerja selama

jam-jam dilatasi dan melahirkan kemudian berakhir ketika wanita dan keluarganya memulai proses ikatan

Menurut survei SKI 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas ibu di Indonesia lebih memilih melahirkan secara normal ketimbang metode lainnya. Survei tersebut menunjukkan tiga kategori utama metode persalinan, yaitu persalinan normal dengan persentase 73,2%, persalinan caesar sebesar 25,9%, dan metode persalinan lainnya yang hanya mencakup 1%. Persalinan normal mendominasi pilihan ibu di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa nyaris tiga dari empat ibu hamil di Indonesia lebih memilih melahirkan secara alami. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan ini adalah keinginan untuk mengalami persalinan alami, menghindari operasi dan komplikasi yang mungkin timbul dari prosedur bedah, serta pemulihan yang lebih cepat dan risiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi caesar.

Hasil survei ini mencerminkan tren dan preferensi dalam metode persalinan di Indonesia. Beberapa implikasi yang dapat diambil dari data ini adalah tingginya persentase persalinan normal yang menunjukkan perlunya edukasi dan dukungan bagi ibu hamil mengenai manfaat dan risiko dari berbagai metode persalinan. Hal ini akan membantu ibu membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu edukasi yang diperlukan ibu hamil adalah edukasi tentang manfaat persiapan persalinan alami yang diberikan pada ibu hamil trimester ke tiga.

D. Edukasi Pada Ibu Hamil Tentang Persalinan Alami

Edukasi tentang persalinan alami diberikan saat ibu hamil saat menjalani antenatal care terutama pada ibu primigravida, dan edukasi tentang persalinan alami ini juga penting diberikan kepada wanita usia subur, pasangan suami istri yang berencana memiliki anak. termasuk penjelasan bahwa persalinan normal merupakan proses fisiologis.

Edukasi Tanda-Tanda Persalinan

Saat antenatal care, ibu hamil dan keluarga perlu diberikan edukasi sebagai berikut:

1. Tanda-tanda pasti persalinan, seperti kontraksi uterus yang semakin kuat dan sering, pecahnya air ketuban, dan adanya lendir darah dari jalan lahir
2. Pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan selama proses persalinan normal, seperti pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, denyut jantung janin, pemeriksaan dalam secara berkala
3. Komplikasi yang mungkin terjadi kepada ibu dan janin selama proses melahirkan, termasuk kondisi di mana sectio caesarea lebih dianjurkan.

4. Ibu hamil dan keluarga tidak perlu panik jika menghadapi tanda-tanda pasti persalinan. Ibu hamil dapat langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dan persiapan proses persalinan normal. Perlu diingatkan agar ibu menjaga kebersihan saat akan melahirkan, sehingga dapat mengurangi risiko infeksi.
5. Keluarga dan suami perlu diberitahu juga mengenai pentingnya dukungan emosional selama proses persalinan.

E. Manfaat Persalinan Alami

Berikut ini adalah beberapa manfaat persalinan alami yang perlu ibu hamil ketahui:

1. Waktu pemulihan lebih singkat

Banyak Ibu hamil ingin melahirkan normal karena waktu pemulihannya yang lebih cepat. Hal tersebut memang benar. Ibu yang melahirkan normal tanpa komplikasi pascapersalinan umumnya hanya membutuhkan lama perawatan sekitar 1–2 hari di klinik bersalin atau rumah sakit.

2. Ikatan ibu dan bayi terjalin

Metode persalinan apa pun tetap bisa membuat ikatan atau bonding antara ibu dan bayi. Namun, saat melahirkan normal, jika tidak ada komplikasi pascapersalinan dan bayi sehat, maka ibu bisa langsung melakukan metode skin to skin dan menjalani inisiasi menyusui dini (IMD). Melakukan hal-hal tersebut diyakini bisa meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dan bayi.

3. Ibu lebih cepat siap untuk merawat bayi

Melahirkan normal bisa membuat ibu pulih lebih cepat. Beberapa ibu bahkan sudah bisa beraktivitas ringan beberapa jam setelah melahirkan normal. Nah, karena lebih cepatnya proses pemulihan ini, ibu yang melahirkan normal dianggap bisa lebih cepat beradaptasi untuk merawat bayi.

Namun, siap tidaknya untuk merawat bayi tidak bisa disamakan pada tiap ibu yang baru melahirkan, ya. Setiap ibu memiliki kondisi fisik dan psikis yang berbeda-beda, jadi kesiapannya dalam merawat bayi tidak boleh dipaksakan.

4. Tidak ada batasan untuk melahirkan kembali

Ketika ibu melahirkan normal, selama belum mengalami menopause dan tidak ada masalah kesehatan yang bisa memburuk jika ibu hamil dan melahirkan kembali, tidak ada batasan untuk hamil dan melahirkan kembali. Namun, tetap berikan jarak antar kehamilan, misalnya rencanakan kehamilan setelah 2–3 tahun melahirkan anak pertama, begitu seterusnya. Sementara itu operasi

caesar memiliki batasan pengulangan, umumnya sebanyak 3 kali. Hal ini karena adanya risiko kesehatan yang bisa terjadi akibat proses pembedahan. Selain itu, biasanya jika sudah menjalani operasi caesar di kehamilan pertama, ada kemungkinan pilihan persalinan yang dilakukan di kehamilan kedua dan selanjutnya pun sama.

5. Bayi dianggap memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik

Beberapa penelitian menyatakan bahwa bayi yang lahir dari proses persalinan normal akan lebih dahulu terpapar flora normal yang ada di sepanjang jalan lahir termasuk vagina ibu. Hal ini diyakini bisa meningkatkan kerja sistem kekebalan tubuhnya. Selain itu, bayi yang lahir dengan metode persalinan normal, sistem pernapasannya juga bisa bekerja lebih optimal karena adanya usaha napas yang sudah dilakukan sejak proses kelahirannya.

Walaupun memiliki sejumlah manfaat, pada beberapa kondisi, misalnya panggul sempit atau placenta menutupi jalan lahir atau faktor resiko lainnya, melahirkan normal bukan menjadi pilihan bahkan tidak disarankan karena justru akan membahayakan ibu dan bayi. Agar kondisi kesehatan ibu hamil dan janin tetap terpantau, harus melakukan antenatal care secara rutin ke dokter dan bidan untuk menentukan metode persalinan yang sesuai dengan kondisi ibu.

F. Peran Bidan Dalam Memberikan Edukasi Pada Ibu Hamil Tentang Persalinan Alami

Peran bidan dalam memberikan edukasi ibu hamil adalah memberikan edukasi tentang persalinan alami dengan memberikan informasi, dorongan, dan dukungan emosional. Bidan juga membantu ibu hamil merencanakan persalinan yang aman dan sehat.

Penjelasan

1. Bidan memberikan informasi dan edukasi tentang persalinan alami.
2. Bidan membantu ibu hamil merencanakan persalinan yang aman dan sehat.
3. Bidan membantu ibu hamil mempersiapkan diri menghadapi komplikasi dan tanda bahaya.
4. Bidan memberikan dukungan emosional kepada ibu hamil.
5. Bidan memantau kemajuan persalinan dan memberikan saran strategi.
6. Bidan memantau detak jantung bayi dan tanda-tanda lainnya.
7. Bidan merujuk ibu hamil ke dokter kandungan jika terjadi komplikasi.
8. Bidan memberikan bantuan medis lainnya jika diperlukan.

Bidan adalah profesional kesehatan yang membantu ibu hamil selama kehamilan, persalinan, dan setelah kelahiran bayi. Bidan dapat membantu persalinan di rumah bidan, fasilitas kesehatan, atau di rumah pribadi ibu hamil.

Manfaat Edukasi Pada Ibu Hamil

Edukasi ibu hamil memberikan banyak manfaat, di antaranya:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, termasuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan.
2. Meningkatkan kesehatan bayi, termasuk mengurangi risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah.
3. Mempersiapkan ibu untuk mengasuh bayi yang baru lahir, termasuk menyusui dan memenuhi kebutuhan dasar bayinya.
4. Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada ibu selama masa kehamilan dan persalinan.

G. Penutup

Edukasi Kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktik baik individu, kelompok atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Edukasi tentang persalinan alami diberikan saat ibu hamil saat menjalani antenatal care terutama pada ibu primigravida, dan edukasi tentang persalinan alami ini juga penting diberikan kepada wanita usia subur, pasangan suami istri yang berencana memiliki anak. termasuk penjelasan bahwa persalinan normal merupakan proses fisiologis. Manfaat persalinan alami yang perlu ibu hamil ketahui adalah Waktu pemulihan lebih singkat, Ikatan ibu dan bayi terjalin, Ibu lebih cepat siap untuk merawat bayi, Tidak ada batasan untuk melahirkan Kembali, Bayi dianggap memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik.

Peran bidan dalam edukasi ibu hamil tentang persalinan alami adalah dengan memberikan informasi, dorongan, dan dukungan emosional pada ibu hamil. Bidan juga membantu ibu hamil merencanakan persalinan yang aman dan sehat.

Referensi

- Aprilita, dkk. 2024. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta
- Azwar, Azrul. 2002. *Asuhan Persalinan Normal*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Bobak, Lowdermilk, Jensen (Alih bahasa: Wijayarini, Anugerah), *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*, edisi 4. EGC, Jakarta; 2005
- Chapman, Vicky, *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*. EGC: Jakarta; 2006
- JNPK-KR, *Asuhan Persalinan Normal*. JNPK-KR Depkes RI : Jakarta; 2008
- Leksana, Ery. 2011. *CDK 185/Vol.38 no.4/Mei-Juni 2011: Mengatasi Nyeri Persalinan*. SMF/Bagian Anestesi dan Terapi Intensif RSUP dr. Kariadi/FK Undip, Semarang.
- Mander, Rosemary, *Nyeri Persalinan*. EGC : Jakarta ; 2004
- Manuaba IAC, Manuaba IBGF, Manuaba IBG. Ilmu Kebidanan, *Penyakit Kandungan, dan KB*. Jakarta: EGC; 2005
- Machmudah Machmudah. *Gangguan Psikologis pada Ibu Postpartum; Postpartum Blues*. Jurnal Keperawatan Maternitas. 2015;3(2):118-25.
- Maulani Nurul, Zainal Erli, *Modul Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir* Edisi 2, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Saptabakti
- Medforth J, Battersby S, Evans M, Marsh B, Walker A. *Kebidanan Oxford dari Bidan untuk Bidan*. Jakarta: EGC; 2010.
- Nandia Dwi, *Anggorowati. Pendidikan Kesehatan Pada Ibu Nifas*, Yogyakarta: Nuha Medika; 2020
- Notoatmodjo S. 2017. *Promosi Kesehatan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rukiyah, Yeyen A. *Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta: CV. Trans Info Media; 2014
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: YBP-SP; 2006
- Utami Istri, Fitriahadi Enny, *Buku Ajar Asuhan Persalinan & Manajemen Nyeri Persalinan*, Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta; 2019
- Varney Helen, *Asuhan Kebidanan Varney*. Jakarta, EGC ; 2004
- Yulizar dkk, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan, Siduwardjo*. Indomedia Pustaka Siduwardjo; 2019

Glosarium

- BPS : Badan Pusat Statistik
KIE : Komunikasi Informasi Edukasi
IMD : Inisiasi Menyusui Dini
SKI : Survei Kesehatan Indonesia
WHO : World Health Organization

BAB II

STRATEGI PENAGANAN NYERI NON-FARMAKOLOGI PERSALINAN

A. Pendahuluan

Persalinan adalah salah satu peristiwa paling monumental dalam kehidupan seorang wanita. Meskipun merupakan proses fisiologis yang alami, persalinan sering kali disertai dengan nyeri yang intens. Nyeri ini terjadi akibat kontraksi uterus, peregangan jaringan jalan lahir, dan tekanan pada struktur di sekitar panggul. Intensitas nyeri persalinan dapat bervariasi pada setiap individu, tergantung pada faktor fisiologis, psikologis, serta dukungan sosial yang diterima ibu selama proses persalinan. Persalinan dapat berjalan normal didukung oleh 4 faktor penting ("4 P") yaitu *Powers* (kekuatan kontraksi), *Passage* (bagian panggul dan jalan lahir), *Passenger* (janin) dan *Psyche* (respon wanita)(1). Persalinan terasa sangat nyeri yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos uterus.(2)

Dalam dunia medis, terdapat berbagai metode untuk menangani nyeri persalinan, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Pendekatan farmakologis, seperti penggunaan analgesik dan anestesi, memang efektif dalam mengurangi nyeri, tetapi tidak selalu menjadi pilihan utama bagi semua ibu. Beberapa alasan, seperti efek samping obat, keterbatasan akses terhadap fasilitas medis yang memadai, serta keinginan ibu untuk menjalani persalinan secara alami, membuat metode non-farmakologis menjadi alternatif yang layak dan penting untuk dipertimbangkan.

Strategi penanganan nyeri non-farmakologis melibatkan berbagai teknik yang bertujuan untuk membantu ibu mengelola nyeri secara lebih alami dan nyaman. Metode ini meliputi teknik pernapasan, relaksasi, terapi posisi, stimulasi sensorik seperti pijatan dan kompres hangat, terapi air, hingga metode psikologis seperti dukungan emosional dari pendamping persalinan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri, tetapi juga membantu meningkatkan rasa kontrol, mengurangi kecemasan, dan memperkuat ikatan antara ibu, pendamping, dan tenaga kesehatan. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa Teknik deep back massage efektif dilakukan pada ibu bersalin memberikan pengurangan rasa nyeri persalinan.(3) Berbagai teknik non farmakologi dilakukan sesuai dengan kesepakatan pasien diantaranya tehnik pernapasan, distraksi, *aromatherapy*, penggunaan herbal, hidroterapi, *hypnobirthing*, *self massage*,

TENS, dan akupunktur. Hipnoterapi efektif untuk beberapa pasien dengan nyeri kronis(4) telah terbukti mengurangi rasa nyeri dan kecemasan(5)(6). Ibu bersalin yang menerima perlakuan akupunktur dan hipnoterapi dapat menghilangkan nyeri persalinan(7)

Buku ini disusun untuk memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai strategi penanganan nyeri non-farmakologis selama persalinan. Setiap bab dalam buku ini akan mengupas secara mendalam teori di balik setiap metode, cara penerapannya di lapangan, serta bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya. Sasaran utama buku ini adalah tenaga kesehatan, seperti bidan dan perawat, yang terlibat dalam proses persalinan, serta ibu hamil dan keluarganya yang ingin memahami lebih jauh tentang pilihan manajemen nyeri yang lebih alami.

Harapannya, dengan memahami dan menerapkan strategi penanganan nyeri non-farmakologis, pengalaman persalinan dapat menjadi lebih positif, nyaman, dan bermakna. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan persalinan di berbagai fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, klinik, maupun di lingkungan komunitas.

Dengan demikian, mari kita telusuri bersama berbagai pendekatan inovatif dan berbasis bukti dalam mengelola nyeri persalinan, guna menciptakan pengalaman melahirkan yang lebih baik dan lebih manusiawi bagi setiap ibu.

B. Nyeri Persalinan

1. Definisi Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan adalah sensasi tidak nyaman yang dialami ibu selama proses melahirkan, yang terjadi akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, peregangan jaringan jalan lahir, serta tekanan pada struktur di sekitar panggul. Nyeri ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya (8)

Secara medis, nyeri persalinan dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- a. Nyeri Viseral: Nyeri yang dominan selama fase laten dan aktif persalinan, disebabkan oleh kontraksi uterus serta peregangan segmen bawah rahim dan serviks. Nyeri ini sering dirasakan di daerah perut, punggung bawah, dan paha (2)
- b. Nyeri Somatik: Muncul pada fase ekspulsi akibat distensi perineum, vagina, serta tekanan kepala janin terhadap jaringan di sekitar panggul. Nyeri ini lebih tajam, terlokalisasi, dan sering digambarkan sebagai sensasi terbakar atau robek (9)

2. Mekanisme Nyeri Persalinan

Melzack & Wall mengusulkan bahwa nyeri persalinan dapat dijelaskan melalui teori gerbang nyeri (*gate control theory*), di mana rangsangan tertentu seperti pijatan dan teknik pernapasan dapat menghambat transmisi nyeri menuju sistem saraf pusat, sehingga mengurangi persepsi nyeri.(10)

3. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan

- a. Faktor Fisiologis: Intensitas kontraksi, ukuran janin, serta kondisi jalan lahir (2)
- b. Faktor Psikologis: Tingkat kecemasan dan ketakutan ibu dapat meningkatkan persepsi nyeri karena adanya pelepasan hormon stres seperti katekolamin (8)
- c. Faktor Lingkungan dan Dukungan Sosial: Kehadiran pendamping persalinan dan lingkungan yang mendukung dapat membantu ibu dalam mengelola nyeri lebih baik (11)

C. Konsep Dasar Nyeri Persalinan

Pada kehamilan dan persalinan rasa nyeri diartikan sebagai sebuah “sinyal” sebagai pemberitahuan kepada ibu bahwa dirinya telah memasuki tahapan proses persalinan. Nyeri sendiri merupakan bagian integral dari proses persalinan(12).

1. Etiologi Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan tidak diketahui secara pasti, tetapi dapat diduga dari beberapa kemungkinan diantaranya (2):

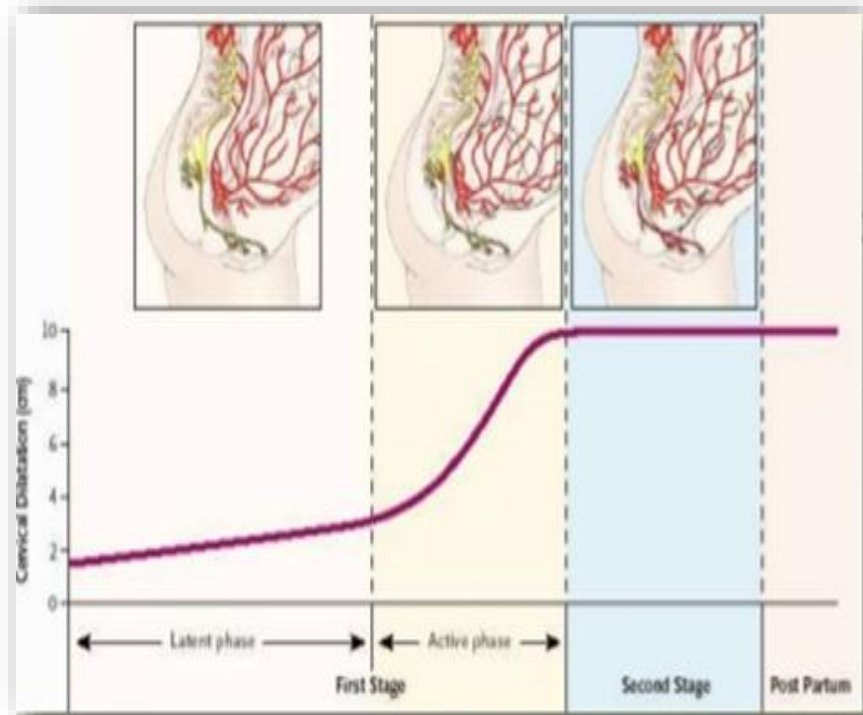
- a. Hipoksia pada miometrium yang berkontraksi (seperti pada angina pectoris)
- b. Penekanan ganglia syaraf di serviks dan uterus bagian bawah oleh berkas berkas otot yang saling bertautan
- c. Peregangan serviks sewaktu dilatasi
- d. Peregangan peritonium yang terletak diatas fundus

Nyeri persalinan sebagai akibat dari kontraksi dari myometrium yang fisiologis dengan intensitas yang berbeda-beda pada tiap individu(13). Rasa nyeri pada persalinan adalah akibat dari adanya kontraksi (pemendekan) otot rahim. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut dan menjalar kearah paha. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim (serviks). Dengan adanya pembukaan serviks ini maka akan terjadi persalinan(14).

Nyeri kontraksi uterus yang dapat mengakibatkan peningkatan aktifitas sistem saraf simpatis, perubahan tekanan darah, denyut jantung, pernafasan dengan warna kulit dan apabila tidak segera di atasi maka akan meningkatkan rasa khawatir, tegang, takut dan stress(15). Intensitas nyeri sebanding dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang terjadi. Nyeri bertambah ketika mulut rahim dalam dilatasi penuh akibat tekanan bayi terhadap struktur panggul diikuti

regangan dan perobekan jalan lahir(13). Nyeri terjadi disebabkan oleh stimulus yang hampir dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Oleh karena itu, sensasi nyeri dapat dibedakan dengan sensasi lainnya, meskipun emosi seperti rasa takut dan ansietas dialami bersamaan sehingga memengaruhi persepsi seseorang terhadap nyeri. Akibat nyeri persalinan dapat terjadi penurunan motilitas lambung dan penurunan suplai darah kulit yang menyebabkan berkeringat. Oleh karena itu, stimulus yang menimbulkan rasa nyeri akan mengakibatkan terjadinya insiden sensorik(16).

Nyeri juga dapat didefinisikan sebagai suatu sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus spesifik bersifat subyektif dan berbeda antara masing-masing individu karena dipengaruhi oleh faktor psikososial, kultur dan endorphine seseorang, sehingga orang tersebut lebih merasakan nyeri(17). Nyeri merupakan tanda peringatan bahwa terjadi kerusakan jaringan, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pemberian asuhan kebidanan(13). Pada kehamilan dan persalinan rasa nyeri diartikan sebuah "sinyal" sebagai pemberitahuan kepada ibu bahwa dirinya telah memasuki tahapan proses persalinan. Nyeri sendiri merupakan bagian integral dari proses persalinan(12). Nyeri persalinan sebagai akibat dari kontraksi dari myometrium yang fisiologis dengan intensitas yang berbeda-beda pada tiap individu(13). Rasa nyeri pada persalinan adalah akibat dari adanya kontraksi (pemendekan) otot rahim. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut dan menjalar kearah paha. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim (serviks). Dengan adanya pembukaan serviks ini maka akan terjadi persalinan(14). Nyeri pada persalinan dalam hal ini adalah nyeri kontraksi uterus yang dapat mengakibatkan peningkatan aktifitas sistem saraf simpatis, perubahan tekanan darah, denyut jantung, pernafasan dengan warna kulit dan apabila tidak segera di atasi maka akan meningkatkan rasa khawatir, tegang, takut dan stress(15). Intensitas nyeri sebanding dengan kekuatan kontraksi dan tekanan yang terjadi. Nyeri bertambah ketika mulut rahim dalam dilatasi penuh akibat tekanan bayi terhadap struktur panggul diikuti regangan dan perobekan jalan lahir(13).



Gambar 2.1 Nyeri Kala persalinan(2)

2. Faktor yang Memengaruhi Nyeri Persalinan

Rasa nyeri yang dialami selama persalinan bersifat unik pada setiap ibu. rasa nyeri persalinan muncul karena(14):

a. Kontraksi otot rahim

Kontraksi rahim menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia rahim akibat kontraksi arteri miometrium. Karena rahim merupakan organ internal maka nyeri yang timbul disebut nyeri visceral. Nyeri visceral juga dapat dirasakan pada organ lain yang bukan merupakan asalnya nyeri alih (*referred pain*). Pada persalinan nyeri alih dapat dirasakan pada punggung bagian bawah dan sacrum. Biasanya ibu hanya mengalami rasa nyeri ini hanya selama kontraksi dan bebas dari rasa nyeri pada interval antar kontraksi.

b. Regangan otot dasar panggul

Jenis nyeri ini timbul pada saat mendekati kala II. Tidak seperti nyeri visceral, nyeri ini terlokalisir di daerah vagina, rectum, perineum dan sekitar anus. Nyeri jenis ini disebut nyeri somatik yang disebabkan peregangan struktur jalan lahir bagian bawah akibat penurunan bagian terbawah janin.

c. Episiotomi

Pada peristiwa episiotomi, nyeri dirasakan apabila ada tindakan episiotomi, tindakan ini dilakukan sebelum jalan lahir mengalami laserasi maupun ruptur pada jalan lahir.

d. Kondisi psikologis

Nyeri dan rasa sakit yang berlebihan akan menimbulkan rasa cemas. Takut, cemas dan tegang memicu produksi hormon prostaglandin sehingga timbul stress. Kondisi stress dapat memengaruhi kemampuan tubuh menahan rasa nyeri.

Selain faktor yang telah disebutkan nyeri persalinan disebabkan pula oleh rasa tidak nyaman dan nyeri dalam persalinan adalah unik. Oleh karenanya, pengalaman persalinan mempunyai suatu kekuatan tinggi terhadap pemilihan metoda yang tepat dalam menaggulangi nyeri persalinan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kecemasan berkurang jika seseorang mengetahui kapan peristiwa yang menimbulkan nyeri itu akan terjadi dan berapa lama rasa nyeri itu berlangsung. Selain itu, meskipun rasa nyeri bisa meningkat intensitasnya, ibu tidak biasanya dalam ketidak nyamanan yang menetap. Antara kontraksi, terdapat periode-periode rasa nyaman relatif bahkan selama fase kontraksi persalinan akhir(15).

Faktor psikologis memainkan peran kunci dalam persalinan dan perkembangan setiap gangguan nyeri maka diperlukan komunikasi yang efektif antara akademisi, dokter, peneliti, dan pasien(18).

D. Prinsip Dasar Penanganan Nyeri Persalinan dengan Non Farmakologi

Penanganan nyeri non-farmakologis dalam persalinan berfokus pada metode alami dan intervensi psikologis-fisik untuk membantu ibu mengelola nyeri tanpa menggunakan obat-obatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, mengurangi kecemasan, dan memberikan ibu rasa kontrol terhadap proses persalinan.

1. Mengoptimalkan Mekanisme Fisiologis Nyeri

Nyeri persalinan sebagian besar bersumber dari kontraksi uterus dan peregangan jaringan jalan lahir. Prinsip utama penanganan non-farmakologis adalah memanfaatkan respons tubuh alami dalam mengurangi nyeri, seperti: Stimulasi sensorik positif untuk menghambat transmisi sinyal nyeri ke otak. Peningkatan pelepasan endorfin, yaitu hormon alami yang berperan sebagai analgesik tubuh.

2. Memberikan Rasa Kontrol kepada Ibu

Ketika ibu merasa memiliki kendali atas persalinannya, kecemasan dan ketakutan dapat berkurang, sehingga nyeri lebih mudah ditoleransi. Strategi yang

digunakan meliputi: Pendidikan prenatal tentang proses persalinan dan teknik manajemen nyeri. Melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan terkait metode yang akan digunakan. Menggunakan teknik visualisasi dan afirmasi positif untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu.

3. Mengurangi Ketegangan Otot dan Meningkatkan Relaksasi

Ketegangan otot akibat stres atau kecemasan dapat meningkatkan intensitas nyeri. Prinsip ini diterapkan melalui teknik seperti: Pernapasan terkontrol untuk membantu ibu tetap rileks selama kontraksi. Teknik relaksasi otot progresif, di mana ibu diajarkan untuk mengendurkan otot-otot yang tidak diperlukan saat persalinan. Aromaterapi dan musik terapi untuk menciptakan suasana yang nyaman.

4. Menggunakan Stimulasi Sensorik untuk Mengalihkan Nyeri

Berdasarkan Gate Control Theory, rangsangan sensorik tertentu dapat mengurangi transmisi sinyal nyeri ke otak. Teknik yang digunakan meliputi: Pijat dan akupresur, yang merangsang saraf untuk menghambat rasa nyeri. Kompres hangat atau dingin, yang membantu mengendurkan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Hidroterapi (berendam dalam air hangat), yang dapat mengurangi tekanan pada sendi dan meredakan nyeri.

5. Mengoptimalkan Posisi dan Mobilisasi Ibu

Posisi tubuh dapat memengaruhi kenyamanan ibu serta efisiensi kontraksi. Prinsip ini diterapkan melalui: Gerakan aktif dan perubahan posisi, seperti jongkok, berdiri, atau menggunakan bola persalinan. Dukungan gravitasi, seperti berdiri atau duduk tegak, untuk membantu bayi turun ke jalan lahir dengan lebih mudah.

6. Dukungan Emosional dan Psikologis

Kehadiran pendamping persalinan (suami, keluarga, atau tenaga kesehatan) sangat berpengaruh dalam mengurangi persepsi nyeri. Prinsipnya adalah: Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibu. Memberikan sentuhan lembut dan komunikasi positif untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu. Menerapkan teknik Hypnobirthing, yaitu metode relaksasi mendalam dengan sugesti positif untuk mengurangi kecemasan.

Hipnoterapi

Hipnosis berasal dari kata *hypnos* (bahasa Yunani) adalah nama Dewa Tidur. Arti tidur di sini adalah pikiran yang tenang, sedangkan *birthing* (bahasa Inggris) berarti proses persalinan(19). hipnoterapi diartikan sebagai pemberian sugesti kepada ibu dalam kondisi *trance* / hipnotis, sugesti yang diberikan berisi anjuran, ajakan, perintah yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu(20). Hipnosis sudah dipergunakan sejak zaman dahulu, hanya saja saat ini hipnosis lebih sering dikaitkan dengan magic, supranatural bahkan mistik. Saat ini, hipnosis dapat dijelaskan secara ilmiah dan terprogram sehingga untuk kepentingan terapi, hasil sebelum dan sesudah terapi hipnosis bisa dilihat dan dibandingkan. Berdasarkan teori Dr. Grantley Dick-Read (seorang ahli kebidanan Inggris yang hidup di tahun 1890-1959), yang dikenal sebagai bapak kelahiran alami. Hipnoterapi merupakan salah satu teknik otohipnosis (*self Hypnosis*) yaitu upaya alami menanamkan niat positif/sugesti ke jiwa/ pikiran bawah sadar dalam menjalani masa kehamilan dan persiapan persalinan. Dengan demikian, setiap ibu hamil dapat menikmati indahnya kehamilan dan lancarnya proses persalinan(19). Metode *hypnobirthing* didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perempuan memiliki potensi untuk menjalani proses melahirkan secara alami, tenang dan nyaman (tanpa rasa sakit). Program ini mengajarkan ibu hamil untuk menyatu dengan gerak dan ritme tubuh yang alami saat menjalani proses melahirkan, membiarkan tubuh dan pikiran untuk bekerja serta meyakini bahwa tubuh mampu berfungsi sebagaimana seharusnya sehingga rasa sakit menghilang(19). *Hypnobirthing* juga mampu untuk menetralkan dan memprogram ulang (*reprogramming*) rekaman negatif dalam pikiran bawah sadar dengan program positif. Dengan demikian, rekaman yang terpatrit dalam pikiran bawah sadar bahwa persalinan itu menakutkan dan menyakitkan, bisa terhapus. Berganti dengan keyakinan bahwa persalinan berlangsung mudah, lancar dan tanpa rasa sakit (nyaman)(19).

Hypnobirthing sebagai penggunaan Hipnosis untuk membuat suatu kepatuhan dan kondisi seperti tidur dalam tetapi kondisi-kondisi dengan komponen psikologis yang sangat besar(12). Hipnosis dapat membantu mengubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. Selama persalinan Hipnosis dianggap memungkinkan wanita menginterpretasikan ulang nyeri kontraksi uterus sebagai sensasi lemah. Dengan jalan ini "gerbang" pada substansi gelatinosa dicegah oleh impuls yang turun untuk membuka dan menyebabkan persepsi nyeri. Seiring dengan relaksasi, respon stress otonom berkurang dan hormon stres yang biasanya meningkatkan persepsi nyeri

dalam persalinan tidak disekresi(12). Namun dalam memberikan terapi hipnosis membutuhkan ahli hipnotis yang terlatih, 10-20% wanita tidak rentan terhadap hipnosis, dan efek sampingnya termasuk keadaan kecemasan(21).

Bukti dari 85 studi terkontrol memberikan bukti yang meyakinkan bahwa hipnosis menghasilkan analgesia substantif, dengan penghilang rasa sakit yang optimal diberikan ketika sugesti analgesik langsung digunakan pada populasi target individu yang sugestibilitasnya tinggi. Secara keseluruhan, temuan bahwa induksi hipnosis menghasilkan penurunan nyeri yang diinduksi secara eksperimental menunjukkan bahwa hipnosis dapat mewakili alternatif yang berpotensi efektif dan aman atau tambahan untuk intervensi farmakologis untuk nyeri akut(22).

E. Teknik Relaksasi Dan Pernapasan

Teknik relaksasi dan pernapasan merupakan metode non-farmakologis yang efektif dalam mengatasi nyeri selama persalinan. Metode ini membantu ibu hamil mengelola nyeri dengan cara menenangkan pikiran, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan kontrol diri selama proses persalinan.

1. Teknik Relaksasi

Relaksasi adalah proses menenangkan pikiran dan tubuh untuk mencapai keadaan rileks, yang dapat membantu mengurangi persepsi nyeri. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah relaksasi napas dalam.

a. Relaksasi Napas Dalam: Ibu hamil diajarkan untuk menarik napas dalam melalui hidung, mengembungkan perut, kemudian menghembuskan napas perlahan melalui mulut sambil mengempiskan perut. Teknik ini dapat meningkatkan oksigenasi, memberikan rasa tenang, dan mengurangi ketegangan otot, sehingga membantu menurunkan intensitas nyeri selama kontraksi. (23)

2. Teknik Pernapasan

Pernapasan teratur dan terkendali dapat membantu ibu hamil mengalihkan perhatian dari nyeri dan memberikan ritme yang menenangkan selama persalinan. Beberapa teknik pernapasan yang umum digunakan meliputi:

a. Pernapasan Lambat: Menarik napas perlahan melalui hidung hingga hitungan keempat, kemudian menghembuskan napas melalui mulut hingga hitungan keempat. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi persepsi nyeri.

- b. Pernapasan Ringan: Mengambil napas pendek dan cepat melalui mulut, biasanya digunakan saat kontraksi mencapai puncaknya. Teknik ini membantu ibu tetap fokus dan mengalihkan perhatian dari nyeri intens.
- 3. Efektivitas Teknik Relaksasi dan Pernapasan.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik relaksasi dan pernapasan dapat secara signifikan mengurangi intensitas nyeri selama persalinan. Sebuah studi menemukan bahwa rata-rata nyeri persalinan sebelum diberikan terapi relaksasi napas dalam adalah 6,7, dan menurun menjadi 4,3 setelah penerapan teknik tersebut. (24)

Selain itu, teknik pernapasan yang efektif dapat meningkatkan oksigenasi darah, memberikan rasa tenang, mengurangi detak jantung, dan menurunkan tekanan darah, yang semuanya berkontribusi pada penurunan nyeri selama persalinan.(25)

F. Terapi Fisik untuk mengurangi nyeri

1. Akupresur

Akupresur berasal dari kata *accus* dan *pressure*, yang berarti jarum dan menekan. Akupresur merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan rangsangan (stimulasi) titik akupunktur dengan teknik penekanan atau teknik mekanik. Penekanan dilakukan sebagai pengganti penusukan jarum yang dilakukan pada akupunktur dengan tujuan untuk melancarkan aliran energi vital (qi) pada seluruh tubuh(26).

Akupresur disebut juga dengan terapi totok/tusuk jari adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu atau acupoint pada tubuh. Akupresur juga diartikan sebagai menekan titik-titik penyembuhan menggunakan jari secara bertahap yang merangsang kemampuan tubuh untuk penyembuhan diri secara alami(27). Penelitian terdahulu membuktikan bahwa ada pengaruh pemberian teknik akupresur terhadap nyeri persalinan kala I fase aktif(28).

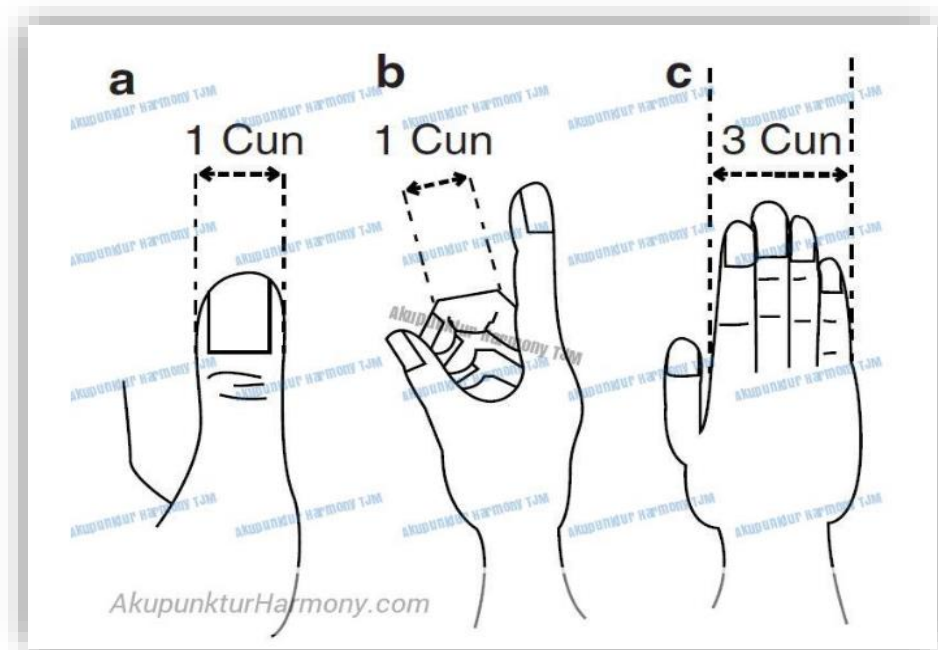
Titik akupresur sama dengan titik akupunktur. Titik akupunktur ialah suatu daerah tertentu di permukaan tubuh, yang dapat menimbulkan reaksi tertentu apabila terdapat rangsangan. Titik – titik akupresur berada pada alur sistem meridian berpengaruh langsung pada meridian yang bersangkutan, sehingga menentukan alur meridian merupakan persyaratan awal sebelum mempelajari akupresur. Titik akupresur memiliki beberapa ciri – ciri khas, yaitu (29):

- a. Besar diameter titik berkisar antara 1-2 mm
- b. Memiliki tahanan listrik rendah, daya hantar serta kepekaan yang tinggi
- c. Memiliki daya hantar gelombang suara yang tinggi

- d. Memiliki suhu yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya
- e. Memiliki persyarafan dan vaskularisasi yang lebih banyak, bila dibandingkan dengan daerah lain.
- f. Mempunyai hubungan dengan fungsi alat dalam tertentu.
- g. Mempunyai hubungan refleks, seperti cutaneo-visceral refleks, viscero-cutaneo refleks.

Cara kerja teknik ini adalah dengan jalan memberikan tekanan pada titik-titik akupunktur selama persalinan yang dianggap dapat memperbaiki kontraksi tanpa meningkatkan rasa nyeri. Terapi akupresur merupakan pengembangan dari ilmu akupunktur, sehingga pada prinsipnya sama, yang membedakan dengan terapi akupunktur yaitu terapi akupresur menggunakan jari tangan dan teknik akupunktur menggunakan jarum. Dengan menggunakan jari tangan maka tindakan secara non invasive diberikan kepada pasien sehingga meminimalkan resiko atau efek samping dari tindakan akupresur.

Untuk mempermudah penentuan letak suatu titik akupresur digunakan 2 cara yaitu dengan letak anatomi dan ukuran cun jari. Letak anatomi biasanya digunakan benjolan benjolan tulang, panca indera, kuku, batas rambut, kerutan lipatan tangan pergelangan, kerutan lipatan siku, kerutan lipatan ketiak, kerutan lipatan lutut, batas perbedaan warna kulit dsb. Ukuran cun jari adalah pengukuran yang menggunakan ukuran panjang atau lebar jari penderita. Ukuran yang paling populer adalah ukuran Fu Fa yaitu lebar 4 jari (jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dalam keadaan merapat) sama dengan 3 cun (Fu Fa).



Gambar 2.8 Ukuran Cun Jari

Akupresur berlandaskan teori akupunktur yang menyatakan bahwa masalah kesehatan yang spesifik termasuk kemajuan persalinan yang kurang memuaskan atau nyeri hebat saat persalinan, muncul ketika terjadi blokade arus energi sepanjang meridian tertentu di dalam tubuh. Dengan melepaskan blokade tersebut keserasian dan fungsi halus dapat dikembalikan. Akupresur merangsang produksi endorfin lokal. Selain itu menutup gerbang terhadap rangsang nyeri(13). *Acupoint* atau titik-titik meridian akupunktur atau akupresur merupakan konduktor listrik pada permukaan kulit yang dapat menyalurkan energi penyembuhan yang paling efektif. *Acupoint* bersifat biolistrik memiliki ciri-ciri papillae kulit 2 kali lebih banyak, mengandung kapiler teranyam dengan saraf sensoris, ujung-ujung saraf simpatis sehingga menaikkan konduktivitas kulit di atasnya karena tekanan listriknya rendah. *Acupoint* terletak di permukaan tubuh, terutama pada lokasi dimana bundle saraf menembus fascia otot atau secara histologis merupakan struktur neodermal dengan densitas lokal yang tinggi yang banyak mengandung serabut saraf simpatik.

G. Teknik Stimulasi Sensorik Dan Terapi Alami

HIV/AIDS sebagai permasalahan penyakit menular secara global memerlukan penanganan yang holistik dan komprehensif yang berkaitan dalam pencapaian tujuan ketiga SDGs. Fenomena penularan HIV/AIDS di masyarakat mengakibatkan kondisi kerentanan klien HIV/AIDS dan berisiko penularan antar individu di keluarga dan komunitas. Strategi penanganan masalah HIV/AIDS secara menyeluruh dan berkelanjutan atau multilevel di antara elemen sub sistem di masyarakat diharapkan akan mampu meningkatkan status kesehatan klien HIV/AIDS dan mencegah penularan penyakit secara berdasarkan pendekatan sosial budaya masyarakat. Solusi terbaru yang dapat diberikan dalam penanganan HIV/AIDS di komunitas dengan lebih melibatkan faktor multi-level di luar tingkat individu HIV/AIDS, misalnya antar individu, jaringan, kelembagaan, atau tingkatan struktural (Seeley et al., 2012 ; Latkin et al., 2010) sebagai suatu model pendekatan yang lebih holistik terhadap perubahan perilaku terkait HIV/AIDS.

H. Teknik Stimulasi Sensorik Dan Terapi Alami

Hipnobirthing

Hipnosis berasal dari kata *hypnos* (bahasa Yunani) adalah nama Dewa Tidur. Arti tidur di sini adalah pikiran yang tenang, sedangkan *birthing* (bahasa Inggris) berarti proses persalinan(19)hipnoterapi diartikan sebagai pemberian sugesti kepada ibu dalam kondisi *trance* / hipnotis, sugesti yang diberikan berisi anjuran,

ajakan, perintah yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu(20). Hipnosis sudah dipergunakan sejak zaman dahulu, hanya saja saat ini hipnosis lebih sering dikaitkan dengan magic, supranatural bahkan mistik. Saat ini, hipnosis dapat dijelaskan secara ilmiah dan terprogram sehingga untuk kepentingan terapi, hasil sebelum dan sesudah terapi hipnosis bisa dilihat dan dibandingkan. Berdasarkan teori Dr. Grantley Dick-Read (seorang ahli kebidanan Inggris yang hidup di tahun 1890-1959), yang dikenal sebagai bapak kelahiran alami. Hipnoterapi merupakan salah satu teknik otophipnosis (*self Hipnosis*) yaitu upaya alami menanamkan niat positif/sugesti ke jiwa/ pikiran bawah sadar dalam menjalani masa kehamilan dan persiapan persalinan. Dengan demikian, setiap ibu hamil dapat menikmati indahnya kehamilan dan lancarnya proses persalinan(19) Metode *hypnobirthing* didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perempuan memiliki potensi untuk menjalani proses melahirkan secara alami, tenang dan nyaman (tanpa rasa sakit). Program ini mengajarkan ibu hamil untuk menyatu dengan gerak dan ritme tubuh yang alami saat menjalani proses melahirkan, membiarkan tubuh dan pikiran untuk bekerja serta meyakini bahwa tubuh mampu berfungsi sebagaimana seharusnya sehingga rasa sakit menghilang(19). *Hypnobirthing* juga mampu untuk menetralsir dan memprogram ulang (*reprogramming*) rekaman negatif dalam pikiran bawah sadar dengan program positif. Dengan demikian, rekaman yang terpatrit dalam pikiran bawah sadar bahwa persalinan itu menakutkan dan menyakitkan, bisa terhapus. Berganti dengan keyakinan bahwa persalinan berlangsung mudah, lancar dan tanpa rasa sakit (nyaman)(19).

Hypnobirthing sebagai penggunaan Hipnosis untuk membuat suatu kepatuhan dan kondisi seperti tidur dalam tetapi kondisi-kondisi dengan komponen psikologis yang sangat besar(12) Hipnosis dapat membantu mengubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. Selama persalinan Hipnosis dianggap memungkinkan wanita menginterpretasikan ulang nyeri kontraksi uterus sebagai sensasi lemah. Dengan jalan ini "gerbang" pada substansia gelatinosa dicegah oleh impuls yang turun untuk membuka dan menyebabkan persepsi nyeri. Seiring dengan relaksasi, respon stress otonom berkurang dan hormon stres yang biasanya meningkatkan persepsi nyeri dalam persalinan tidak disekresi(12). Namun dalam memberikan terapi hipnosis membutuhkan ahli hipnotis yang terlatih, 10-20% wanita tidak rentan terhadap hipnosis, dan efek sampingnya termasuk keadaan kecemasan(21).

Bukti dari 85 studi terkontrol memberikan bukti yang meyakinkan bahwa hipnosis menghasilkan analgesia substantif, dengan penghilang rasa sakit yang optimal diberikan ketika sugesti analgesik langsung digunakan pada populasi target individu yang sugestibilitasnya tinggi. Secara keseluruhan, temuan bahwa induksi

hipnosis menghasilkan penurunan nyeri yang diinduksi secara eksperimental menunjukkan bahwa hipnosis dapat mewakili alternatif yang berpotensi efektif dan aman atau tambahan untuk intervensi farmakologis untuk nyeri akut(22).

I. Penutup

Persalinan adalah proses fisiologis yang menakjubkan, tetapi sering kali disertai dengan tantangan, termasuk nyeri yang dapat memengaruhi pengalaman seorang ibu saat melahirkan. Selama bertahun-tahun, berbagai metode telah dikembangkan untuk mengurangi nyeri persalinan, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Buku ini telah membahas berbagai strategi non-farmakologis yang dapat digunakan untuk membantu ibu mengelola nyeri persalinan dengan lebih nyaman dan alami.

Teknik-teknik seperti pernapasan terkontrol, relaksasi, pijatan, terapi air, aromaterapi, akupresur, serta dukungan emosional dari pendamping persalinan telah terbukti efektif dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa kendali bagi ibu selama proses persalinan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meredakan nyeri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis ibu, yang pada akhirnya dapat mendukung proses persalinan yang lebih positif dan lancar.

Penerapan strategi non-farmakologis dalam manajemen nyeri persalinan membutuhkan edukasi yang baik bagi ibu hamil, keluarga, dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teknik-teknik ini dan dapat mengajarkannya kepada ibu hamil sebagai bagian dari persiapan persalinan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi ibu hamil, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang terlibat dalam mendukung proses persalinan yang lebih nyaman dan bermakna. Dengan pendekatan yang tepat, setiap ibu dapat merasakan pengalaman persalinan yang lebih positif, minim rasa sakit, dan tetap dalam kendali.

Selamat menjalani proses persalinan dengan penuh keberanian, ketenangan, dan keyakinan.

Referensi

- Durham LC and R. The Essence of Maternity-Newborn Nursing. Vol. 53, Journal of Chemical Information and Modeling. California United States of America; 2019. 1689–1699 p.
- Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Haunth JC, Gilstrap LC WK. Williams Obstetrics. New York : McGraw-Hill Inc; 2018.
- Anita W, Nafratilova L, Zalni RI. Efektivitas manajemen nyeri persalinan non farmakologi dengan Deep Back Massage The effectiveness of non-pharmacological labor pain management with Deep Back Massage. 2023;
- Downe S, Finlayson K, Melvin C, Spiby H, Ali S, Diggle P, et al. Self-hypnosis for intrapartum pain management in pregnant nulliparous women : a randomised controlled trial of clinical effectiveness. 2015;
- Hauser, Winfried, Hagi, Maria, Schmierer Albrecht Hansen Emil. The Efficacy , Safety and Applications of medical Hypnosis. Dtsch Arztebl Int. 2016;96–289.
- Rizka Innayatun Mubarak HP, Respati SH. Efektivitas Hipnoterapi untuk Mengurangi Kecemasan di Bagian Pra-Caesar Wanita. J Kesehat Ibu dan Anak. 2020;5:12–8.
- Safdari F, Ra H. Complementary Therapies in Clinical Practice Complementary and alternative therapies to relieve labor pain : A comparative study between music therapy and Hoku point ice massage. 2015;21:2013–6.
- Nancy K Lowe. The nature of labor pain. Am J Obs gynecology. 2002;
- NSimkin, P., & O'Hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: Systematic reviews of five methods. Am J Obstet Gynecol. 186(5),:S131-S159.
- Melzak R WP. Textbook of pain. Edinburg: Churchill Livingstone; 1994.
- WHO. WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience [Internet]. Geneva; 2018. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513809/>
- Mander. Nyeri Persalinan. Jakarta: EGC; 2004.
- Andarmoyo S. Persalinan Tanpa Nyeri Berlebihan. Yogyakarta; 2013. Ar-Ruzz Media. 1.
- Judha M. Teori Pengukuran Nyeri dan Nyeri Persalinan. Jogjakarta: Muha Medika; 2012. 169 p.
- Maryunani A. Nyeri dalam persalinan “Teknik dan Cara \Penanganannya.” Jakarta; 2010.
- Bobak, I.M, Lowdermilk D.I & Jensen MD. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Jakarta: EGC; 2004.
- Potter, P.A. Perry A. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses Dan Praktik. EGC, editor. Vols. 1, E/4. Jakarta; 2005. 1057 p.
- Kumar KH, Elavarasi P. Definition of pain and classification of pain disorders. J Adv Clin Res Insights. 2016;3(June):87–90.
- Kuswandi L. Keajaiban hypno – birthing. Pustaka Bunda, editor. Jakarta; 2011.
- Mubarak RI, Prasetya H. The Effectiveness of Hypnotherapy to Reduce Anxiety in Pre-Caesarean Section Women. 2020;5:12–8.
- Perception I, Fear a, Increased B, Positive C, Level D, Age E, et al. Pain and Pregnancy and Labor. Int J. 2005;1–5.

- Thompson T, Terhune DB, Oram C, Sharangparni J, Rouf R, Solmi M, et al. The effectiveness of hypnosis for pain relief: A systematic review and meta-analysis of 85 controlled experimental trials. *Neurosci Biobehav Rev* [Internet]. 2019;99(February):298–310. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.02.013>
- Kabupaten S, Utara L, Sari ZM, Utami IT, Veronica SY. INTENSITAS NYERI PADA PERSALINAN KALA I FASE AKTIF DI PMB MEYTA EKA FAULIA , S . ST . KECAMATAN ABUNG. *J Matern Aisyah (JAMAN AISYAH) Univ Aisyah Pringsewu* [Internet]. 2021;2(2). Available from: <file:///C:/Users/acer/Downloads/200-Article Text-556-2-10-20210925.pdf>
- Therapy R, Breathing I, Reducing I. Terapi Relaksasi (Napas Dalam) dalam Mengurangi Nyeri Persalinan. *J Dunia Kesmas* [Internet]. 2020;9(3):365–70. Available from: <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/duniakesmas/article/view/3003/pdf>
- Yati Nurhayati. PENGARUH TEKNIK RELAKSASI PERNAFASAN TERHADAP PENURUNAN NYERI Program Studi Akademi Kebidanan Alamat Korespondensi: Program Studi Kebidanan , Akademi Kebidanan Sakinah , Jl . Karya Bhakti No . 1 , Kecamatan Kraton , Kabupaten Pasuruan , Jawa Timur. *J Keperawatan dan Kebidanan*. 2019;47–51.
- Alvira N. Efek Akupresur Pada Titik P6 Dan St36 Untuk Mencegah Post Operative Nausea and Vomiting Pada Pasien Laparatomi Dengan Spinal Anastesi. 2017;42–51.
- Setyowati H. Akupresur untuk kesehatan wanita berbasis penelitian. UNIMMA PRESS, editor. 2018.
- Fransiska Nova Nanur M. Pngaruh pemberian teknik akupresur terhadap nyeri persalinan Kala I fase aktif di RSUD Ambarawa 2013. 2013;(1):90–6.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teori Meridian Akupunktur. Jakarta; 2014.
- Seeley J, Watts CH, Kippax S, Russell S, Heise L, Whiteside A. Addressing the structural drivers of HIV: A luxury or necessity for programmes? *J Int AIDS Soc*. 2012;15(Suppl 1):15–8.
- Latkin C, Weeks MR, Glasman L, Galletly C, Albarracin D. A dynamic social systems model for considering structural factors in HIV prevention and detection. *AIDS Behav*. 2010;14(SUPPL. 2):222–38.

BAB III

PEMANTAUAN KESEHATAN IBU DAN JANIN SELAMA PERSALINAN

A. Pendahuluan

Data yang didapatkan oleh World Health Organization (WHO) tahun 2022 sebanyak 830 wanita meninggal setiap harinya. Hampir 95% dari seluruh kematian ibu berasal dari negara berkembang. Kematian ibu lebih tinggi terjadi di daerah berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah (Elvina Sari Sinaga & Aminah, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia jumlah AKI di Indonesia terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah AKI di Indonesia tercatat sebanyak 7.389 kasus kematian.

Penyebab utama meningkatnya AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia adalah kasus perdarahan yaitu sebanyak 1.330 kasus, 1.077 kasus hipertensi dalam kehamilan, 207 kasus infeksi, 14 kasus abortus, dan lain-lain (Kemenkes RI, 2022). Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menurunkan AKI adalah dengan memastikan setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan bila terjadi komplikasi serta pelayanan terhadap keluarga berencana (Rohati & Siregar, 2023).

B. Tahapan Persalinan dan Fokus Pemantauan

1. Kala I (Pembukaan)

Kala I persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat (frekuensi dan kekuatannya) hingga serviks membuka lengkap (10 cm). Kala I persalinan terdiri atas dua fase yaitu fase laten dan fase aktif

a. Fase laten

- 1) Dimulai sejak berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks bertahap
- 2) Berlangsung hingga serviks membuka kurang dari 4 cm
- 3) Fase laten berlangsung antara 6 hingga 8 jam

b. Fase aktif

- 1) Kontraksi adekuat yaitu terjadi 3 kali atau lebih dalam 10 menit dan berlangsung selama 40 detik/lebih

2) Berlangsung dari pembukaan 4 cm mencapai pembukaan 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam (nullipara atau primigravida) atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm (multipara).

3) Terjadi penurunan bagian terbawah janin.

Dalam penelitian Yuriati & Khoiriyah (2021), kala I dalam persalinan kurang dari 12 jam dikelompokkan pada persalinan cepat, lebih dari 12 jam dikelompokkan persalinan lama.

c. Fokus Pemantauan

1) Kontraksi

- a) Frekuensi yaitu lama kontraksi dalam 10 menit,
- b) Durasi merupakan detik berlangsungnya setiap kontraksi dan
- c) Intesitas kontraksi yaitu ringan, sedang dan kuat

2) Kemajuan Pembukaan

Pembukaan pada persalinan terdiri dari :

- a) Dilatasi (Lebar pembukaan serviks dalam cm)
- b) Penipisan serviks (persentase dari ketebalan normal)
- c) Posisi kepala janin dalam panggul

3) Detak Jantung Janin (DJJ)

Nilai DJJ selama dan segera setelah uterus berkontraksi. Mulai penilaian sebelum atau selama puncak kontraksi. Dengar DJJ selama minimal 60 detik. Gangguan kondisi Kesehatan janin dicerminkan dari DJJ yang kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Kegawatdaruratan janin ditunjukkan dari DJJ yang kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit.

4) Tekanan Darah

Tekanan darah ibu saat sedang bersalin cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum hamil, perlu waspada kegawatdaruratan saat bersalin di kala I yaitu sistol lebih tinggi dari 150 mmHg dan diastole lebih tinggi dari 91 mmHg.

2. Kala II (Pengeluaran)

Kala II persalianan di mulai dari pembukaan lengkap serviks (10 cm), dilanjutkan dengan lahirnya bayi keluar dari jalan lahir dan berakhir dengan lahirnya bayi (Rahmawati, 2024).

a. Fokus pemantauan

1) Frekuensi dan kekuatan kontraksi uterus

- a) Kontraksi uterus yang adekuat harus melampaui 5 kali Dalam 10 menit selama >40 detik.

- b) Waspada kegawadaruratan kontraksi yang <3 kali Dalam 10 menit dan lamanya <40 detik.
 - c) Memastikan adanya istirahat diantara kontraksi untuk mengatasi ibu kelelahan
- 2) Kemajuan persalinan
 - a) Perlunya di evaluasi penurunan kepala janin kedalam jalan lahir.
 - b) memastikan putar paksi Dalam dan luar mengikuti jalan lahir
- 3) Denyut Jantung Janin
 - a) Memastikan tidak adanya tanda-tanda gawat janin seperti brakikardia atau takikardia
 - b) Memastikan tidak adanya bayi kembar yang tak terdeteksi saat hamil
- 4) Mengejan oleh ibu
 - a) Mengajari ibu cara mengejan efektif
 - b) Memastikan ibu mengejan saat kontraksi dan mendorong bayi keluar
- 5) Kondisi Ibu
 - a) Pemantau tanda vital ibu seperti tekanan darah, nadi, pernafasan
 - b) Memantau kemungkinan perdarahan
 - c) Memantau kandung kemih agar tetap Dalam posisi kosong
- 6) Episiotomi dan robekan

Mengevaluasi bayi besar atau penyulit lainnya untuk dilakukannya episiotomi

3. Kala III (Pengeluaran Plasenta) :

Kala III persalinan di mulai dari setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta serta selaput ketuban (Yuriati & Khoiriyah, 2021).

a. Fokus pemantauan

1) Kontraksi Uterus

Pada kala III persalinan, otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan plasenta terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus.

2) Pemberian oksitosin profilaksis

Pemberian oksitosin dapat menyebabkan uterus berkontraksi sehingga mempercepat pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah.

3) Pengeluaran Plasenta

Melahirkan plasenta harus dengan berkontraksinya uterus, saat melahirkan plasenta periksa kembali vagina dan serviks secara seksama untuk memastikan selaput ketuban tidak ada yang tertinggal.

4) Rangsangan Taktil (Masase) fundus uteri

Pastikan uterus berkontraksi selama 15 detik untuk meminimalisir perdarahan.

4. Kala IV (Pemantauan)

Kala IV persalinan di mulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir dalam dua jam pemantauan.

a. Fokus Pemantauan

1) Tanda Vital

a) Tekanan darah

b) Nadi

c) Suhu

2) Tinggi Fundus Uteri

3) Kontraksi

4) Kandung Kemih dan

5) Perdarahan

C. Metode Pemantauan Kesehatan Ibu

1. Pemantauan Fisik dan Tanda Vital

a. Tekanan Darah perlu di lakukan pemantauan karena mewaspadaai kemungkinan preeklamsia atau hipotensi

b. Nadi untuk menilai kondisi kardiovaskular ibu

c. Suhu Tubuh untuk menilai adanya infeksi atau konplikasi

d. Frekuensi Nafas untuk mengetahui gangguan pernafasan seperti asma

2. Pemantauan Kontraksi Uterus

Perlunya di lakukan pemantauan kontraksi uterus berapa kali frekuensi, durasi dan intensitas kontraksinya yang dapat menyimpulkan persalinan tersebut masih bisa dipertahankan ataupun harus di lakukan tindakan.

3. Pemantauan Kemajuan Persalinan

a. Dilakukan Vagina Toucher (VT) untuk mengukur besarnya pembukaan jalan lahir.

b. Penurunan kepala bayi dan molase kepala bayi

c. Status ketuban, apakah sudah pecah dan berwarna jernih atau tidak

4. Pemantauan Nyeri dan Kondisi Psikologis Ibu
 - a. Pengukuran skala nyeri untuk menilai seberapa sakit yang dirasakan ibu
 - b. Kondisi emosional ibu yang tetap tenang dan mendapatkan dukungan dari keluarga
5. Pemberian Asupan dan Cairan

Asupan makanan untuk menjaga stamina ibu selama persalinan dan pemberian infus untuk mencegah dehidrasi kalau diperlukan.
6. Deteksi Dini Komplikasi

Deteksi yang perlu di perhatikan selama persalinan kala I, II, III dan IV adalah perdarahan, tanda-tanda preeklamsia dan tanda-tanda infeksi.

D. Metode Pemantauan Kesehatan Janin

1. Pemantauan Denyut Jantung Janin (DJJ)

Pemantauan denyut jantung janin dapat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Menggunakan Doppler / lenek / monoral

Cara memantau DJJ dengan doppler/lenek/monoral dapat di lakukan setelah dilakukannya palpasi. Saat dilakukan kaki pasien di luruskan dan dengarkan sesuai dengan hasil palpasi dimana letak punggung bayi, dengarkan selama 60 detik untuk memastikan denyut jantung janinnya dalam batas normal

Menurut penelitian fajrin tahun 2021 membahas pembuatan simulator BPM untuk Fetal Doppler dengan rentang 60 hingga 240 BPM menggunakan solenoid sebagai pengganti detak jantung dan rangkaian elektronik pendukung lainnya. Hasil pengukuran menunjukkan nilai error yang rendah, di bawah toleransi $\pm 5\%$ untuk BPM pada Fetal Doppler (Fajrin et al., 2021).

b. Cardiotocography (CTG)

Menurut Penelitian oleh Putri pada tahun 2024 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta mengevaluasi hubungan antara hasil CTG dan skor APGAR pada kasus persalinan prematur. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat hubungan positif antara hasil CTG dan skor APGAR, nilai prediktif positif (PPV) CTG hanya 24%, sementara nilai prediktif negatif (NPV) mencapai 91%. Ini menunjukkan bahwa meskipun CTG efektif dalam mengidentifikasi janin yang tidak mengalami asfiksia (NPV tinggi), kemampuannya untuk mendeteksi janin yang mengalami asfiksia (PPV rendah) masih terbatas. Oleh karena itu, hasil CTG sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya acuan untuk tindakan darurat

tanpa didukung pemeriksaan penunjang lainnya, seperti Skor Profil Biofisik yang mencakup pemeriksaan ultrasonografi. Cara penggunaan CTG Menggunakan sensor elektroda pada punggung janin dan pada fundus uteri hubungkan keduanya dengan sabuk dan hasil siap dibaca dalam bentuk grafik (Afors & Chandharan, 2011).

c. Ultrasonografi (USG)

Pemantauan menggunakan USG yaitu dengan cara probe di letakkan di perut ibu tepat di bagian punggung janin sehingga terdengar suara denyut jantung yang beraturan selanjutnya dihitung dan mendapatkan hasil.

2. Pemantauan Gerakan Janin

Penelitian Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pemantauan Gerakan Janin pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia mengevaluasi tingkat pengetahuan ibu hamil dengan preeklampsia mengenai pemantauan gerakan janin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80,4% ibu hamil dengan preeklampsia memiliki pengetahuan yang kurang tentang pemantauan gerakan janin. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi bagi ibu hamil dengan preeklampsia untuk meningkatkan pemantauan gerakan janin guna mengurangi risiko komplikasi kehamilan. Gerakan janin saat proses bersalin tidak seaktif saat hamil, gerakan janin cenderung melemah karena ruang gerak janin yang menyempit, perlu diperhatikan saat janin kurang bergerak atau gerakan janin turun drastis selama 2 jam maka perlu di evaluasi DJJ dan USG untuk tindakan selanjutnya (Yani et al., 2021).

3. Penyusupan (Moulage) Tulang Kepala Janin

Penyusupan antar tulang kranium merupakan indikator penting tentang seberapa jauh kepala bayi dapat menyesuaikan diri terhadap bagian keras (tulang) panggul ibu. Semakin besar derajat penyusupan atau tumpang-tindih antar tulang kepala semakin menunjukkan risiko disproporsi kepala-panggul (CDP). Pada penelitian Hasanlita tahun 2024 dengan judul "Pengaruh Lingkar Kepala Janin dan Berat Badan Lahir terhadap Kejadian Ruptur Perineum di Puskesmas Malakopa" menunjukkan bahwa Berat badan bayi normal yang mengalami kejadian ruptur perineum 34.7% sedangkan berat badan bayi tidak normal yang mengalami kejadian rupture perineum 73.3% didapatkan nilai $p = 0,017$ ($pvalue < 0,05$). Lingkar kepala bayi normal pada ibu bersalin yang mengalami kejadian ruptur perineum 36% sedangkan lingkar kepala bayi tidak

normal yang mengalami kejadian rupture perineum 68.8% didapatkan nilai $p = 0,041$ ($p \text{ value} < 0,05$) (Hasanalita et al., 2024).

E. Tanda-tanda Gawat Janin

Ada beberapa tanda-tanda gawat janin menurut Kasuma et al (2022):

1. Denyut Jantung Janin

Denyut Jantung Janin kurang dari 120 atau lebih dari 160 x/menit dan DJJ kurang dari 100 atau lebih dari 180 x/menit. Anjurkan ibu untuk miring ke kiri dan menarik nafas panjang perlahan-lahan dan berhenti meneran. Nilai ulang DJJ setelah 5 menit, jika DJJ normal minta ibu Kembali meneran akan tetapi jika DJJ irregular persiapkan dan damping ibu ke tempat rujukan.

2. Penurunan Kepala Bayi

Penurunan kepala bayi saat persalinan merupakan indikator penting dalam kemajuan persalinan apabila kepala bayi tidak turun maka anjurkan ibu untuk memilih posisi meneran jongkok/berdiri.

3. Permasalahan saat bersalin

Distosia bahu saat bayi lahir merupakan salah satu masalah besar dalam kemajuan persalinan. Dapat di tandai dengan kepala bayi tidak melakukan putaran paksi luar, Kepala bayi keluar kemudian teratrik Kembali kedalam vagina, bahu bayi tidak dapat lahir maka tindakan yang dapat dilakukan adalah perasat Mc.robert, prone Mc.robert (menungging), anterior dysimpact, perasat corkscrew dari wood dan perasat schwartz-dixon

4. Cairan Ketuban

Cairan ketuban berwarna hijau atau mengandung mekonium maka nilai DJJ ulang dan evaluai cara ibu meneran serta persiapkan tatalaksana bayi asfiksia saat lahir.

5. Tali Pusat

- a. Pastikan tali tidak menumbung dan tidak ada presentasi manjemuk dengan meraba atau terlihat saat periksa dalam apabila terjadi terjadi maka persiapkan ibu ke fasilitas rujukan dan damping ibu. Posisikan ibu seperti sujud dan dada menempel pada Kasur/brancart tinggikan bokong sambil tangan menekan tali pusat

- b. Tali pusat melilit leher bayi, jika tali pusat melilit longgar di leher bayi, lepaskan melewati kepala bayi. Jika tali pusat melilit erat di leher bayi, lakukan klem dan jepit potong dengan segera

F. Partograf

1. Pengertian

Partograf merupakan alat rekomendasi WHO yang digunakan sebagai acuan untuk mendeteksi persalinan berjalan normal ataukah abnormal sehingga jika penggunaan tidak sesuai akan dapat menyebabkan keterlambatan deteksi dini dalam pengambilan keputusan klinis dan berpotensi meningkatkan resiko terjadinya komplikasi bagi ibu dan bayi, partograf berbentuk grafik yang bertujuan mencatat parameter penting kemajuan persalinan seperti pembukaan serviks, kontraksi uterus, denyut jantung janin serta tanda vital ibu (Titin et al., 2023).

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Titin et al (2023) berjudul "Gambaran Pengetahuan, Masa Kerja, Keterampilan Dalam Kesesuaian Pengisian Partograf Oleh Bidan Di Puskesmas Wilayah Kerja Kecamatan Rambipuji" Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bidan memiliki pengetahuan yang baik tentang partograf, masa kerja yang lama, dan keterampilan yang baik dalam pengisian partograf. Namun, masih terdapat bidan yang tidak sesuai dalam pengisian partograf saat pemantauan proses persalinan, meskipun memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku caring bidan dapat mempengaruhi kesesuaian pengisian partograf.

Penelitian lain oleh Yulianti et al (2020) berjudul "Hubungan Pengetahuan Dengan Penggunaan Partograf Pada Bidan Di Wilayah Kota Bengkulu" Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan teknik purposive sampling, melibatkan 31 responden. Hasil uji univariat menunjukkan bahwa 61,3% responden memiliki pengetahuan sedang dan menggunakan partograf dengan tidak tepat. Uji bivariat dengan nilai p-value 0,003 menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan partograf pada bidan di wilayah Kota Bengkulu.

Selain itu, penelitian oleh Sumaryanti & Jufri (2023) berjudul "Hubungan Tingkat Pengetahuan Keterampilan Pengisian Partograf Pada Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Patria Artha" Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan sampel 30 responden. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa 52,4% responden memiliki pengetahuan baik, namun 50,5% tidak lulus dalam praktik pengisian partograf. Dengan nilai p-value 0,036, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa tentang partograf dengan praktik pengisian partograf.

2. Tujuan Utama

- a. Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan nilai pembukaan serviks, menilai kontraksi uterus dan penurunan bagian terbawah
- b. Mendeteksi secara dini kemungkinan partus lama (Ningrum et al., 2024).

3. Pencatatan selama fase laten kala satu persalinan

Studi kasus oleh Aristina & Diana (2023) berjudul "Asuhan Persalinan Kala I Fase Laten dengan Ketuban Pecah Dini: Studi Kasus" menyoroti pentingnya pencatatan yang teliti pada fase ini, terutama ketika terjadi ketuban pecah dini. Penelitian ini menekankan bahwa asuhan kebidanan yang tepat dan dokumentasi yang akurat dapat membantu menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi.

Semua data dan asuhan pada kala satu persalinan di catat terpisah dari partograf meliputi :

- a. Denyut jantung janin setiap $\frac{1}{2}$ jam
- b. Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap $\frac{1}{2}$ jam
- c. Nadi setiap $\frac{1}{2}$ jam
- d. Pembukaan serviks setiap 4 jam
- e. Penurunan bagian terbawah janin setiap 4 jam
- f. Tekanan darah dan temperature tubuh setiap 4 jam
- g. Produksi urin, aseton dan protein setiap 2 sampai 4 jam

4. Pencatatan selama fase aktif persalinan

Halaman depan partograf mengintruksikan observasi fase aktif persalinan beberapa jurnal menyebutkan hal-hal yang berkaitan didalam persalinan fase aktif dimana salah satunya tentang kontraksi yang berpotensi mempercepat kemajuan persalian dengan dilakukannya pijat oksitosin penelitian tersebut dilakukan oleh Anggraeni, astuti dan anggraini pada tahun 2024 dengan judul "Pengaruh Pijat Oksitosin terhadap Frekuensi dan Durasi Kontraksi Otot Rahim (His) pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif di PMB N" (Anggraeni et al., 2024), sedangkan menurut Pratiwi et al (2024), pada penelitian yang berjudul "Deteksi kontraksi uterus pada ibu bersalin kala I fase aktif menggunakan uterine electromyography" ditahun 2024 menunjukkan bahwa metode mengeksplorasi

penggunaan elektromiografi uterus untuk mendeteksi kontraksi selama fase aktif persalinan dapat menjadi alternatif dalam memantau aktivitas kontraksi uterus.

Pada partograf disediakan tempat untuk mengisi hasil pemeriksaan selama fase aktif persalinan, yaitu :

- a. Informasi tentang ibu
 - 1) Nama, umur
 - 2) Gravida, para abortus (keguguran)
 - 3) Nomor catatan medik/nomor puskesmas
 - 4) Tanggal dan waktu mulai dirawat
 - 5) Waktu pecahnya selaput ketuban
- b. Kondisi janin
 - 1) DJJ
 - 2) Warna dan adanya air ketuban
 - 3) Penyusupan (molase) tulang cranium janin
- c. Kemajuan persalinan
 - 1) Pembukaan serviks
 - 2) Penurunan bagian terbawah atau presentasi janin
 - 3) Garis waspada dan garis bertindak
- d. Jam dan waktu
 - 1) Waktu mulainya fase aktif persalinan
 - 2) Waktu aktual saat pemeriksaan atau penilaian.
- e. Kontraksi uterus
 - 1) Frekuensi kontraksi dalam waktu 10 menit
 - 2) Lama kontraksi (dalam detik)
- f. Obat-obatan dan cairan yang diberikan
 - 1) Oksitosin
 - 2) Obat-obatan lainnya dan cairan IV yang diberikan
- g. Kondisi ibu
 - 1) Nadi, tekanan darah dan temperatur tubuh
 - 2) Urin (volume, aseton atau protein)

5. Mencatat temuan pada partograf

Temuan yang harus dicatatkan pada partograf merupakan indikator pemantauan kemajuan persalinan Studi oleh Puspita et al (2021), dengan judul "Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin di bpm sri puspa kencana amd.keb di kabupaten bogor". mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini (KPD), seperti paritas, jumlah cairan ketuban, kelainan letak, dan usia.

Meskipun tidak secara langsung membahas pencatatan warna air ketuban pada partograf, penelitian ini menyoroti pentingnya pemantauan kondisi air ketuban selama persalinan.

Sedangkan menurut penelitian Elmeida et al (2024), menekankan bahwa penggunaan partograf dapat membantu bidan dalam mendeteksi dini komplikasi pada persalinan, termasuk yang terkait dengan kondisi air ketuban. Meskipun tidak secara eksplisit membahas warna atau keberadaan air ketuban, penelitian ini menunjukkan bahwa partograf dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memantau berbagai aspek persalinan.

Beberapa temuan pada partograf

a. Informasi Tentang Ibu

Terdapat dibagian atas partograf sebelum memulai asuhan persalinan waktu, jam dan perhatikan ibu datang pada fase laten atau aktif catat juga waktu pecahnya selaput ketuban

b. Kondisi Janin

Grafik pertama pada partograf merupakan tempat pencatatan denyut jantung janin, air ketuban dan penyusupan (kepala bayi)

1) Denyut Jantung Janin (DJJ)

Nilai dan catat denyut jantung janin setiap 30 menit, djj akan meningkat apabila ada tanda-tanda gawat janin.

2) Warna dan adanya air ketuban

Nilai kondisi air ketuban setiap kali melakukan pemeriksaan dalam dan nilai warna air ketuban jika selaput ketuban pecah. Dengan lambang-lambang

a) U : Selaput Ketuban Masih Utuh (belum pecah)

b) J : Selaput Ketuban Sudah Pecah dan Air Ketuban Jernih

c) M : Selaput Ketuban Sudah Pecah dan Air Ketuban Bercampur Mekonium

d) D : Selaput Ketuban Sudah Pecah dan Air Ketuban Bercampur Darah

e) K : Selaput Ketuban Sudah Pecah tapi air ketuban tidak mengalir lagi

3) Penyusupan (moulage) tulang kepala janin

Penyusupan merupakan indikator penting selama persalinan, semakin besar derajat penyusupan atau tumpang tindih antar tulang kepala semakin menunjukkan risiko disproporsi kepala panggul (CPD), Berikut lambang yang digunakan untuk penyusupan :

0 : Tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah dapat dipalpasi

1 : Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan

2 : Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan

3 : Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan

c. Kemajuan Persalinan

1) Pembukaan serviks

Nilai dan catat pembukaan serviks setiap 4 jam saat ibu dalam fase aktif dan diberi tanda "X"

2) Penurunan bagian terbawah janin

Posisi miring kiri ibu selama persalinan dapat mempercepat penurunan kepala janin. Sebagian besar responden yang memilih posisi miring kiri menunjukkan kemajuan persalinan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa posisi ibu selama persalinan berperan penting dalam proses penurunan kepala janin (Ariastuti et al., 2020).

3) Garis waspada dan garis bertindak

d. Jam dan Waktu

e. Obat-obatan dan cairan yang diberikan

G. Penutup

Pemantauan kesehatan ibu dan janin selama persalinan merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dengan pemantauan yang tepat, risiko komplikasi dapat diminimalkan, dan tindakan medis yang diperlukan dapat segera dilakukan. Peran tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter, sangat penting dalam memberikan perawatan yang optimal.

Dukungan dari keluarga serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi faktor pendukung dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin harus terus ditingkatkan agar ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan yang optimal sejak awal hingga proses persalinan.

Dengan adanya upaya bersama dari tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan angka kematian ibu dan bayi dapat terus menurun, sehingga kesehatan ibu dan anak di Indonesia semakin terjaga.

Partograf merupakan alat yang sangat penting dalam pemantauan persalinan untuk memastikan proses berlangsung dengan aman dan terkendali. Dengan pencatatan yang sistematis, tenaga kesehatan dapat mendeteksi dini kemungkinan komplikasi, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Penggunaan partograf yang optimal tidak hanya membantu mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, penerapan partograf harus terus diperkuat melalui pelatihan tenaga

kesehatan, peningkatan kesadaran akan manfaatnya, serta integrasi teknologi digital untuk mempermudah pencatatan dan analisis data.

Ke depan, diharapkan partograf dapat semakin diterapkan secara luas dan konsisten di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan keselamatan persalinan secara menyeluruh.

Referensi

- Afors, K., & Chandraharan, E. (2011). Use of continuous electronic fetal monitoring in a preterm fetus: clinical dilemmas and recommendations for practice. *Journal of Pregnancy*, 2011(2014), 848794. <https://doi.org/10.1155/2011/848794>
- Anggraeni, A. D., Astuti, R. P., & Anggraini, M. (2024). Pengaruh Pijat Oksitosin terhadap Frekuensi dan Durasi Kontraksi Otot Rahim (His) pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif di PMB N. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 739–746. <https://doi.org/10.54082/jupin.370>
- Ariastuti, N. D., Sucipto, E., & Andari, I. D. (2020). Hubungan Antara Posisi Miring Kiri Dengan Proses Mempercepat Penurunan Kepala Janin Pada Proses Persalinan. *Jurnal Kesehatan*, 2(2), 60–64. <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/viewFile/243/238>
- Aristina, N. E., & Diana, I. (2023). Asuhan Persalinan Kala I Fase Laten dengan Ketuban Pecah Dini: Studi Kasus. *Jurnal Kesehatan*, XVI(2), 2023. <https://ojs.stikes.gunungsari.id/index.php/GBK/article/view/124>
- Elmeida, I. F., Nurlaila, & Nurchairina. (2024). Pentingnya Partograf Sebagai Alat Deteksi Dini Kegawatdaruratan Pada Persalinan Untuk Menurunkan Angka Sectio Caesarea di TPMB Wirahayu Panjang , Bandar Lampung. *JGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 425–431.
- Elvina Sari Sinaga, & Aminah, A. (2022). Hubungan Preeklamsi Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Di RSUP Haji Adam Malik Medan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 47–51. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.128>
- Fajrin, H. R., Maharani, S., & Fitriyah, A. (2021). Simulator Fetal Doppler. *Medika Teknika: Jurnal Teknik Elektromedik Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mt.v2i2.11212>
- Hasanalita, Satria, E., & Diba, A. (2024). Pengaruh lingkaran kepala janin dan berat badan lahir terhadap kejadian ruptur perineum di puskesmas malakopa. *Jurnal Sehat Mandiri*, 19(1), 242–250.
- Kasuma, A. A., Lulianthy, E., Indry Harvika, & Aprina, T. (2022). Case Report : ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA Ny . I DENGAN PARTUS LAMA DAN By . Ny . I DENGAN. Politeknik Aisyiyah Pontianak, November.
- Ningrum, W. M., Rohmah, S., & Suminar, R. (2024). Inovasi Partograf Digital : Membangun Kapasitas Bidan untuk Penanganan Persalinan Aman di Kabupaten Ciamis. *JPKMU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kesehatan Galuh*, 1(2019), 95–102.
- Pratiwi, P., Nurul Widyawati, M., & Kurnianingsih. (2024). Deteksi Kontraksi Uterus pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif Menggunakan Uterine Electromiography. *Health*

- Information : Jurnal Penelitian, 16(2), e1494.
<https://doi.org/10.36990/hijp.v16i2.1494>
- Puspita, D. F., Novianty, K., & Rahmadini, A. F. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu bersalin Di BPM Sri Puspa Kencana.Amd,Keb di Kabupaten Bogor. *Journal of Midwifery Care*, 2(01), 1–10.
<https://doi.org/10.34305/jmc.v2i01.364>
- Rahmawati, L. D. (2024). Studi Kasus Pertolongan Persalinan Normal dengan Kala I Fase Laten Memanjang di Puskesmas Balongsari, Tandes , Surabaya. *Jurnal Keperawatan*, 22(2), 118–127.
- Rohati, E., & Siregar, R. U. P. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kematian Ibu pada Masa Kehamilan, Persalinan dan Nifas di Kota Depok Tahun 2021. *Jengala: Jurnal Riset Pengembangan Dan Pelayanan Kesehatan*, 2(1), 72–81.
- Sumaryanti, S., & Jufri P, F. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Keterampilan Pengisian Partograf Pada Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Patria Artha. *JUKEJ: Jurnal Kesehatan Jompa*, 2(1), 149–153.
<https://doi.org/10.57218/jkj.vol2.iss1.745>
- Titin, H., Ida, P., & Hendro, P. (2023). Gambaran Pengetahuan, Masa Kerja, Keterampilan dalam Kesesuaian Pengisian Partograf Oleh Bidan di Puskesmas Wilayah Kerja Kecamatan Rambipuji. *Journal of Social Science Research*, 3, 9441–9448.
- Yani, F., Adila, D. R., & Roslita, R. (2021). Tingkat pengetahuan ibu tentang pemantauan gerakan janin pada ibu hamil dengan preeklampsia. *Jurnal Cakrawala Promkes*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.12928/promkes.v3i1.2848>
- Yulianti, S., Rossita, T., & Putri, Y. (2020). Hubungan Pengetahuan dengan Penggunaan Partograf. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10(July), 1–85. <https://justice.gov.za/vg/gbv/NSP-GBVF-FINAL-DOC-04-05.pdf>
- Yuriati, P., & Khoiriyah, E. (2021). Persalinan Nyaman Dengan Teknik Rebozo. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(2), 287.
<https://doi.org/10.26751/jikk.v12i2.1052>

BAB IV

DUKUNGAN PSIKOLOGIS UNTUK IBU SELAMA PROSES PERSALINAN

A. Pendahuluan

Persalinan merupakan hal yang paling dinantikan oleh ibu hamil, dikarenakan merupakan moment yang membahagiakan akan kelahiran bayi namun disisi lain merupakan hal yang sangat mencemaskan karena terbayang akan proses persalinan yang menyakitkan dan merupakan perjuangan yang sangat menguras energi. Gangguan yang sering terjadi pada saat menjelang persalinan bersumber pada rasa takut dan sakit pada fisik yang menimbulkan kecemasan sehingga ibu membutuhkan dukungan secara psikologis pada saat persalinan. Dalam beberapa literatur dukungan psikologis dapat mempercepat proses persalinan karenan dapat meringankan ketidaknyamanan dan mengurangi rasa cemas, menerikan afirmasi positif sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam proses persalinan dan menurunkan rasa nyeri persalinan.

Perubahan psikologis yang terjadi pada ibu bersalin, hendaknya sebagai seorang tenaga kesehatan terutama kebidanan mampu memberikan asuhan kebidanan berdasarkan pada konsep-konsep kebidanan, sikap dan keterampilan sesuai dengan evidence based kebidanan.

B. Perubahan Psikologis Ibu Menjelang Persalinan Dan Saat Proses Persalinan

Kondisi Psikologis yang sering terijadi menjelang persalinan adalah kecemasan, baik pada ibu primiparitas maupun yang multiparitas yang memiliki trauma pada saat persalinan. Dukungan psikologis yang diberikan dapat memastikan kesehatan mental selama dan pasca persalinan, kurangnya dukungan psikologis ibu beresiko mengalami stress, kecemasan bahkan deprsesi (Setianingsih Lilis Zuniawati, 2024).

Mempersiapkan ibu dan keluarga secara mental dan emosional dalam menghadapi persalinan dapat membantu mengelola harapan, ketakutan dan kecemasan yang mungkin akan timbul pada saat persalianan sehingga dibutuhkan dukungan secara psikologis.

Dukungan psikologis dan perhatian akan memberikan dampak terhadap pola kehidupan sosial sperti keharmonisan, penghargaan, kasih sayang dan empati pada

ibu dalam proses persalinan sedangkan dari segi teknis dapat mempercepat proses persalinan, mengendalikan rasa nyeri dan memberikan asuhan neonatal.

Adapun perubahan psikologis yang terjadi pada ibu bersalin yaitu (Supiani, 2024):

1. Perubahan Psikologis pada ibu bersalin kala I

Kala I dalam persalinan dimulai pada pembukaan 1 cm samapai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Kala I dibagi menjadi dua fase yaitu fase aktif dan fase laten.

Psikologi ibu juga dapat mempengaruhi fisiologi sehingga seorang bidan harus memahami tentang perubahan psikologis pada ibu selama persalinan dengan melakukan pengkajian terhadap ibu secara nyaman sesuai dengan kondisi ibu. Adapun kondisi yang sering terjadi pada kala I adalah :

- a. Rasa cemas yang dirasakan ibu biasanya berupa takut jika bayi lahir dalam keadaan cacat, rasa cemas tidak bisa merawat bayinya dengan baik dsb.
- b. Sensasi ketidaknyaman berupa rasa tegang, kesakitan. karena kepala bayi sudah masuk panggul dan terjadi kontraksi rahim sehingga bayi yang diharapkan dan dicintai secara psikologis selama berbulan-bulan kini dirasakan sebagai beban yang sangat berat.
- c. Kekhawatiran akan kesulitan dan bahaya melahirkan bayi, yang merupakan hambatan dalam proses persalinan:
 - 1) Rasa ketakutan dan kecemasan terjadi dalam waktu yang singkat dan tanpa sebab yang diketahui dengan jelas.
 - 2) Ada beberapa keluhan sesak napas atau menyesakkan dada, jantung berdebar-debar.
 - 3) Perasaan takut akan kematian atau merasa tidak dapat ditolong selama persalinan.
 - 4) Wajah pucat, pandangan liar, napas pendek, cepat, dan takikardia
- d. Adanya kekhawatiran mengenai jenis kelamin bayi yang dilahirkan.
- e. Kegelisahan dan ketakutan menjelang proses persalinan seperti adanya rasa takut mati, trauma kelahiran, perasaan bersalah dan ketakutan riil.

2. Perubahan Psikologis berupa rasada ibu bersalin kala II

Kala II dimulai setelah *serviks* mencapai pembukaan lengkap (10cm) dan berakhir dengan kelahiran bayi. Tanda gejala kala II yaitu :

- a. Adanya rasa ingin meneran atau mengejan
- b. Adanya peningkatan tekanan di area rektum dan vagina.
- c. Permukaan perineum menjadi menonjol.
- d. Mulut vagina dan otot sfingter ani mulai terbuka.

e. Keluarnya lendir yang bercampur darah.

Adapun perubahan psikologi yang sering muncul pada kala II adalah :

- 1) Dalam proses persalinan, sering kali muncul perasaan tidak nyaman dan frustrasi. karena rasa sakit yang disebabkan oleh kontraksi rahim yang semakin sering terjadi. Metabolisme ibu semakin meningkat, dengan peningkatan
- 2) detak jantung, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan yang lebih cepat. Akibatnya, ibu berkeringat lebih banyak dan merasa sangat lelah dan haus setelah bayi lahir karena usaha mendedan yang keras.
- 3) Ketidaksabaran yang muncul dapat mengganggu keseimbangan antara ibu dan janin di dalam rahim. Hal ini terjadi ketika kepala janin sudah mulai memasuki panggul dan kontraksi rahim menjadi lebih sering. Rasa sakit dan dorongan untuk segera melahirkan menjadi lebih kuat.
- 4) Pengaruh mengejan selama persalinan dapat menyebabkan kelelahan pada ibu, karena energi yang besar dikerahkan untuk mendorong bayi keluar.

C. Masalah Psikologis yang Sering Terjadi pada Masa Persalinan

Masalah psikologis yang terjadi selama persalinan adalah kecemasan. Selama persalinan, beberapa wanita merasa tenang dan bangga dengan kelahiran bayi mereka, tetapi ada juga yang merasa takut.

Dari segi fisiologis, respons tubuh terhadap kecemasan adalah mengaktifkan sistem saraf otonom (simpatis dan parasimpatis). sistem saraf otonom (simpatis dan parasimpatis). Sistem saraf simpatis akan mengaktifkan sistem saraf tubuh, sedangkan sistem saraf parasimpatis akan menyebabkan respon tubuh. Ketika korteks menerima rangsangan, maka rangsangan tersebut akan dikirim melalui saraf simpatis ke kelenjar adrenal yang akan mengeluarkan adrenal/epineprin sehingga efek yang ditimbulkan antara lain napas menjadi lebih dalam, denyut nadi meningkat, dan tubuh merespon rangsangan tersebut. lebih dalam, denyut nadi meningkat, dan tekanan darah meningkat. Darah akan dialirkan terutama terutama ke jantung, sistem saraf pusat, dan otak. Dengan meningkatnya glikolisis, gula darah akan meningkat. Secara psikologis, kecemasan akan mempengaruhi koordinasi atau refleks, kesulitan mendengar atau mengganggu hubungan. refleks, kesulitan mendengar atau mengganggu hubungan dengan orang lain. Kecemasan dapat membuat individu menarik diri dan mengurangi keterlibatan orang lain (Biana et al., 2021) dan (Nurseha et al., 2024)

1. Kecemasan

Kecemasan adalah hal yang umum dialami menjelang persalinan Wanita yang sedang mengandung anak pertama kan mulai merasa khawatir dan cemas.

jika kecemasan ini tidak dikelola dengan baik, maka kondisi psikologis ibu akan semakin memburuk. Tidak menutup kemungkinan ia bisa mengalami gangguan obsesif kompulsif.

Beberapa tanda dan gejala kecemasan diantaranya :

- a. Stres motorik/gerakan, termasuk gemetar, tegang, nyeri otot, kelelahan, kelelahan, ketidakmampuan untuk rileks, kegelisahan, cemberut, dan reaksi mudah terkejut.
- b. Hiperaktivitas saraf otonom simpatis dan parasimpatis, termasuk keringat berlebih, jantung berdebar, sensasi dingin di telapak tangan dan telapak kaki, mulut kering, mual, sering buang air kecil, diare, wajah pucat atau merah, detak jantung cepat.
- c. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang akan datang yang akan datang seperti cemas, takut, khawatir, membayangkan kemalangan akan menimpa dirinya.
- d. Kewaspadaan yang berlebihan seperti perhatian perhatian mudah teralihkan, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, mudah tersinggung dan tidak sabar.

2. Ketakutan

Seorang ibu mungkin merasa takut dengan proses persalinan normal. Ia berimajinasi apakah janin yang akan dilahirkannya akan selamat atau tidak. Atau rasa sakit persalinan apakah ia bisa menanggungnya atau tidak. Ketakutan berbeda dengan kecemasan. Kecemasan adalah suatu bentuk kekhawatiran tentang objek yang samar-samar (hanya ada dalam pikiran dan tidak jelas seperti apa bentuknya). Sementara itu, rasa takut adalah bentuk kekhawatiran terhadap sesuatu yang memiliki objek yang jelas. Dalam mengatasi rasa takut, seorang ibu harus ditenangkan terlebih dahulu. Mendengarkan apa adalah hal yang baik untuk dilakukan, bersikap menggurui atau memintanya untuk berhenti merasa takut tidak akan membantu.

3. Sikap pasif

Kepasifan ikut berpengaruh ketika seorang ibu hamil memiliki keengganan untuk melahirkan. Hal ini juga dipicu oleh rendahnya dukungan dari lingkungan sekitar. Minimnya perhatian dari suami dan keluarga akan menimbulkan sikap pasif dari ibu hamil. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan pada

Untuk mengatasi sikap pasif tersebut, kita dapat memberikan support system yang baik berupa perhatian dan kasih sayang. Bagaimanapun juga, hal ini akan sangat mempengaruhi kelancaran proses persalinannya nanti.

4. Hipermaskulin

Ibu merasa tidak stabil keinginannya antara ingin atau tidak memiliki anak. Padahal, dia sudah berada di masa-masa persalinan. Akibatnya, emosinya menjadi tidak stabil. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang berkarier. Pikirannya tidak stabil karena ia ingin mempertahankan pekerjaannya, tetapi di sisi lain, ia juga mendambakan kehadiran seorang anak. Gangguan psikologis selama masa reproduksi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Lagi-lagi, untuk mengatasinya, dengan memberikan support system yang baik Mendengarkan keluhan kesahnya dan mencari solusi bersama adalah hal yang tepat untuk yang harus dilakukan.

5. Hiperaktif

Menjelang persalinan, seorang ibu juga bisa menjadi lebih hiperaktif karena ibu ingin segera melahirkan sesegera mungkin. Oleh karena itu, ibu menjadi lebih aktif demi kelancaran proses persalinan. Menenangkan ibu hamil dengan memberikan pengertian tentang proses persalinan merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Konseling psikologis juga dapat dilakukan untuk membantu ibu menjadi lebih siap.

6. Komplek maskulin

Kompleks maskulin adalah bentuk hiperaktif yang tidak dapat dikelola. Pada saat persalinan, seorang wanita menjadi lebih agresif lagi. Sikapnya menunjukkan bahwa persalinan yang dialaminya harus segera diselesaikan dan dia tidak ingin membuang waktu. Sikapnya menjadi lebih mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Untuk mengatasi gangguan psikologis selama persalinan ini, sebaiknya tenaga medis yang membantu persalinan sebaiknya menghadirkan orang terdekatnya (suami).

7. Halusinasi hipnagonik

Pada saat akan bersalin, seorang ibu pasti akan mengalami kontraksi. Ada fase istirahat selama kontraksi tersebut. Seorang ibu bisa mengalami kondisi tidur semu. Di sinilah terjadi kondisi halusinasi hipnagonik. Ia akan menjadi tidak tenang karena muncul pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Bahkan, kadang bisa juga muncul gangguan psikosomatis. Untuk mengatasinya, maka kita bisa tetap mempertahankan interaksi pada ibu menjelang persalinan.

8. Sindrom Baby blues

Biasanya terjadi setelah proses persalinan. Bounding attachment yang kurang baik menyebabkan seorang ibu justru menolak kehadiran bayinya. Oleh

karenanya, dukungan berupa pemberian motivasi dan juga langkah-langkah untuk siap mengalami perubahan status menjadi ibu bisa diberikan supaya sindrom ini tidak terjadi.

D. Faktor Penyebab Masalah Psikologis dalam Persalinan

Pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab masalah psikologis yang dialami selama proses kehamilan dan persalinan karena berkaitan dengan kesehatan mental ibu. Pengalaman persalinan dapat mempengaruhi kesehatan psikologi secara signifikan. Masalah psikologis yang dialami selama proses persalinan tidak hanya dipengaruhi kesehatan mental sebelumnya namun juga dipengaruhi dari berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal (Bima Suryantara, 2025) dan (Nilsson et al., 2018) :

1. Perubahan hormon dan emosi selama kehamilan

Secara signifikan perubahan hormon selama kehamilan berdampak pada kesehatan psikologis ibu. Perubahan suasana hati seperti merasa cemas, ketakutan dan perasaan yang tidak menentu (*mood swing*) biasanya disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron, selain itu juga juga mempengaruhi fungsi *neurotransmitter* di otak yang berkaitan dengan emosi dan *mood*.

2. Pengalaman persalinan sebelumnya

Trauma persalinan yang lama atau komplikasi medis dapat meninggalkan dampak emosional yang mendalam pada ibu dan mengarah pada gangguan *stres pasca-trauma (PTSD)* . ibu yang mengalami traumatis lebih rentan mengalami kecemasan dan stres pada kehamilan berikutnya. Traumatik ini dapat meninggalkan luka psikologis yang mempengaruhi kondisi mental ibu saat menjalani kehamilan dan persalinan berikutnya. Sehingga ibu yang traumatis ini perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari terjadinya kecemasan berlebih atau ketakutan saat menghadapi proses persalinan yang baru. Pendekatan psikologis seperti kognitif dan sesi konseling merupakan cara yang sangat efektif untuk membantu ibu mengurangi risiko terjadinya gangguan mental pada persalinan berikutnya.

3. Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang diberikan bukan hanya berupa sentuhan fisik, tetapi juga dukungan emosional yang berfungsi sebagai penyangga terhadap tekanan psikologis yang dialami ibu. Ibu yang menerima dukungan sosial yang kuat memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah psikologis selama kehamilan

dan setelah persalinan. Dukungan sosial yang baik, dari pasangan maupun dari lingkungan terdekat mampu mengurangi gejala kecemasan dan depresi post partum. Dukungan sosial yang diberikan langsung dan tidak langsung seperti membantu mengurus rumah tangga dukungan emosional kekhawatiran pada saat melahirkan. Ibu yang mendapatkan dukungan emosional dari pasangan menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah dalam dan berpengaruh positif terhadap kesehatan ibu dan bayi.

4. Kurangnya persiapan mental

Kondisi psikis atau mental yang kurang dalam menghadapi berbagai kemungkinan seperti peran ganda dalam merawat bayi, pasangan dan diri sendiri. Terutama akan hal-hal baru yang akan dialami setelah melahirkan tentunya dapat menimbulkan masalah dan rasa sakit yang dialami pada minggu-minggu terakhir menjelang persalinan yang dapat meregangkan gangguan psikis ibu dan anak. Maka beban inilah yang menjadi impuls-impuls emosional yang menyebabkan sikap permusuhan antara ibu dan bayi, sehingga ibu merasa harus segera melahirkan bayi yang dikandungnya.

5. Kondisi medis dan komplikasi persalinan sebelumnya

Komplikasi medis tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik ibu, namun juga mentalnya dikarenakan rasa cemas tentang kesehatan ibu dan bayinya. Seringkali komplikasi ini meningkatkan risiko depresi *prenatal* dan *postpartum*. Keadaan medis yang memerlukan perawatan intensif ini seringkali menimbulkan kecemasan pada ibu terutama yang dapat membahayakan nyawa bayi.

6. Gangguan *Bonding Attachment*

Keterikatan batin adalah suatu proses dimana sebagai hasil dari interaksi terus menerus antara bayi dan orangtua yang bersifat saling mencintai dan memberikan dukungan emosional dan saling membutuhkan.

7. Faktor budaya dan Kepercayaan

Budaya dan kepercayaan memiliki pengaruh besar terhadap pandangan ibu tentang persalinan. Beberapa tradisi kepercayaan budaya mengajarkan bahwa persalinan adalah ujian atau tantangan yang menambahkan beban psikologis ibu. Namun ada juga budaya yang menekankan pada pentingnya kesehatan mental dan fisik ibu selama hamil sehingga ibu lebih tenang dalam menghadapi persalinan.

8. Nyeri

Hampir semua wanita mengalami dan merasakan nyeri selama persalinan, tetapi respon setiap wanita terhadap nyeri persalinan berbeda-beda. Nyeri adalah pengalaman yang berbeda yang dirasakan seseorang. Nyeri pada persalinan kala I adalah perasaan sakit dan tidak nyaman yang dialami ibu sejak awal mulainya persalinan sampai serviks berdilatasi maksimal (10 cm). Nyeri ini disebabkan oleh dilatasi serviks, hipoksia otot uterus, iskemia korpus uteri, peregangan segmen bawah uterus dan kompresi saraf di serviks (ganglionik servikalis). Subyektif nyeri ini dipengaruhi paritas, ukuran dan posisi janin, tindakan medis, kecemasan, kelelahan, budaya dan mekanisme koping, serta lingkungan. Nyeri mengakibatkan stres karena stres dapat melepaskan katekolamin yang mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke uterus sehingga uterus kekurangan oksigen. Nyeri melibatkan dua komponen yaitu fisiologis dan psikologis. Secara psikologis pengurang nyeri akan menurunkan tekanan yang luar biasa bagi ibu dan bayinya. Ibu mungkin akan menurunkan kesulitan untuk berinteraksi setelah lahir karena ia mengalami kelelahan saat menghadapi nyeri persalinan. Peristiwa atau kesan yang tidak menyenangkan saat melahirkan dapat mempengaruhi responnya terhadap aktivitas seksual atau untuk melahirkan yang akan datang.

9. Keadaan fisik

Penyakit yang menyertai ibu dalam kehamilan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kecemasan. Seseorang yang menderita suatu penyakit akan mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak sedang menderita sakit. Seorang ibu hamil dengan suatu penyakit yang menyertai kehamilannya, maka ibu tersebut akan lebih cemas lagi karena kehamilan dan persalinan meskipun dianggap fisiologis, tetapi tetap berisiko terjadi hal-hal psikologis.

10. Riwayat pemeriksaan kehamilan

Ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya pada dokter ahli kandungan, dokter umum, dan bidan. Tujuan pemeriksaan dan pengawasan ibu hamil adalah sebagai berikut:

- a) Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin dijumpai dalam kehamilan, persalinan dan nifas.
- b) Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita ibu sedini mungkin
- c) Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak.

d) Memberikan nasehat- nasehat tentang cara hidup sehari-hari dan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas dan laktasi.

Dalam setiap kunjungan pemeriksaan kehamilan ke petugas kesehatan, selain pemeriksaan fisik, ibu akan mendapatkan informasi/pendidikan kesehatan tentang perawatan kehamilan yang baik, persiapan menjelang persalinan baik fisik maupun psikis, serta informasi mengenai proses persalinan yang akan dihadapi nanti. Dengan demikian, ibu diharapkan dapat lebih siap dan lebih percaya diri dalam menghadapi proses persalinan. Untuk itu selama hamil hendaknya ibu memeriksakan kehamilannya secara teratur ke petugas kesehatan.

11. Pengetahuan

Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh seseorang tentang suatu hal secara formal maupun nonformal. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu. Ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih permanen dianut seseorang dibandingkan dengan perilaku yang biasa berlaku. Pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami kecemasan. Ketidaktahuan tentang suatu hal yang dianggap sebagai tekanan yang dapat mengakibatkan krisis sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan dapat terjadi pada ibu dengan pengetahuan rendah mengenai proses persalinan, serta hal-hal yang akan dan harus dialami oleh ibu sebagai dampak dari kemajuan persalinan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh.

12. Pendidikan

Pendidikan adalah proses belajar yang berarti di dalam pendidikan terjadi proses perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik dari individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih luas. Pendidikan sejalan dengan pengetahuan yaitu pengetahuan adalah hasil tahu yang terjadi setelah penginderaan terhadap suatu obyek tertentu serta pengetahuan/ kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Menurut Raytone tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan respons terhadap sesuatu yang datang baik dari dalam maupun luar. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan memberikan

respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah atau yang tidak mempunyai pendidikan. Kecemasan adalah respon yang dapat dipelajari. Dengan demikian, pendidikan yang rendah menjadi faktor penunjang terjadinya kecemasan.

13. Status psikologis

Respons psikologis terhadap pengalaman persalinan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor yang penting adalah latar belakang budaya wanita. Orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya berbeda mungkin memiliki keyakinan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya sikap wanita bersalin, keberadaan orang-orang pendukung dan peran perawat. Misalnya dengan sentuhan bisa merupakan bentuk perhatian yang berharga bagi ibu bersalin wanita sangat menginginkan pasangannya menemani sepanjang persalinan dan kelahiran, sebagai ungkapan cinta dan memperlihatkan pengertian dan kesabaran. Persiapan kelahiran seringkali bervariasi dan secara dramatis dapat mempengaruhi kemampuan koping wanita bersalin dan pasangannya.

Dukungan emosional pasangan selama melahirkan merupakan prediktor utama terbentuknya persepsi yang positif terhadap pengalaman. Kepercayaan diri maternal dalam koping terhadap persalinan telah terbukti berhubungan dengan persepsinya tentang nyeri selama persalinan. Begitu juga harapan dapat mempengaruhi respons psikologis terhadap persalinan. (O'Connell et al., 2021) mengobservasi bahwa wanita dengan kehamilan resiko tinggi mungkin lebih mengharapkan intervensi medis dan lebih sulit mengatasi nyeri persalinan dan kelahiran dibandingkan wanita dengan kehamilan resiko rendah. Bagi kedua kelompok wanita tersebut, kecemasan berhubungan secara negatif dengan harapan melahirkan. Dalam rangkaian study klasik yang terkenal, Lederman, meneliti hubungan antara faktor psikologis dalam variabel kehamilan dan persalinan seperti epineprin plasma dan kemajuan persalinan. Kecemasan dalam persalinan dan epineprin plasma berhubungan dengan pola denyut jantung janin dalam persalinan aktif

Lama persalinan berhubungan dengan kadar epineprin plasma dan norepineprin pada multipara. Persalinan yang lebih lama dihubungkan dengan kadar katekolamin yang lebih tinggi, yang berhubungan dengan ukuran kecemasan pasien. Peneliti lain menemukan kesamaan bahwa wanita mengalami nyeri yang sangat atau distres akan lebih mengalami persalinan yang tidak efisien.

E. Dukungan Psikologis dalam Pemulihan Pasca Melahirkan

Dukungan persalinan pada ibu membuat ibu merasa nyaman, tenang dan bahagia selama persalinan. Dukungan ini termasuk dukungan emosional (kehadiran pendamping terus menerus, kepastian dan pujian), serta informasi mengenai kemajuan persalinan. Hal ini juga menyangkut mengenai teknik koping, tindakan kenyamanan (sentuhan, pijat, mandi air hangat, mendorong mobilitas, memberikan nutrisi dan gizi yang baik (Taheri et al., 2018).

Perawatan suportif selama persalinan dapat meningkatkan proses persalinan fisiologis, serta dapat mengontrol perasaan dan kepercayaan ibu terhadap kekuatan dan kemampuan dalam melahirkan. Hal ini dapat mengurangi intervensi obstetrik dan meningkatkan pengalaman positif pada ibu selama proses melahirkan.

Selain dukungan keluarga, kehadiran dari tenaga kesehatan terutama bidan dalam memberikan support pada ibu saat melahirkan juga memberikan kesan positif dan kepuasan pada ibu dalam perawatnya. Kehadiran dan sikap bidan dapat meningkatkan kepercayaan wanita terhadap kemampuannya sendiri dalam menghadapi persalinan.

Adapun dukungan selama persalinan diantaranya (Happy Nurmawati et al., 2023) :

1. Lingkungan yang tenag dapat membuat ibu dan pendamping persalinan merasa nyaman serta sikap penolong persalinan yang ramah sangatlah mempengaruhi selama proses persalinan.
2. Bidan dan keluarga harus menjadi teman yang mendukung persalinan dbagi ibu.
3. Memfasilitasi ibu bersalin untuk tetap kuat dan bersemangat serta bergerak aktif dan mengatur posisi yang nyaman pada saat persalinan sehingga persalinan berjalan lancar, cepat dan aman.
4. Menjelaskan kepada ibu mengenai keadaan ibu, janin dan kemajuan persalinan.
5. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga setiap intervensi yang dilakukan dan libatkan ibu dan keluarga untuk mengambik keputusan klinis jika diperlukan
6. Mengajarkan ibu tehnik relaksasi untuk mengalihkan rasa cemas dan nyeri yang dirasakan ibu.
7. Bidan memberikan semangat dan dorongan selama proses persalinan serta memberikan pujian setiap usaha ibu.

Dukungan minimal yang diberikan suami berupa dampingan ibu selama proses persalinan dapat berupa mendengarkan keluhan ibu, memberikan sentuhan dan kata-kata afirmasi positif yang mendukung ibu sehingga ibu merasa nyaman dengan kehadirannya dan dukungan lainnya yang dapat memberikan penguatan selama proses persalinan dan mempersingkat proses persalinan.

8. Konseling prenatal menyediakan ruang aman bagi calon ibu untuk membicarakan berbagai masalah yang tidak selalu dibicarakan sebelum atau selama kehamilan. Ini adalah kesempatan bagi seorang wanita untuk memilah-milah berbagai emosi yang bertentangan dan meningkatkan kesehatan mentalnya dengan perawatan yang mendukung.

F. Mengatasi Gangguan Psikologis saat Persalinan

Fenomena psikologis yang menyertai persalinan itu bermacam-macam. Setiap wanita memiliki disposisi kepribadian yang definitif dan mewarnai proses kelahiran bayinya. Secara garis besar, mewarnai itu mengandung pengertian menonjolkan kepasifan atau keaktifan pada saat kelahiran bayinya. Keadaan emosional pada ibu bersalin sangat dipengaruhi oleh timbulnya rasa sakit dan rasa tidak enak selama persalinan berlangsung, terutama bila ibu baru pertama kali akan melahirkan yang pertama kali dan baru pertama kali dirawat di rumah sakit. Alangkah baiknya apabila ibu bersalin mengenal dengan baik keadaan ruang bersalin/rumah sakit dari tersebut berada dalam suasana yang hangat dan familiar walaupun dirawat di rumah sakit.

Peran bidan yang empati pada ibu bersalin sangat berarti, keluhan dan kebutuhankebutuhan yang timbul agar mendapatkan tanggapan yang baik. Penjelasan tentang kemajuan persalinan harus dikerjakan secara baik sedemikian rupa agar ibu bersalin tidak mengalami panik. Peran suami yang sudah memahami proses persalinan bila berada di samping ibu yang sedang bersalin sangat membantu kemantapan ibu dalam menghadapi rasa sakit dan takut yang timbul. Pengurang rasa sakit (*pain relief*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil penelitian, pemberian dukungan fisik, emosional dan psikologis selama persalinan akan dapat membantu mempercepat proses persalinan dan membantu ibu memperoleh kepuasan saat melewati proses persalinan. 2) Metode pengurang rasa nyeri yang dilakukan secara terus menerus dalam bentuk dukungan harus dipilih yang bersifat sederhana, biaya rendah, resiko rendah, membantu kemajuan persalinan, hasil kelahiran bertambah baik dan bersifat sayang ibu. (Fenwick et al., 2015).

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri yang dialami diantaranya dengan melakukan kompres panas atau dingin kemudian sentuhan dan pemijatan ringan dengan remasan, pijatan melingkar yang halus dan ringan (pemijatan dalam kategori rangsangan dan sentuhan ringan dan halus).

1. Kompres panas

Kompres dapat dilakukan dengan menggunakan handuk panas, silika gel yang telah dipanaskan, kantong nasi panas atau botol yang telah diisi air panas.

Dapat juga langsung dengan menggunakan shower air panas langsung pada bahu, perut atau punggung jika dia merasa nyaman. Kompres panas dapat meningkatkan suhu lokal pada kulit sehingga meningkatkan sirkulasi pada jaringan untuk proses metabolisme tubuh. Hal tersebut dapat mengurangi spasme otot dan mengurangi nyeri. Indikasi pemberian kompres panas Saat yang tepat pemberian kompres panas, yaitu saat ibu mengeluh sakit atau nyeri pada daerah tertentu, saat ibu mengeluh adanya tanda - tanda ketegangan otot saat ibu mengeluh ada perasaan tidak nyaman. Kompres panas tidak diberikan pada ibu dalam keadaan demam dan disertai tanda - tanda peradangan lain, mengompres daerah yang mengalami peradangan (ditandai dengan bengkak, panas, dan merah) dapat memperluas peradangan, atau kompres panas tidak dilakukan jika petugas takut dengan kemungkinan terjadinya demam akibat kompres hangat.

2. Kompres dingin

Cara pemberian kompres dingin adalah dengan meletakkan kompres dingin butiran es, handuk basah dan dingin, sarung tanagn karet yang diisi dengan butiran es, botol plastik dengan air es pada punggung atau perieum. Selain itu kompres dingin dapat digunakan pada wajah ibu yang bengkak, tangan dan kakiserta dapat diletakkan pada anus untuk mengurangi nyeri haemorrhoid pada kala II. Kompres dingin sangat berguna untuk mengurangi ketegangan otot dan nyeri dengan menekan spasme otot (lebih lama daripada kompres panas) serta memperlambat proses penghantaran rasa sakit dari neuron ke organ. Kompres dingin juga mengurangi bengkak dan mendinginkan kulit. Kompres dingin diberikan pada kondisi nyeri punggung, rasa panas saat inpartu, hemoroid yang menimbulkan sakit. Setelah persalinan, kompres dingin dapat digunakan pada perineum. Kompres dingin tidak diberikan pada saat ibu menggigil atau jika ibu mengatakan tidak ada perubahan dengan kompres panas dan menimbulkan iritasi.

3. Hidroterapi

Hidroterapi adalah jenis terapi yang menggunakan media air dengan suhunya tidak lebih 37 – 37,5 0 C untuk mengurangi rasa sakit, ketegangan otot, nyeri atau cemas pada beberapa wanita. Hidroterapi juga dapat mengurangi nyeri punggung dengan menggunakan teknik tertentu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hip Squeeze Kedua tangan memberi tekanan pada otot gluteal (daerah bokong) bergerak ke atas. Teknik ini mengurangi ketegangan pada sakro iliaka dan juga pada ligamentum.

- b. Knee Press. Dilakukan penekanan pada lutut dengan posisi duduk. Cara ini dapat mengurangi nyeri punggung.

Beberapa teknik dukungan/pendekatan untuk mengurangi rasa sakit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kehadiran seorang pendamping yang terus menerus, sentuhan yang nyaman dan dorongan dari orang yang memberikan dukungan
- b. Perubahan posisi dan pergerakan.
- c. Sentuhan dan massage *Counter pressure* untuk mengurangi tegangan pada ligamen
- d. Pijatan ganda pada pinggul
- e. Penekanan pada lutut
- f. Kompres hangat dan kompres dingin
- g. Berendam
- h. Pengeluaran suara
- i. Visualisasi dan pemusatan perhatian (dengan berdoa)
- j. Musik yang lembut dan menyenangkan ibu .

G. Penutup

Persalinan bisa menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi ibu, terutama kelahiran pertama. Selain itu, ibu akan mengalami sensasi fisik mulai dari ketidaknyamanan hingga nyeri hebat. Membantu ibu untuk santai mungkin dan menyadari situasinya dapat membantu meminimalkan nyeri fisik dan tekanan emosional selama persalinan dan kelahiran. Strategi yang paling efektif untuk menciptakan pengalaman melahirkan yang positif adalah dengan mendukung ibu selama persalinan, perawatan intrapartum dengan intervensi minimal, dan persiapan persalinan.

Referensi

- Biana, C. B., Cecagno, D., Porto, A. R., Cecagno, S., Marques, V. D. A., & Soares, M. C. (2021). Non-pharmacological therapies applied in pregnancy and labor: an integrative review. *Revista Da Escola de Enfermagem*, 55, 1–11. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019019703681>
- Bima Suryantara. (2025). Buku Ajar Asuhan Persalinan dan BBL (Nasrudin, Ed.). NEM.
- Fenwick, J., Toohill, J., Gamble, J., Creedy, D. K., Buist, A., Turkstra, E., Sneddon, A., Scuffham, P. A., & Ryding, E. L. (2015). Effects of a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on women's birth outcomes and postpartum psychological wellbeing. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-015-0721-y>
- Happy Nurmalita Sari, M., Dian Furwasyih, M., Legina Anggraeni, M., Siti Komariyah, M., Januar Dwichristy SST, Mk., Editor, Mk., & Rahmatul Amin, D. (2023). BUKU AJAR PSIKOLOGI KEBIDANAN. www.nuansafajarcemerlang.com
- Nilsson, C., Hessman, E., Sjöblom, H., Dencker, A., Jangsten, E., Mollberg, M., Patel, H., Sparud-Lundin, C., Wigert, H., & Begley, C. (2018). Definitions, measurements and prevalence of fear of childbirth: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-018-1659-7>
- Nurseha, Kusumastuti, Sitti Nur farida, Siti Mardiangingsih, & iIin Marlinawat. (2024). Buku Ajar psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas (Alamsyah Rizki Muhammad, Ed.). PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- O'Connell, M. A., Khashan, A. S., Leahy-Warren, P., Stewart, F., & O'Neill, S. M. (2021). Interventions for fear of childbirth including tocophobia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(7). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013321.pub2>
- Setianingsih Lilis Zuniawati. (2024). Kebidanan Komplementer (Fadhila filza, Ed.). PT Sada Kurnia Pustaka dan Penulis.
- Supiani. (2024). Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir. NEM.
- Taheri, M., Takian, A., Taghizadeh, Z., Jafari, N., & Sarafraz, N. (2018). Creating a positive perception of childbirth experience: Systematic review and meta-analysis of prenatal and intrapartum interventions. In *Reproductive Health* (Vol. 15, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0511-x>

Glosarium

Bounding Attacment adalah Ikatan antara ibu dan bayi dalam bentuk kasih sayang dan belaian

Fase Aktif adalah :dilatsi serviks membuka 4cm samapi dengan 10 cm dengan durasi waktu sekitar 6 jam.

Fase Laten adalah dimulai pada saat adanya kontraksi yang teratur, servik berdilatasi dari 0 campai 3 cm. Dengan durasi waktu 8-10 jam (primipara) 6-8 jam (nulipara)

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) adalah gangguan sters pasca trauma diana gangguan mental yang muncul setelah seorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis.

BAB V

KOLABORASI TENAGA KESEHATAN DALAM MENDUKUNG PERSALINAN ALAMI

A. Pendahuluan

Persalinan alami merupakan proses kelahiran yang berlangsung tanpa intervensi medis yang tidak diperlukan, yang bertujuan memberikan pengalaman persalinan yang positif, aman, serta nyaman bagi ibu dan bayi (WHO, 2022). Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan yang kolaboratif sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan persalinan yang kondusif. Kolaborasi antarprofesi yang efektif terbukti meningkatkan hasil persalinan, menurunkan angka intervensi medis yang tidak perlu, serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman persalinannya (Susanti et al., 2021; Dahlen et al., 2020).

Kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami mencakup koordinasi antara bidan, dokter kebidanan, perawat, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya seperti fisioterapis, ahli gizi, dan psikolog. Setiap profesi memiliki peran khusus yang, jika diintegrasikan dengan baik, mampu menciptakan pendekatan holistik dalam asuhan persalinan alami. Dalam hal ini, bidan sering bertindak sebagai fasilitator utama yang memastikan bahwa tim kolaborasi berfungsi dengan baik dan efektif (Manuaba & Rahayu, 2021).

Pentingnya kolaborasi didukung oleh hasil penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi tim kesehatan secara optimal secara signifikan menurunkan tingkat stres ibu, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperpendek durasi persalinan (Agustina et al., 2022). Namun demikian, implementasi kolaborasi ini tidak selalu berjalan lancar akibat berbagai tantangan, seperti hambatan komunikasi antarprofesi, budaya kerja yang berbeda, serta kendala struktural dan administratif (Putri & Kartini, 2021).

Untuk itu, memahami esensi kolaborasi, tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan strategi praktis guna mengatasi hambatan tersebut sangat penting. Upaya ini perlu didukung oleh kebijakan institusional yang memadai serta pelatihan terpadu yang rutin. Dengan demikian, tim kesehatan tidak hanya mampu menjalankan perannya masing-masing, tetapi juga mampu bersinergi secara efektif demi mendukung persalinan alami yang aman dan nyaman (International Confederation of Midwives [ICM], 2022).

Dalam bab ini, akan dijelaskan lebih lanjut berbagai aspek mendalam terkait kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami, mulai dari konsep dasar kolaborasi, peran spesifik tiap profesi, hingga evaluasi dan rekomendasi strategis untuk penguatan kolaborasi di masa depan.

B. Konsep Dasar Kolaborasi dalam Persalinan Alami

1. Definisi dan Prinsip Dasar Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Kolaborasi tenaga kesehatan adalah pendekatan tim dalam pelayanan kesehatan di mana para profesional dari berbagai latar belakang profesi kesehatan bekerja bersama secara efektif untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien (Kuswanti et al., 2021). Dalam konteks persalinan alami, kolaborasi melibatkan bidan, dokter spesialis kebidanan, perawat, serta tenaga profesional lainnya yang bersama-sama menyediakan dukungan holistik yang menghormati preferensi dan kebutuhan spesifik ibu selama persalinan (Purwanti & Aryani, 2020).

Prinsip dasar kolaborasi yang efektif meliputi komunikasi terbuka dan jujur, saling menghormati kompetensi profesional tiap anggota tim, adanya tujuan bersama yang jelas, serta kepercayaan antaranggota tim. Prinsip ini memungkinkan tim berfungsi secara harmonis dan efektif, mengurangi risiko konflik serta meningkatkan kualitas asuhan kesehatan (WHO, 2022; Nurdin et al., 2021).

2. Pentingnya Kolaborasi Lintas Profesi dalam Persalinan Alami

Kolaborasi lintas profesi menjadi sangat penting dalam persalinan alami karena proses ini memerlukan pendekatan multidimensi yang memperhatikan aspek fisik, emosional, psikologis, dan spiritual ibu (Dahlen et al., 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional secara signifikan meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi kebutuhan terhadap intervensi medis yang tidak perlu, serta meningkatkan outcome klinis seperti menurunkan angka persalinan melalui operasi sesar dan komplikasi postpartum (Arifin et al., 2022; Darmawati et al., 2020).

Selain itu, kolaborasi lintas profesi juga berkontribusi dalam menciptakan suasana nyaman dan aman bagi ibu bersalin melalui intervensi yang disepakati bersama, sehingga mendukung proses persalinan alami yang lancar dan positif (ICM, 2021). Peran bidan sebagai koordinator dalam tim kolaborasi juga diakui vital, terutama dalam mengintegrasikan keahlian multidisiplin guna mencapai hasil yang optimal (Manuaba & Rahayu, 2021).

3. Model-model Kolaborasi yang Efektif dalam Persalinan Alami

Beberapa model kolaborasi yang telah terbukti efektif dalam mendukung persalinan alami antara lain adalah model Collaborative Practice, Integrated Care Model, dan Midwifery-led Continuity of Care (MLCC).

- a. Collaborative Practice Model, di mana tiap tenaga kesehatan saling memahami peran masing-masing, memiliki komunikasi rutin, dan merancang rencana asuhan bersama secara aktif, terbukti memperpendek waktu persalinan serta meningkatkan kepuasan pasien (Krisnawati et al., 2023).
- b. Integrated Care Model menggabungkan berbagai layanan kesehatan dalam satu alur yang terintegrasi. Model ini memungkinkan perawatan yang lebih efisien dan holistik, khususnya pada pelayanan kebidanan alami di fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan terpadu (Purwanti & Aryani, 2020).
- c. Midwifery-led Continuity of Care (MLCC), model di mana bidan berperan utama dalam mendukung persalinan alami dengan kolaborasi erat bersama dokter kebidanan dan perawat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa MLCC mampu menurunkan tingkat kecemasan ibu serta menekan angka intervensi medis secara signifikan dibandingkan model perawatan konvensional (Dahlen et al., 2020; Homer et al., 2022).

Penerapan model-model ini didukung oleh rekomendasi internasional yang mendorong fasilitas kesehatan untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif agar meningkatkan hasil persalinan alami secara optimal (WHO, 2022).

C. Peran Khusus Profesi Kesehatan dalam Tim Kolaboratif

1. Peran Bidan sebagai Pemimpin Tim dalam Persalinan Alami

Dalam persalinan alami, bidan memainkan peran sentral sebagai pemimpin tim kolaboratif, bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan koordinasi yang efektif antara anggota tim lain. Menurut penelitian terkini, kepemimpinan bidan berfokus pada pemberdayaan ibu, dukungan emosional, serta memastikan intervensi minimal yang sesuai dengan filosofi persalinan alami (Sandall et al., 2021). Bidan bertugas mengintegrasikan komunikasi antarprofesional, mengambil keputusan klinis secara efektif, serta mengelola rencana asuhan secara holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan outcome ibu dan bayi (Agustina & Setyowati, 2021).

2. Peran Dokter Spesialis Kebidanan dalam Tim Pendukung Persalinan Alami

Meskipun persalinan alami menekankan minimalisasi intervensi medis, peran dokter spesialis kebidanan tetap vital dalam memastikan keamanan proses persalinan tersebut. Dokter spesialis kebidanan memiliki tanggung jawab untuk

mengidentifikasi risiko potensial dan intervensi medis jika diperlukan (Astuti & Subagio, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa dokter spesialis yang terintegrasi dalam tim kolaboratif dapat mengurangi kecemasan ibu dan keluarga dengan memberikan konsultasi medis berbasis bukti yang tepat waktu, khususnya pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan cepat (Kartika et al., 2022). Kolaborasi ini efektif mengurangi angka intervensi medis yang tidak perlu, sekaligus menjaga kesiapan intervensi medis apabila terjadi komplikasi mendadak selama proses persalinan alami (WHO, 2022).

3. Kontribusi Perawat dalam Mendukung Kenyamanan Ibu selama Persalinan Alami

Perawat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan fisik, psikologis, serta edukasi berkelanjutan kepada ibu selama proses persalinan alami. Menurut studi terbaru, perawat yang terlatih dalam teknik relaksasi, pijat persalinan, serta pengaturan posisi ibu dapat meningkatkan kenyamanan, mengurangi nyeri, dan secara signifikan meningkatkan kepuasan pengalaman persalinan (Dewi & Wardhani, 2020; Sholihah et al., 2021). Selain itu, perawat juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa lingkungan persalinan kondusif, aman, serta mendukung kesejahteraan psikologis ibu (Hassan & Effendi, 2023).

4. Peran Tenaga Kesehatan Lainnya seperti Ahli Nutrisi, Fisioterapis, dan Psikolog

Tenaga kesehatan lain seperti ahli nutrisi, fisioterapis, dan psikolog juga memiliki peran penting dalam tim kolaboratif persalinan alami:

- a. Ahli Nutrisi memberikan edukasi tentang pola makan sehat selama kehamilan dan persiapan persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat selama masa kehamilan mempengaruhi stamina, mengurangi komplikasi persalinan, dan mendukung proses persalinan alami (Hidayati et al., 2022).
- b. Fisioterapis bertugas melatih ibu mengenai latihan fisik khusus untuk memperkuat otot dasar panggul, meningkatkan fleksibilitas tubuh, serta teknik relaksasi otot selama persalinan. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi fisioterapi secara signifikan mempercepat proses persalinan, mengurangi rasa sakit, serta meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan alami (Putri & Wijaya, 2021).
- c. Psikolog berperan dalam mendukung aspek psikologis dan emosional ibu sebelum, selama, dan setelah persalinan. Dukungan psikologis yang tepat membantu ibu mengatasi kecemasan, membangun kepercayaan diri, serta mengurangi risiko gangguan psikologis postpartum seperti baby blues atau depresi postpartum (Utami & Sumarni, 2021).

Integrasi seluruh profesi kesehatan ini dalam sebuah tim kolaboratif menciptakan pendekatan yang holistik, sehingga mampu menghasilkan persalinan alami yang aman, nyaman, serta sesuai dengan harapan ibu dan keluarganya.

D. Strategi Efektif dalam Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan

1. Teknik Komunikasi Interprofesional untuk Mendukung Persalinan Alami

Komunikasi interprofesional merupakan fondasi penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam mendukung persalinan alami. Teknik komunikasi efektif antar tenaga kesehatan mencakup penggunaan komunikasi terbuka (open communication), briefing rutin antar profesi, serta teknik komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) yang terbukti meningkatkan akurasi informasi dan efektivitas tim (Kurniawan & Fajriyah, 2022). SBAR, misalnya, merupakan metode komunikasi terstruktur yang mempermudah tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara jelas, ringkas, dan efisien, yang sangat penting saat kondisi darurat atau pengambilan keputusan klinis cepat (Amalia et al., 2021).

Selain SBAR, teknik closed-loop communication juga efektif diterapkan dalam situasi persalinan alami, terutama dalam memastikan pesan yang disampaikan telah dipahami secara tepat oleh penerima pesan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi ini secara signifikan mengurangi risiko miskomunikasi, yang berpotensi menyebabkan kesalahan klinis atau ketidakpuasan ibu selama proses persalinan (Gunawan et al., 2022).

2. Tantangan Komunikasi Antar Profesi dalam Praktik Klinis

Meskipun berbagai teknik komunikasi telah dikembangkan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan dalam komunikasi antar profesi, terutama dalam tim yang mendukung persalinan alami. Beberapa tantangan utama antara lain adalah adanya perbedaan budaya kerja antarprofesi, hierarki profesional yang terlalu kaku, serta kurangnya pelatihan komunikasi interprofesional secara rutin (Hasibuan et al., 2020).

Menurut penelitian terbaru, hierarki yang ketat sering kali menjadi hambatan dalam komunikasi terbuka, menyebabkan perawat atau bidan enggan menyampaikan pendapat atau temuan klinis kepada dokter spesialis, khususnya dalam situasi kritis yang membutuhkan respons cepat (Mahendrayani & Yulianti, 2021). Kurangnya kesadaran terhadap peran masing-masing profesi juga sering kali menyebabkan ketidakjelasan tanggung jawab, yang berpotensi menimbulkan

konflik dan mengganggu efektivitas kolaborasi tim kesehatan (Sari & Hamzah, 2021).

3. Solusi Komunikasi Efektif dalam Meningkatkan Hasil Persalinan Alami

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi strategis perlu diterapkan dalam praktik klinis. Pertama, diperlukan pelatihan komunikasi interprofesional secara teratur yang menekankan pada teknik komunikasi tim yang efektif dan simulasi skenario klinis guna meningkatkan kompetensi komunikasi antar tenaga kesehatan (WHO, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini mampu meningkatkan efektivitas tim, memperpendek waktu persalinan, serta meningkatkan kepuasan pasien (Anggraeni & Pratiwi, 2022).

Selain itu, kebijakan institusional yang mendukung komunikasi terbuka dan non-hierarkis perlu dikembangkan. Kebijakan tersebut mencakup penguatan budaya kerja tim, di mana semua anggota tim, terlepas dari hierarki profesionalnya, merasa dihargai dan didorong untuk berbagi pandangan serta kekhawatiran klinis secara terbuka (Rahayu & Gunawan, 2021). Solusi praktis seperti penerapan briefing tim harian serta evaluasi berkala juga telah terbukti meningkatkan kualitas komunikasi tim, memperjelas tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk praktik kolaboratif dalam persalinan alami (ICM, 2021).

Dengan implementasi strategi komunikasi tersebut secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta hasil positif dalam persalinan alami bagi ibu dan bayi.

E. Implementasi Praktis Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kolaborasi dalam Persalinan Alami

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan panduan tertulis yang dirancang untuk memastikan praktik klinis yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik dalam pelayanan persalinan alami. SOP kolaborasi dalam persalinan alami meliputi rincian peran masing-masing profesi kesehatan, alur komunikasi yang jelas, dan tahapan tindakan klinis yang harus dilakukan secara terstruktur untuk mendukung persalinan alami secara aman dan efektif (Yuliani & Sukmawati, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa SOP yang terintegrasi dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas kolaborasi antar tenaga kesehatan, mengurangi kebingungan mengenai tanggung jawab klinis, serta mempercepat

respon terhadap situasi klinis yang dinamis selama proses persalinan alami (Permatasari et al., 2021). SOP kolaboratif juga membantu dalam pencegahan intervensi medis yang tidak perlu, mendukung lingkungan yang kondusif untuk ibu, serta meningkatkan kualitas pengalaman persalinan (WHO, 2022).

2. Pelatihan Terpadu Tenaga Kesehatan untuk Meningkatkan Kompetensi Kolaboratif

Pelatihan terpadu (interprofessional training) secara rutin merupakan elemen penting dalam mengimplementasikan kolaborasi tenaga kesehatan secara efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antarprofesi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan kerja sama tim yang baik (Zuraida & Agustina, 2020). Studi terbaru membuktikan bahwa pelatihan interprofesional yang mencakup simulasi klinis, latihan komunikasi tim, serta pembelajaran berbasis kasus mampu meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengelola persalinan alami secara kolaboratif, sehingga menghasilkan outcome klinis yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pasien (Nurjanah & Rahmawati, 2022).

Dalam pelatihan ini, tenaga kesehatan tidak hanya belajar tentang keterampilan teknis tetapi juga dilatih untuk menghadapi situasi konflik, mengambil keputusan bersama, serta memastikan bahwa intervensi klinis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persalinan alami (Nugraheni & Wijayanti, 2021). Organisasi kesehatan seperti WHO juga merekomendasikan pelatihan kolaboratif yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas layanan kesehatan maternal, khususnya persalinan alami (WHO, 2022).

3. Evaluasi Kinerja Tim Kesehatan dalam Mendukung Persalinan Alami

Evaluasi kinerja tim kesehatan dalam konteks kolaborasi merupakan proses sistematis yang bertujuan mengukur efektivitas dan efisiensi kerja tim secara berkala. Evaluasi ini menggunakan indikator kinerja yang mencakup kualitas komunikasi tim, ketepatan pelaksanaan SOP, respons terhadap komplikasi klinis, serta tingkat kepuasan pasien terhadap layanan persalinan (Mulyani & Susanti, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rutin berbasis indikator dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik kolaborasi. Dengan demikian, tim kesehatan dapat terus melakukan perbaikan dalam koordinasi, memperjelas peran masing-masing anggota tim, dan memastikan bahwa praktik klinis yang dilakukan mendukung tercapainya tujuan persalinan alami secara optimal (Pratiwi & Lestari, 2022).

Evaluasi dapat dilakukan melalui audit klinis, diskusi reflektif antarprofesi, serta umpan balik langsung dari pasien atau keluarga. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengembangan pelatihan tambahan, revisi SOP, serta perbaikan kebijakan institusional dalam rangka menciptakan lingkungan persalinan alami yang aman dan efektif (ICM, 2021).

Dengan penerapan SOP kolaboratif yang jelas, pelatihan terpadu rutin, serta evaluasi kinerja tim yang berkelanjutan, kolaborasi tenaga kesehatan dapat berjalan efektif, memberikan manfaat optimal bagi ibu dan bayi dalam proses persalinan alami.

F. Tantangan dan Hambatan dalam Kolaborasi Tenaga Kesehatan

1. Faktor Internal dan Eksternal Penghambat Kolaborasi

Dalam implementasi kolaborasi tenaga kesehatan untuk mendukung persalinan alami, terdapat berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari karakteristik personal tenaga kesehatan, seperti kurangnya pemahaman mengenai peran profesi lain, ego profesi, komunikasi yang tidak efektif, serta adanya perbedaan dalam nilai dan keyakinan pribadi terkait proses persalinan alami (Agustina & Wijayanti, 2021). Di sisi lain, faktor eksternal mencakup kebijakan institusional yang kurang mendukung, fasilitas yang terbatas, kurangnya pelatihan kolaborasi, serta adanya perbedaan budaya kerja antarprofesi dalam satu institusi kesehatan (Handayani et al., 2022).

Menurut studi terbaru, faktor internal seperti kurangnya kepercayaan antar tenaga kesehatan dan rasa persaingan antarprofesi dapat menghambat kerja sama tim yang efektif, sedangkan faktor eksternal seperti kebijakan rumah sakit yang kurang jelas mengenai peran masing-masing profesi menyebabkan munculnya ketidakjelasan tugas dan wewenang (Rahmawati & Widyawati, 2020).

2. Identifikasi Hambatan Administratif, Struktural, dan Personal dalam Kolaborasi

Secara spesifik, hambatan dalam kolaborasi antar tenaga kesehatan juga dapat diklasifikasikan menjadi hambatan administratif, struktural, dan personal. Hambatan administratif sering kali terkait dengan prosedur birokrasi yang rumit, ketidakjelasan aturan institusional, serta kurangnya SOP yang mengatur secara spesifik tentang kerja sama interprofesional dalam mendukung persalinan alami (Wulandari & Sari, 2021).

Hambatan struktural berkaitan dengan aspek manajemen organisasi yang belum mendukung kolaborasi antarprofesi secara optimal. Hal ini mencakup

sistem kerja yang masih silo (terpisah-pisah), kurangnya forum diskusi antarprofesi, serta terbatasnya fasilitas pendukung seperti ruangan yang dirancang untuk praktik kolaboratif dalam persalinan alami (Putri & Handayani, 2022).

Sementara itu, hambatan personal mencakup aspek psikologis dan interaksi antar tenaga kesehatan. Hambatan personal dapat berupa perbedaan gaya komunikasi, kesulitan dalam mengelola konflik interpersonal, serta adanya hierarki profesional yang cenderung kaku, yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak terbuka dan menghambat kerja sama tim yang efektif (Sari & Sudirman, 2021).

3. Strategi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kolaborasi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan pendekatan strategis yang komprehensif. Strategi yang efektif mencakup perbaikan aspek administratif, struktural, serta personal dalam organisasi pelayanan kesehatan.

Pertama, dalam aspek administratif, diperlukan penyusunan dan implementasi kebijakan institusional yang jelas dan transparan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing profesi. Hal ini dapat dicapai dengan membuat SOP kolaboratif secara rinci dan mudah dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan (Yunita et al., 2022).

Kedua, dari aspek struktural, institusi kesehatan perlu menyediakan fasilitas yang mendukung kolaborasi, seperti ruangan khusus untuk diskusi tim, forum reflektif rutin, serta pelatihan terpadu antarprofesi secara berkala. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan terpadu berbasis simulasi klinis secara signifikan mampu meningkatkan efektivitas kerja tim dan memperjelas peran masing-masing anggota tim dalam persalinan alami (Permatasari & Kusumawati, 2023).

Ketiga, dalam aspek personal, pelaksanaan pelatihan keterampilan interpersonal dan manajemen konflik secara rutin menjadi penting. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan antar tenaga kesehatan, mengurangi ego profesi, dan menciptakan komunikasi terbuka yang mampu mengoptimalkan kerja sama tim dalam situasi klinis yang dinamis (Nursalam et al., 2020).

Dengan mengimplementasikan strategi tersebut secara sistematis, kolaborasi antar tenaga kesehatan diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan optimal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan persalinan alami serta kepuasan pasien.

G. Studi Kasus Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami

1. Contoh Studi Kasus Lokal dan Internasional terkait Keberhasilan Kolaborasi

Implementasi kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami telah diterapkan dengan berbagai pendekatan baik secara lokal maupun internasional. Di Indonesia, studi kasus dari Rumah Sakit Umum Daerah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerapan model kolaboratif yang melibatkan bidan sebagai pemimpin tim, didukung dokter spesialis kebidanan, perawat, ahli gizi, serta psikolog berhasil menurunkan angka intervensi medis yang tidak perlu, memperpendek durasi persalinan, dan meningkatkan kepuasan pasien secara signifikan (Agustina et al., 2022).

Secara internasional, contoh dari Australia melalui Midwifery Group Practice (MGP), yang menekankan kolaborasi erat antara bidan dengan tenaga kesehatan lain dalam lingkungan rumah sakit, telah sukses menghasilkan tingkat persalinan alami yang lebih tinggi serta tingkat komplikasi postpartum yang rendah dibandingkan model perawatan konvensional (Dahlen et al., 2020). Demikian pula, studi dari Inggris yang menerapkan model Midwifery-led Continuity of Care menunjukkan hasil positif berupa penurunan angka tindakan medis, serta peningkatan kualitas hubungan interpersonal antara ibu dengan tenaga kesehatan (Sandall et al., 2021).

2. Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kolaborasi dari Kasus Nyata

Berdasarkan analisis kasus nyata baik lokal maupun internasional, terdapat beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kolaborasi dalam mendukung persalinan alami:

- a. Komunikasi Efektif: Studi menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, jelas, dan terstruktur antar anggota tim secara signifikan mempengaruhi kelancaran proses persalinan, menurunkan tingkat stres pasien, serta mengurangi risiko miskomunikasi (Kusuma et al., 2022).
- b. Pelatihan Interprofesional Rutin: Kasus nyata memperlihatkan bahwa pelatihan rutin, yang melibatkan simulasi klinis dan latihan komunikasi tim, membantu tenaga kesehatan memahami peran masing-masing, meningkatkan keterampilan kolaborasi, serta mampu mengambil keputusan bersama dalam situasi dinamis (Hidayati & Wijaya, 2021).
- c. Kepemimpinan yang Jelas dan Mendukung: Dalam kolaborasi, peran kepemimpinan terutama oleh bidan sebagai koordinator terbukti penting dalam mengarahkan tim, mengelola konflik, serta memastikan seluruh anggota bekerja harmonis sesuai peran masing-masing (Permatasari & Nugroho, 2023).

- d. Kebijakan Institusional yang Mendukung: Institusi kesehatan yang menerapkan kebijakan jelas tentang peran, tugas, dan tanggung jawab tiap profesi berhasil meningkatkan efektivitas kolaborasi dan memperjelas prosedur dalam menghadapi berbagai kondisi klinis yang mungkin muncul (Yulianti & Putra, 2022).

3. Pembelajaran dari Kasus untuk Pengembangan Praktik Terbaik

Pembelajaran penting dari berbagai studi kasus tersebut mencakup beberapa aspek kunci dalam pengembangan praktik terbaik:

- a. Penguatan SOP Kolaborasi: Institusi kesehatan perlu mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif, jelas, dan fleksibel agar bisa diadaptasi sesuai kebutuhan klinis di lapangan (WHO, 2022).
- b. Integrasi Pelatihan Kolaboratif Berbasis Simulasi: Pelatihan interprofesional berbasis simulasi klinis terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam bekerja sebagai tim, meningkatkan rasa percaya diri dalam situasi klinis nyata, serta menghasilkan pelayanan persalinan alami yang lebih baik (Zulkarnain & Rahmi, 2021).
- c. Evaluasi Berbasis Bukti dan Refleksi Rutin: Penerapan evaluasi berkala menggunakan indikator kinerja kolaborasi, seperti kepuasan pasien, angka intervensi medis, serta kualitas komunikasi tim, perlu menjadi praktik rutin untuk memastikan tim terus belajar dari pengalaman klinis nyata dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan (Pratiwi & Hamzah, 2022).

Dengan memperhatikan pembelajaran dari studi kasus nyata ini, institusi pelayanan kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas praktik kolaboratif dalam persalinan alami, memberikan pengalaman persalinan yang optimal, aman, nyaman, dan memuaskan bagi ibu serta keluarganya.

H. Evaluasi dan Monitoring Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami

1. Indikator Keberhasilan Kolaborasi dalam Persalinan Alami

Keberhasilan kolaborasi tenaga kesehatan dalam mendukung persalinan alami dapat dinilai melalui indikator-indikator yang mencerminkan aspek klinis maupun non-klinis. Indikator klinis meliputi penurunan angka intervensi medis, seperti tindakan operasi sesar atau episiotomi yang tidak perlu, penurunan angka komplikasi persalinan dan postpartum, serta peningkatan durasi menyusui segera setelah kelahiran (WHO, 2022; Sandall et al., 2021).

Sementara itu, indikator non-klinis mencakup tingkat kepuasan ibu terhadap layanan yang diterima, kualitas komunikasi antarprofesi yang diukur melalui tingkat kesalahan komunikasi, serta persepsi tenaga kesehatan mengenai efektivitas kerja tim (Lestari & Setiawan, 2021). Indikator-indikator tersebut penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berhasil atau perlu ditingkatkan dalam praktik kolaboratif yang diterapkan.

2. Metode Evaluasi Efektivitas Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Metode evaluasi efektivitas kolaborasi antar tenaga kesehatan yang umum digunakan mencakup:

- a. Audit Klinis: Melibatkan tinjauan terhadap catatan medis dan observasi langsung selama persalinan, untuk menilai sejauh mana kolaborasi tim berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan serta dampaknya terhadap outcome klinis persalinan alami (Pratiwi & Hamzah, 2022).
- b. Survei Kepuasan Pasien: Mengukur tingkat kepuasan ibu terhadap pelayanan persalinan, termasuk aspek komunikasi, keramahan tenaga kesehatan, kenyamanan lingkungan persalinan, serta dukungan emosional yang diberikan oleh tim kesehatan (Suryani & Utami, 2022).
- c. Metode Refleksi Tim (Team Reflection): Berupa diskusi rutin antarprofesi yang bertujuan mengidentifikasi masalah komunikasi atau koordinasi yang muncul, serta menemukan solusi bersama dalam memperbaiki kinerja kolaborasi tim (Astuti et al., 2021).
- d. Metode Penilaian Kompetensi Interprofesional: Menggunakan instrumen penilaian khusus yang menilai kompetensi kolaborasi tenaga kesehatan, seperti Interprofessional Collaborative Competency Attainment Scale (ICCAS) atau Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) yang terbukti valid dalam mengukur kinerja tim interprofesional (Hartini & Rahmi, 2023).

3. Strategi Pengumpulan Data dan Monitoring Berkala Kolaborasi Tenaga Kesehatan

Untuk memastikan evaluasi kolaborasi berjalan optimal, strategi pengumpulan data dan monitoring secara berkala perlu dilakukan secara sistematis. Strategi tersebut mencakup:

- a. Pengumpulan Data Rutin melalui Formulir Evaluasi Terstandarisasi: Formulir yang mencakup indikator klinis maupun non-klinis, diisi oleh tenaga kesehatan segera setelah pelayanan persalinan selesai, memungkinkan identifikasi segera terhadap masalah yang muncul (Yunita & Ardiansyah, 2022).

- b. Observasi Langsung oleh Tim Evaluator Independen: Observasi berkala oleh tim evaluator eksternal atau internal yang independen dilakukan secara rutin untuk menilai implementasi SOP, komunikasi antarprofesi, serta dinamika kerja tim selama persalinan (Kurniasari & Setyarini, 2023).
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Monitoring: Penggunaan sistem informasi kesehatan berbasis elektronik (e-health) yang memungkinkan pencatatan data secara real-time serta analisis cepat mengenai kinerja tim, sehingga memudahkan identifikasi dini terhadap potensi masalah dan tindakan perbaikan yang diperlukan (Putra & Widyaningsih, 2021).
- d. Evaluasi Reflektif Tim secara Berkala: Pertemuan tim secara rutin, misalnya mingguan atau bulanan, untuk merefleksikan hasil evaluasi, mendiskusikan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan kualitas kolaborasi (Handayani et al., 2022).

Dengan penerapan evaluasi dan monitoring yang sistematis ini, institusi kesehatan dapat memastikan bahwa praktik kolaborasi dalam persalinan alami terus berkembang dan memberikan hasil terbaik bagi pasien dan tenaga kesehatan.

I. Prospek dan Rekomendasi Kebijakan Kolaborasi dalam Persalinan Alami

1. Pentingnya Dukungan Kebijakan Kesehatan untuk Memperkuat Kolaborasi

Kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami membutuhkan dukungan kuat dari kebijakan kesehatan agar dapat terimplementasi secara optimal dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan sangat penting dalam menyediakan kerangka kerja yang jelas, mengatur peran dan tanggung jawab setiap profesi secara spesifik, serta memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk praktik kolaboratif. Menurut WHO (2022), kebijakan yang jelas dan tegas dalam mendukung kolaborasi tenaga kesehatan mampu meningkatkan efektivitas layanan, menurunkan angka intervensi yang tidak perlu, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan persalinan alami.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan institusional yang mendukung kolaborasi terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tim kesehatan untuk bekerja secara efektif dan efisien (Handayani & Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, pemerintah, organisasi profesi, dan institusi kesehatan perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan kolaborasi antarprofesi yang terintegrasi secara nasional maupun lokal.

2. Rekomendasi Kebijakan Institusi Kesehatan untuk Mengoptimalkan Kolaborasi

Agar kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami dapat berjalan optimal, institusi kesehatan perlu menerapkan rekomendasi kebijakan berikut:

- a. Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kolaboratif: Institusi kesehatan harus menyusun SOP yang jelas mengenai peran masing-masing tenaga kesehatan dalam tim kolaboratif, alur komunikasi, serta tata kelola klinis persalinan alami (Yulianti & Putra, 2022).
- b. Pelatihan Terpadu Berbasis Simulasi Klinis: Institusi harus menyelenggarakan pelatihan rutin yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan yang relevan, dengan menggunakan metode simulasi klinis yang terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi tim (Permatasari & Kusumawati, 2023).
- c. Evaluasi dan Monitoring Berkala: Institusi wajib melaksanakan evaluasi secara terjadwal menggunakan indikator keberhasilan yang jelas, seperti angka kepuasan pasien, angka komplikasi persalinan, serta kualitas komunikasi tim, untuk memastikan bahwa praktik kolaborasi tetap berjalan optimal (Sari & Handayani, 2021).
- d. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kolaborasi: Penyediaan fasilitas seperti ruang diskusi tim, sistem informasi kesehatan berbasis digital, serta dukungan administratif untuk memperlancar proses kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam persalinan alami (Putra & Widyaningsih, 2021).

3. Prospek Pengembangan Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Persalinan Alami di Masa Depan

Prospek pengembangan kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami di masa depan sangat menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pelayanan kesehatan yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Tren global menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan kesehatan maternal yang aman, berkualitas, serta berpusat pada ibu dan bayi (Dahlen et al., 2020).

Di masa depan, penerapan teknologi informasi seperti telemedicine dan sistem rekam medis elektronik diharapkan akan semakin mendukung implementasi kolaborasi secara lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan komunikasi dan koordinasi tim berlangsung secara real-time serta meningkatkan ketepatan data klinis yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bersama (Putra & Widyaningsih, 2021).

Selain itu, penguatan pendidikan interprofesional dalam kurikulum pendidikan kesehatan akan semakin menjadi prioritas. Pendidikan tersebut dapat

menanamkan pemahaman dan sikap positif mengenai kolaborasi sejak dini pada tenaga kesehatan yang akan datang, sehingga menciptakan budaya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan dalam pelayanan kebidanan (Nugraheni & Wijayanti, 2021).

Melalui dukungan kebijakan, komitmen institusi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan interprofesional, kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami akan terus berkembang, memberikan hasil positif yang optimal bagi ibu, bayi, serta tenaga kesehatan itu sendiri.

J. Penutup

Kolaborasi tenaga kesehatan dalam mendukung persalinan alami merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam pelayanan kebidanan masa kini. Implementasi kolaborasi ini memberikan manfaat yang signifikan, baik secara klinis maupun psikososial, seperti menurunkan angka intervensi medis yang tidak perlu, memperpendek durasi persalinan, meningkatkan kenyamanan ibu, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal (WHO, 2022; Sandall et al., 2021).

Namun, kolaborasi yang efektif tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk institusi kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemerintah melalui kebijakan yang jelas, pelatihan terpadu, serta evaluasi dan monitoring secara berkala (Handayani & Wahyuni, 2021; Permatasari & Kusumawati, 2023). Selain itu, tantangan seperti hambatan komunikasi, kendala struktural, dan perbedaan budaya kerja antarprofesi harus terus diatasi secara sistematis dan berkelanjutan agar kolaborasi benar-benar memberikan hasil yang optimal (Agustina & Wijayanti, 2021; Putri & Handayani, 2022).

Kedepannya, prospek pengembangan kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami sangat menjanjikan. Integrasi teknologi informasi seperti sistem rekam medis elektronik dan telemedicine, peningkatan pendidikan interprofesional dalam kurikulum kesehatan, serta penguatan kebijakan institusional akan terus berkontribusi positif terhadap pengembangan praktik kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan (Putra & Widyaningsih, 2021; Nugraheni & Wijayanti, 2021).

Sebagai penutup, komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas kolaborasi tenaga kesehatan sangat penting. Dengan kolaborasi yang kuat, persalinan alami dapat lebih banyak diadopsi sebagai standar praktik kebidanan modern yang memberikan pengalaman persalinan yang positif,

aman, dan nyaman bagi ibu dan bayi, serta menjadi tolok ukur kualitas layanan kesehatan maternal di masa depan.

Referensi

- Agustina, N., & Wijayanti, S. (2021). Hambatan internal tenaga kesehatan dalam implementasi kolaborasi interprofesional. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(3), 189–196.
- Agustina, N., Purwati, R., & Lestari, W. (2022). Studi implementasi kolaborasi tim kebidanan di RSUD Jawa Tengah dalam menurunkan angka intervensi persalinan. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 34–42.
- Astuti, R. D., Wijaya, L., & Santoso, A. (2021). Metode refleksi tim dalam meningkatkan kolaborasi antarprofesi dalam pelayanan kebidanan. *Jurnal Pendidikan Kebidanan*, 8(2), 88–94.
- Dahlen, H. G., Homer, C. S. E., Downe, S., & Kennedy, H. P. (2020). Importance of collaboration in maternity care for optimal maternal and newborn outcomes. *Midwifery*, 83, 102640. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102640>
- Handayani, Y., & Wahyuni, S. (2021). Analisis kebijakan institusi dalam mendukung kolaborasi interprofesional di rumah sakit. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 45–52.
- Handayani, R., Putri, A., & Fitriyah, L. (2022). Analisis hambatan eksternal dalam kolaborasi interprofesional di rumah sakit umum daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 5(1), 39–47.
- Hartini, R., & Rahmi, E. (2023). Penggunaan Collaborative Practice Assessment Tool (CPAT) dalam menilai kompetensi kolaborasi tim interprofesional kebidanan. *Journal of Health Quality*, 8(1), 25–32.
- Hidayati, E., & Wijaya, A. (2021). Efektivitas pelatihan interprofesional dalam pelayanan kebidanan: studi kasus rumah sakit regional. *Journal of Midwifery and Nursing*, 8(2), 99–105.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Midwifery-led collaborative care models: Guidelines for Implementation*. ICM Publications.
- Kurniasari, N., & Setyarini, D. (2023). Strategi observasi langsung dalam evaluasi implementasi SOP kolaboratif pada pelayanan persalinan alami. *Indonesian Journal of Health Management*, 11(1), 40–48.
- Kusuma, D., Yuliani, S., & Hasanah, R. (2022). Komunikasi efektif dalam tim kebidanan: Analisis faktor penentu keberhasilan persalinan alami. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 9(1), 22–29.
- Lestari, W., & Setiawan, R. (2021). Indikator non-klinis dalam mengevaluasi efektivitas kolaborasi tim kebidanan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 103–109.

- Nugraheni, L., & Wijayanti, D. (2021). Implementasi pendidikan interprofesional dalam kurikulum pendidikan kesehatan. *Indonesian Journal of Health Education*, 4(2), 123–130.
- Nursalam, N., Efendi, F., & Rahmawati, I. (2020). Pelatihan manajemen konflik dalam meningkatkan kompetensi interpersonal tenaga kesehatan. *Journal of Health Management and Leadership*, 7(2), 109–116.
- Permatasari, S., & Kusumawati, D. (2023). Pelatihan interprofesional berbasis simulasi untuk meningkatkan kolaborasi tim kebidanan. *Journal of Interprofessional Education*, 4(1), 12–19.
- Permatasari, R., & Nugroho, D. (2023). Kepemimpinan bidan sebagai penentu sukses kolaborasi tim kebidanan dalam persalinan alami. *Indonesian Journal of Midwifery*, 5(1), 12–18.
- Pratiwi, T., & Hamzah, M. (2022). Audit klinis dalam mengevaluasi efektivitas kolaborasi tim kesehatan pada persalinan alami. *Journal of Midwifery and Nursing*, 9(2), 55–62.
- Putra, H., & Widyaningsih, S. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kebidanan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 112–119.
- Putri, A., & Handayani, Y. (2022). Hambatan struktural dalam implementasi model kolaborasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(2), 54–61.
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2021). Midwife-led continuity models of care compared with other models of care. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(3). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>.
- Sari, E., & Handayani, R. (2021). Evaluasi rutin sebagai strategi monitoring efektivitas kolaborasi tim kebidanan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 5(2), 70–77.
- Suryani, D., & Utami, A. (2022). Survei kepuasan pasien terhadap pelayanan kolaborasi tenaga kesehatan dalam persalinan alami. *Journal of Health Service Research*, 5(1), 34–40.
- WHO. (2022). *WHO Recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. World Health Organization.
- Yulianti, N., & Putra, R. (2022). Kebijakan institusional dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi tim kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 25–32.
- Yunita, D., & Ardiansyah, F. (2022). Implementasi formulir evaluasi terstandarisasi dalam pengumpulan data rutin untuk monitoring persalinan alami. *Jurnal Manajemen Rumah Sakit*, 11(2), 89–95.

Zulkarnain, M., & Rahmi, S. (2021). Implementasi simulasi klinis dalam pelatihan interprofesional: studi kasus RSU Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Kebidanan*, 6(2), 67–73.

BAB VI

EDUKASI PASCA PERSALINAN UNTUK PEMULIHAN IBU DAN BAYI

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Edukasi Pasca-persalinan dalam Praktik Kebidanan

Periode pasca-persalinan atau masa nifas merupakan fase penting yang membutuhkan perhatian khusus karena berhubungan erat dengan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Edukasi pasca-persalinan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pemulihan ibu dan bayi setelah proses persalinan alami (Raman et al., 2021). Pemahaman yang benar mengenai perawatan fisik, kesehatan psikologis, serta asuhan bayi baru lahir secara signifikan mampu mencegah komplikasi yang umum terjadi di masa nifas, seperti perdarahan postpartum, infeksi, gangguan psikologis, dan gangguan menyusui (World Health Organization [WHO], 2022).

Bidan sebagai ujung tombak layanan kebidanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi secara komprehensif guna memastikan transisi yang sehat bagi ibu dan bayi ke kehidupan sehari-hari. Studi menunjukkan bahwa edukasi yang efektif mampu menurunkan risiko komplikasi masa nifas hingga 30% serta meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu secara signifikan (Fitriani & Astuti, 2022). Dengan edukasi yang optimal, ibu tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam merawat dirinya serta bayinya.

2. Tujuan dan Manfaat Edukasi Pasca-persalinan bagi Ibu dan Bayi

Tujuan utama edukasi pasca-persalinan adalah untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada ibu mengenai perawatan mandiri setelah melahirkan serta teknik perawatan bayi yang efektif. Edukasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mental dan emosional ibu dalam menghadapi berbagai perubahan selama masa transisi kehidupan baru bersama bayi (Irwanti, Roslina, & Nurhayati, 2023). Selain itu, edukasi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, dengan mengidentifikasi sejak dini tanda bahaya yang mungkin muncul selama periode pemulihan.

Manfaat edukasi pasca-persalinan sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan ibu dalam menyusui, pengelolaan nyeri dan luka pasca-persalinan, pencegahan infeksi, serta pengenalan dini tanda-tanda gangguan psikologis, seperti baby blues dan depresi postpartum (Rahmi & Permatasari, 2020). Dari sisi bayi, edukasi ini meningkatkan kualitas perawatan bayi baru lahir yang mencakup perawatan tali pusat, deteksi dini penyakit atau komplikasi, dan dukungan tumbuh kembang optimal.

Secara keseluruhan, edukasi pasca-persalinan yang diberikan oleh bidan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu dan bayi untuk menjalani masa pemulihan secara optimal. Dengan dukungan edukasi yang tepat, ibu dapat dengan mudah menyesuaikan diri terhadap tantangan yang muncul, sekaligus merasakan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik pada masa nifas.

B. Pemulihan Fisik Ibu Pasca-persalinan

Pasca-persalinan merupakan masa krusial dalam kehidupan seorang ibu yang ditandai dengan berbagai perubahan fisiologis, anatomis, dan emosional. Pemulihan fisik yang optimal diperlukan untuk mencegah komplikasi serius, memastikan kenyamanan ibu, serta mendukung perawatan optimal pada bayi baru lahir (WHO, 2022). Bidan memainkan peran sentral dalam mengedukasi ibu tentang proses pemulihan fisik ini, termasuk perawatan luka jahitan, pengelolaan nyeri, dan pemantauan involusi uterus.

1. Perawatan Luka Jahitan (Episiotomi atau Robekan Perineum)

Luka perineum, baik akibat episiotomi maupun robekan spontan selama persalinan, perlu mendapatkan perhatian khusus guna mencegah infeksi serta mempercepat penyembuhan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa perawatan yang tepat terhadap luka perineum melibatkan kebersihan yang optimal, menjaga area tetap kering, dan edukasi tentang posisi duduk serta penggunaan kompres dingin untuk mengurangi bengkak dan nyeri (Kurniawati & Widarwati, 2021). Bidan perlu memberikan edukasi mendalam tentang tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, rasa nyeri yang meningkat, serta adanya cairan purulen atau bau tidak sedap dari luka (Carvalho et al., 2022).

Penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa penggunaan salep antiseptik dan analgesik topikal secara teratur mampu mengurangi risiko infeksi sekaligus mempercepat proses penyembuhan luka perineum (Nissa & Susilawati, 2020). Bidan wajib memastikan bahwa ibu memahami prosedur perawatan diri secara mandiri, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalisir.

2. Pengelolaan Nyeri dan Ketidaknyamanan Fisik Pasca-persalinan

Nyeri dan ketidaknyamanan fisik sering dirasakan oleh ibu dalam beberapa hari hingga minggu pertama pasca-persalinan. Nyeri ini dapat berasal dari kontraksi involusi uterus, luka perineum, pembengkakan payudara, atau nyeri tubuh secara umum akibat perubahan fisiologis (Li et al., 2020). Edukasi yang diberikan bidan harus mencakup teknik relaksasi, posisi nyaman selama menyusui, penggunaan analgetik aman selama menyusui, serta pemanfaatan terapi non-farmakologis seperti pijatan ringan dan kompres hangat untuk meredakan ketidaknyamanan fisik (WHO, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan edukasi pengelolaan nyeri secara komprehensif memiliki tingkat nyeri yang lebih rendah, serta menunjukkan peningkatan kualitas hidup secara umum selama masa nifas dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapat edukasi yang memadai (Yuliani & Susanti, 2021). Oleh karena itu, bidan diharapkan terus mengedukasi ibu tentang manajemen nyeri secara efektif sebagai bagian integral dalam asuhan pasca-persalinan.

3. Pemulihan Involusi Uterus dan Pemantauan Tanda Bahaya

Involusi uterus merupakan proses fisiologis di mana uterus kembali ke ukuran dan kondisi sebelum kehamilan, biasanya terjadi dalam waktu 4 hingga 6 minggu pasca-persalinan (Purwati & Sari, 2023). Pemulihan involusi yang normal penting untuk mencegah komplikasi serius seperti perdarahan postpartum. Bidan bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan rutin melalui pemeriksaan fisik dan palpasi fundus uteri untuk menilai ketinggian serta konsistensi uterus.

Pemantauan tanda bahaya juga menjadi bagian esensial dalam edukasi yang diberikan bidan. Tanda bahaya meliputi perdarahan berlebihan, bau tidak sedap dari cairan vagina, demam tinggi, nyeri perut hebat, serta nyeri hebat pada luka jahitan (Kurniawati & Widarwati, 2021). Bidan perlu memastikan ibu mampu mengenali tanda-tanda bahaya tersebut dan mengetahui langkah-langkah penanganan yang harus segera dilakukan. Studi menunjukkan bahwa edukasi intensif terkait tanda bahaya nifas secara signifikan mengurangi risiko keterlambatan deteksi komplikasi yang serius (Sari & Dewi, 2022).

Secara keseluruhan, pemulihan fisik ibu pasca-persalinan memerlukan edukasi yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui peran aktif bidan dalam memberikan edukasi yang berbasis bukti, kesehatan ibu dan bayi dapat dijamin secara optimal.

C. Asuhan Psikologis Ibu Pasca-persalinan

Periode pasca-persalinan tidak hanya berdampak pada fisik ibu, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologisnya. Perubahan hormonal, kelelahan fisik, serta tantangan baru dalam mengurus bayi berkontribusi signifikan terhadap kondisi psikologis ibu. Asuhan psikologis yang komprehensif dan tepat waktu menjadi penting dalam mencegah dan mengelola berbagai kondisi psikologis yang mungkin timbul selama masa ini, seperti baby blues dan depresi postpartum (WHO, 2022).

1. Identifikasi dan Manajemen Kondisi Baby Blues

Baby blues adalah kondisi psikologis ringan yang umum dialami oleh ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih, mudah menangis, cemas, cepat marah, dan kelelahan. Gejala ini umumnya berlangsung singkat, sekitar dua minggu pasca-persalinan (Putri, Anggarawati, & Rahayu, 2020). Penting bagi bidan untuk mengidentifikasi gejala ini sejak dini agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti depresi postpartum.

Identifikasi kondisi ini melibatkan pengamatan terhadap perubahan suasana hati, pola tidur, serta tingkat kelelahan ibu. Manajemen baby blues meliputi pendekatan psikososial yang mendukung, seperti validasi perasaan ibu, edukasi mengenai normalitas gejala ini, serta intervensi sederhana seperti istirahat yang cukup, dukungan emosional dari keluarga, serta komunikasi yang efektif dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya (Nisa & Rahayu, 2021).

2. Pencegahan dan Edukasi Terkait Depresi Postpartum

Depresi postpartum merupakan gangguan suasana hati yang lebih serius dibandingkan baby blues, yang ditandai oleh perasaan sedih mendalam, kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, perasaan bersalah atau tidak berharga, gangguan tidur yang serius, bahkan ide bunuh diri dalam kasus yang parah (Rahmawati & Andayani, 2023). Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat berpengaruh buruk pada kesehatan mental ibu dan perkembangan bayi.

Bidan memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi pencegahan depresi postpartum melalui identifikasi dini faktor risiko, seperti riwayat depresi sebelumnya, dukungan sosial yang rendah, atau stres tinggi selama kehamilan (Puspitasari & Handayani, 2022). Edukasi yang disampaikan mencakup strategi koping stres, teknik relaksasi, pengenalan dini tanda dan gejala depresi postpartum, serta pentingnya meminta bantuan profesional ketika diperlukan. Pendekatan preventif yang dilakukan sejak masa kehamilan terbukti efektif dalam menurunkan risiko depresi postpartum secara signifikan (Purwanti & Susanti, 2021).

3. Peran Dukungan Keluarga dan Komunitas dalam Mendukung Kesejahteraan Mental Ibu

Dukungan keluarga dan komunitas memiliki peran sentral dalam menjaga kesejahteraan mental ibu selama periode pasca-persalinan. Studi menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional, fisik, dan sosial dari keluarga maupun komunitas memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan psikologis seperti baby blues dan depresi postpartum (Mariana & Putri, 2022). Dukungan yang dimaksud meliputi partisipasi aktif keluarga dalam membantu aktivitas sehari-hari, pendampingan psikologis dari pasangan, serta adanya komunitas ibu-ibu pasca-persalinan yang menyediakan wadah untuk berbagi pengalaman.

Bidan perlu mengedukasi keluarga tentang pentingnya peran mereka, seperti memberi perhatian ekstra, membantu perawatan bayi, serta mendukung ibu secara emosional dan psikologis. Adanya intervensi berbasis komunitas, seperti kelompok dukungan ibu menyusui atau kelompok ibu nifas, secara efektif meningkatkan rasa percaya diri ibu, mengurangi isolasi sosial, serta mempercepat pemulihan psikologis (Widiyawati & Damayanti, 2021). Oleh sebab itu, bidan harus aktif berkolaborasi dengan keluarga dan komunitas lokal dalam menyediakan dukungan berkelanjutan bagi kesejahteraan mental ibu pasca-persalinan.

D. Edukasi Menyusui

Menyusui merupakan proses penting yang memberikan manfaat gizi, imunitas, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Keberhasilan menyusui eksklusif tidak terlepas dari edukasi komprehensif yang diberikan oleh bidan sejak masa kehamilan hingga periode pasca-persalinan (WHO, 2022). Edukasi menyusui perlu mencakup teknik menyusui yang tepat, pencegahan dan manajemen masalah umum menyusui, serta pentingnya nutrisi ibu dalam meningkatkan kualitas ASI.

1. Teknik Menyusui yang Tepat untuk Meningkatkan Keberhasilan Menyusui Eksklusif

Edukasi mengenai teknik menyusui yang tepat sangat penting untuk mendukung keberhasilan menyusui eksklusif. Teknik yang benar meliputi posisi menyusui yang nyaman, perlekatan mulut bayi yang tepat pada puting ibu, serta tanda-tanda bahwa bayi mendapatkan cukup ASI (Kusumawardhani & Widiyawati, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa posisi cradle (menyangga bayi dengan satu tangan), cross-cradle, football hold, dan berbaring miring adalah beberapa posisi

yang direkomendasikan karena dapat meningkatkan kenyamanan ibu serta efektivitas pemberian ASI (Pratiwi, Yuliati, & Nurmiati, 2022).

Edukasi oleh bidan sebaiknya diberikan dengan demonstrasi langsung maupun melalui media audiovisual untuk memastikan ibu memahami teknik yang benar. Penelitian terbaru menemukan bahwa ibu yang menerima edukasi intensif mengenai teknik menyusui selama kehamilan menunjukkan peningkatan keberhasilan menyusui eksklusif hingga 40% lebih tinggi dibandingkan ibu tanpa edukasi tersebut (Sari & Dewi, 2021).

2. Pencegahan dan Manajemen Masalah Umum dalam Menyusui

Beberapa masalah umum yang sering dialami oleh ibu menyusui antara lain mastitis, puting lecet, dan produksi ASI yang sedikit. Mastitis merupakan inflamasi atau infeksi jaringan payudara yang disebabkan oleh penyumbatan saluran ASI, sering disertai nyeri, pembengkakan, kemerahan, dan demam (Ramadhani & Nuryani, 2022). Pencegahannya meliputi teknik perlekatan bayi yang tepat, rutin mengosongkan payudara, serta menjaga kebersihan payudara.

Masalah puting lecet biasanya disebabkan oleh perlekatan yang salah. Pencegahan utamanya adalah memastikan bayi menyusui dengan perlekatan mulut yang tepat. Jika lecet terjadi, bidan dapat merekomendasikan penggunaan salep lanolin murni, kompres hangat, atau ASI itu sendiri yang memiliki efek penyembuhan alami (Putri & Handayani, 2020).

Sementara itu, produksi ASI yang sedikit sering kali menjadi kekhawatiran ibu. Edukasi tentang teknik stimulasi laktasi seperti skin-to-skin contact, teknik breast massage, serta frekuensi menyusui yang sering dapat meningkatkan produksi ASI secara signifikan (Hartini & Yunita, 2021). Penelitian membuktikan bahwa pemberian edukasi sejak dini dapat secara efektif mengurangi risiko masalah-masalah ini, sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan ibu dalam proses menyusui (Rahayu, 2022).

3. Pentingnya Nutrisi Ibu Menyusui untuk Meningkatkan Kualitas ASI

Nutrisi yang optimal bagi ibu menyusui sangat penting untuk menjamin produksi serta kualitas ASI yang diberikan kepada bayi. Edukasi yang diberikan oleh bidan sebaiknya mencakup pentingnya konsumsi protein, karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, serta cairan yang cukup (Savitri & Sulistiyowati, 2022). Ibu menyusui juga perlu disadarkan akan pentingnya zat besi, kalsium, dan asam folat dalam mendukung kebutuhan nutrisi ibu serta pertumbuhan optimal bayi.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pola makan yang sehat dengan konsumsi sayur, buah, protein tinggi, serta cairan yang cukup dapat

meningkatkan volume dan kualitas ASI, termasuk kandungan lemak, protein, serta imunoglobulin yang penting bagi imunitas bayi (Wulandari & Rosaria, 2023). Bidan perlu mengedukasi ibu tentang pemilihan makanan yang tepat, penggunaan suplemen tambahan jika diperlukan, serta menghindari konsumsi zat yang dapat merugikan kualitas ASI seperti kafein berlebihan, alkohol, atau makanan dengan pengawet tinggi (WHO, 2022).

Secara keseluruhan, edukasi menyusui yang lengkap dan berbasis bukti merupakan langkah penting dalam mendukung ibu untuk mencapai keberhasilan menyusui eksklusif serta menjamin kesehatan optimal ibu dan bayi.

E. Perawatan Bayi Baru Lahir

Perawatan bayi baru lahir merupakan komponen penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan bayi secara optimal. Edukasi yang diberikan oleh bidan kepada orang tua tentang perawatan dasar bayi baru lahir mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri orang tua dalam mengidentifikasi kondisi sehat maupun tanda-tanda bahaya pada bayi (WHO, 2022).

1. Edukasi tentang Tanda-tanda Bayi Sehat dan Tanda Bahaya Neonatal

Pengenalan tanda-tanda bayi sehat maupun bahaya neonatal sejak dini sangat penting guna mencegah komplikasi serius. Tanda-tanda bayi sehat meliputi warna kulit kemerahan, tangisan kuat dan aktif, refleks menyusu yang baik, suhu tubuh normal ($36,5^{\circ}\text{C}$ – $37,5^{\circ}\text{C}$), pernapasan teratur (30-60 kali/menit), serta aktivitas motorik yang aktif (Rizki & Sutini, 2022).

Sebaliknya, tanda bahaya neonatal mencakup demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$), hipotermia ($<36,5^{\circ}\text{C}$), pernapasan cepat atau sesak napas, bayi tampak lemas, penurunan aktivitas menyusu secara drastis, muntah terus menerus, kulit pucat atau kebiruan (sianosis), kejang, serta infeksi tali pusat (umbilikus berbau, merah, atau bernanah) (Astuti & Sari, 2021). Edukasi bidan melalui komunikasi yang jelas dan demonstrasi visual membantu ibu dalam mengenali tanda-tanda bahaya tersebut sehingga mampu segera mencari pertolongan medis yang tepat waktu (Kusuma & Wulandari, 2023).

2. Perawatan Tali Pusat yang Benar dan Pencegahan Infeksi

Perawatan tali pusat adalah aspek penting dalam perawatan neonatal, karena kesalahan dalam perawatan dapat menyebabkan infeksi serius. Berdasarkan penelitian terbaru, tali pusat sebaiknya dibiarkan terbuka (tidak ditutup perban) agar cepat mengering, selalu dijaga kebersihannya, dan dijaga

agar tetap kering (Juniarti & Susanti, 2021). WHO merekomendasikan pembersihan tali pusat secara rutin menggunakan air bersih atau klorheksidin untuk mencegah infeksi (WHO, 2022).

Bidan perlu memberikan edukasi tentang tanda-tanda infeksi tali pusat, seperti kemerahan di sekitar tali pusat, keluarnya nanah, bau tidak sedap, serta perdarahan yang tidak normal. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi tentang perawatan tali pusat yang benar mampu menurunkan angka infeksi neonatal secara signifikan, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas (Nugraha & Armini, 2020).

3. Imunisasi Dasar Bayi dan Pemantauan Tumbuh Kembang Awal Bayi

Imunisasi dasar adalah langkah preventif utama dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit menular berbahaya seperti hepatitis B, polio, BCG (tuberkulosis), difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella, dan pneumokokus. Bidan berperan penting dalam memberikan informasi terkait jadwal imunisasi, manfaat imunisasi, serta efek samping ringan yang mungkin muncul (Hartati & Wulandari, 2021).

Selain imunisasi, pemantauan tumbuh kembang bayi baru lahir secara rutin diperlukan guna mendeteksi dini gangguan perkembangan atau tumbuh kembang abnormal. Pemantauan mencakup pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, serta observasi pencapaian kemampuan motorik dan sensorik sesuai dengan usia bayi (Safitri & Murti, 2022). Studi terbaru menemukan bahwa pemantauan rutin yang dilakukan sejak periode neonatal mampu meningkatkan deteksi dini gangguan tumbuh kembang, sehingga intervensi dapat segera dilakukan (Handayani & Febrianti, 2023).

Bidan sebagai pemberi layanan kesehatan primer perlu memastikan orang tua memahami pentingnya imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang rutin. Edukasi ini secara signifikan membantu orang tua dalam memberikan asuhan terbaik bagi bayi baru lahir demi kesehatan jangka panjang bayi tersebut.

F. Edukasi Pencegahan Infeksi Pasca-persalinan

Masa nifas merupakan masa sensitif terhadap berbagai risiko infeksi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan bayi. Infeksi pasca-persalinan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal, sehingga edukasi preventif dari bidan menjadi sangat esensial dalam meningkatkan kesadaran ibu akan pentingnya menjaga kebersihan serta mengenali gejala infeksi secara dini (WHO, 2022).

1. Strategi Kebersihan Diri untuk Ibu dan Bayi dalam Mencegah Infeksi

Kebersihan diri merupakan strategi kunci dalam pencegahan infeksi selama masa nifas. Edukasi dari bidan meliputi praktik kebersihan personal ibu seperti mencuci tangan sebelum menyentuh bayi atau area genital, penggunaan pembalut bersih yang diganti secara rutin, serta mandi secara teratur untuk menjaga kebersihan tubuh (Putri & Handayani, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa kebersihan tangan yang konsisten dapat mengurangi risiko infeksi postpartum hingga 50% (Nugroho & Susanti, 2021).

Untuk bayi, edukasi kebersihan meliputi cara memandikan bayi dengan air bersih hangat, menjaga kebersihan tali pusat, dan memastikan lingkungan bayi tetap bersih serta bebas dari paparan patogen (Astuti & Sari, 2021). Studi terbaru membuktikan bahwa edukasi tentang praktik kebersihan neonatal secara signifikan menurunkan angka kejadian infeksi neonatal di negara berkembang (Jannah & Yuniati, 2023).

2. Pencegahan dan Penanganan Infeksi Saluran Reproduksi pada Masa Nifas

Infeksi saluran reproduksi merupakan komplikasi serius selama masa nifas, ditandai oleh gejala seperti demam, nyeri perut bawah, bau tidak sedap pada cairan nifas (lochia), dan perdarahan abnormal (Kurniasih & Saputra, 2022). Bidan perlu memberikan edukasi preventif yang meliputi praktik kebersihan genital rutin, menjaga luka perineum atau luka operasi caesar tetap bersih dan kering, serta menganjurkan penggunaan air bersih dan antiseptik ringan jika diperlukan (Wulandari & Harjanti, 2021).

Jika infeksi terdeteksi, tindakan segera seperti rujukan ke fasilitas kesehatan, terapi antibiotik yang tepat, serta pemantauan ketat diperlukan guna mencegah komplikasi lebih lanjut (Rahmawati & Susilawati, 2022). Edukasi yang jelas mengenai risiko infeksi, tanda-tanda dini, serta penanganan awal yang benar mampu mengurangi angka kejadian infeksi postpartum secara signifikan.

3. Pemantauan Gejala Infeksi Dini dan Tindakan Cepat Tanggap

Pemantauan dini terhadap tanda-tanda infeksi pasca-persalinan merupakan aspek kritis dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Gejala awal infeksi yang perlu dikenali ibu antara lain demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$), nyeri hebat di area luka perineum, keluarnya cairan bernanah dari luka, bau tidak sedap dari cairan nifas, serta gejala umum seperti nyeri kepala hebat dan rasa menggigil (Fitria & Setyarini, 2021).

Bidan harus mengedukasi ibu dan keluarga tentang pentingnya segera melaporkan gejala-gejala tersebut ke tenaga kesehatan untuk penanganan lebih

lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi tentang pemantauan tanda infeksi serta tindakan cepat tanggap mampu menurunkan risiko komplikasi serius hingga lebih dari 40% dibandingkan dengan kelompok tanpa edukasi yang memadai (Nurhayati & Wahyuningsih, 2023).

G. Pola Istirahat dan Aktivitas Pasca-persalinan

Periode pasca-persalinan membawa banyak perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial bagi ibu baru. Salah satu tantangan besar dalam masa ini adalah pengaturan pola istirahat dan aktivitas, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kelelahan berlebihan, memperlambat proses pemulihan fisik, dan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi postpartum (WHO, 2022). Oleh karena itu, edukasi yang tepat tentang pola istirahat dan aktivitas pasca-persalinan menjadi bagian penting dari asuhan kebidanan.

1. Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Istirahat Ibu Setelah Persalinan

Istirahat yang cukup sangat penting untuk mempercepat pemulihan ibu setelah persalinan. Namun, tantangan seperti menyusui, merawat bayi, serta perubahan hormonal sering kali menyebabkan gangguan pola tidur. Edukasi yang diberikan bidan perlu mencakup strategi praktis seperti tidur saat bayi tidur, pembagian tugas dengan pasangan atau keluarga, menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk tidur, serta penggunaan teknik relaksasi seperti meditasi ringan dan pernapasan dalam (Rakhmawati & Suryani, 2022).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa ibu yang menerapkan teknik relaksasi sederhana, seperti meditasi mindfulness atau relaksasi otot progresif sebelum tidur, menunjukkan peningkatan kualitas istirahat dan pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan strategi tersebut (Hartini & Susanti, 2023). Bidan berperan penting dalam mengenalkan berbagai metode tersebut serta membantu ibu dalam membuat jadwal istirahat realistis yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan keluarga.

2. Aktivitas Fisik Ringan untuk Mempercepat Pemulihan Fisik

Aktivitas fisik ringan yang dimulai secara bertahap setelah persalinan terbukti bermanfaat dalam mempercepat pemulihan fisik, membantu mengembalikan kekuatan otot perut dan dasar panggul, serta meningkatkan kesejahteraan mental ibu (Putri & Nurhayati, 2021). Bidan perlu memberikan edukasi tentang aktivitas yang aman, seperti latihan dasar panggul (Kegel), peregangan ringan, jalan kaki singkat, serta latihan pernapasan dalam.

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ibu yang melakukan aktivitas fisik ringan sejak minggu pertama pasca-persalinan mengalami pemulihan involusi

uterus yang lebih cepat, penurunan risiko konstipasi, serta peningkatan suasana hati dibandingkan ibu yang tidak melakukan aktivitas fisik (Sari & Wahyuningsih, 2022). Bidan harus menyesuaikan jenis dan intensitas aktivitas fisik dengan kondisi spesifik setiap ibu, mengingat ada perbedaan pemulihan pada persalinan normal dan persalinan melalui operasi caesar.

3. Edukasi tentang Manajemen Kelelahan dan Penyesuaian Pola Aktivitas Baru

Kelelahan merupakan kondisi umum yang dialami ibu pada masa nifas akibat tuntutan baru dalam merawat bayi. Kelelahan kronis dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik ibu. Oleh karena itu, edukasi tentang manajemen kelelahan sangat penting. Edukasi yang diberikan oleh bidan meliputi teknik pengelolaan waktu, prioritas tugas sehari-hari, membagi peran dengan anggota keluarga, serta teknik self-care sederhana seperti pijat ringan atau mandi hangat (Hidayati & Astuti, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan edukasi tentang manajemen kelelahan mengalami tingkat stres dan depresi postpartum yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan ibu tanpa edukasi tersebut (Dewi & Yulianti, 2022). Selain itu, penting pula memberikan edukasi tentang cara menyesuaikan diri dengan pola aktivitas baru yang menyesuaikan rutinitas merawat bayi dan aktivitas rumah tangga lainnya. Pendekatan edukatif yang holistik ini membantu ibu lebih percaya diri dan mampu mengelola kelelahan secara efektif.

H. Nutrisi Pasca-persalinan

Nutrisi pada masa pasca-persalinan merupakan faktor penting yang memengaruhi pemulihan fisik ibu serta kualitas produksi ASI. Nutrisi yang baik dan seimbang membantu ibu dalam mengatasi perubahan fisiologis, mempercepat penyembuhan luka, serta mendukung kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh (WHO, 2022). Oleh karena itu, edukasi nutrisi yang tepat oleh bidan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemulihan pasca-persalinan.

1. Pola Makan yang Mendukung Pemulihan Fisik Ibu

Pemulihan fisik ibu setelah persalinan sangat dipengaruhi oleh pola makan yang sehat dan seimbang. Edukasi yang diberikan oleh bidan mencakup pentingnya konsumsi makanan dengan kandungan protein tinggi seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan kacang-kacangan untuk mempercepat penyembuhan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan selama persalinan (Rahmawati & Putri, 2021). Selain itu, konsumsi makanan kaya serat seperti buah

dan sayuran diperlukan untuk mencegah konstipasi, masalah yang sering terjadi pada ibu nifas (Handayani & Rahayu, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pola makan dengan frekuensi kecil namun teratur serta menghindari makanan olahan tinggi gula dan garam dapat membantu menjaga stabilitas energi serta mencegah lonjakan gula darah yang bisa memperlambat proses pemulihan tubuh pasca-persalinan (Nuryanti & Wulandari, 2022).

2. Nutrisi Penting untuk Meningkatkan Produksi ASI

Produksi ASI yang cukup dan berkualitas tinggi sangat tergantung pada asupan nutrisi ibu selama masa menyusui. Edukasi bidan sebaiknya menekankan pada nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, zat besi, kalsium, vitamin D, dan cairan yang cukup (Astuti & Susanti, 2023). Konsumsi ikan berlemak seperti salmon, kacang-kacangan, telur, susu rendah lemak, serta biji-bijian utuh diketahui secara ilmiah membantu meningkatkan volume serta kualitas ASI (Savitri & Rosalia, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asupan cairan yang memadai (minimal 8-10 gelas sehari) sangat penting dalam menjaga hidrasi tubuh ibu serta meningkatkan produksi ASI secara signifikan (Wulandari & Sari, 2023). Edukasi yang jelas dari bidan mengenai pemilihan makanan sehat ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menyusui eksklusif.

3. Suplemen Gizi dan Makanan Tradisional untuk Mempercepat Pemulihan

Dalam beberapa kasus, pemulihan ibu setelah melahirkan juga dibantu dengan penggunaan suplemen gizi. Suplemen yang sering dianjurkan adalah zat besi untuk mencegah anemia, kalsium dan vitamin D untuk mendukung kesehatan tulang, serta suplemen omega-3 untuk membantu pemulihan jaringan tubuh dan meningkatkan kualitas ASI (Nurhayati & Pratiwi, 2021).

Selain suplemen medis, makanan tradisional seperti daun katuk (*Sauropus androgynus*), daun kelor (*Moringa oleifera*), dan kunyit asam secara tradisional dipercaya dapat membantu mempercepat pemulihan serta meningkatkan produksi ASI. Penelitian terbaru membuktikan bahwa konsumsi ekstrak daun katuk dan daun kelor secara signifikan meningkatkan produksi ASI, mempercepat pemulihan energi, dan mengurangi risiko infeksi postpartum (Rahmi & Utami, 2022). Edukasi tentang penggunaan makanan tradisional ini harus tetap memperhatikan keamanan serta interaksi dengan pengobatan medis yang sedang digunakan ibu.

Secara keseluruhan, edukasi nutrisi pasca-persalinan yang terstruktur dan didasarkan pada bukti ilmiah akan membantu ibu untuk menjalani masa nifas yang sehat serta mendukung perkembangan bayi yang optimal melalui ASI yang berkualitas.

I. Edukasi tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pasca-persalinan

Masa pasca-persalinan tidak hanya menuntut pemulihan fisik, namun juga memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan seksual dan reproduksi ibu. Edukasi yang tepat mengenai kapan boleh kembali berhubungan seksual, penggunaan kontrasepsi pasca-persalinan, serta pemahaman tentang siklus menstruasi dan perencanaan kehamilan berikutnya, menjadi aspek penting untuk mendukung kesejahteraan ibu dan keluarga secara keseluruhan (WHO, 2022).

1. Kapan Boleh Kembali Melakukan Hubungan Seksual dan Perawatan Kesehatan Reproduksi Pasca-persalinan

Salah satu pertanyaan umum yang muncul setelah persalinan adalah kapan waktu yang tepat untuk kembali melakukan hubungan seksual. Secara umum, hubungan seksual dapat dimulai kembali setelah periode pemulihan nifas selesai, yaitu sekitar 4 hingga 6 minggu setelah persalinan (Fitriani & Susanti, 2022). Namun, bidan perlu menekankan bahwa waktu yang tepat tergantung pada kondisi fisik dan psikologis ibu, seperti penyembuhan luka perineum atau luka operasi caesar, serta kesiapan emosional ibu.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu yang mendapat edukasi jelas mengenai pemulihan reproduksi dan hubungan seksual mengalami tingkat kepuasan hubungan seksual yang lebih tinggi, serta mengurangi kecemasan yang mungkin timbul akibat perubahan tubuh setelah persalinan (Kurniati & Saputra, 2021). Bidan juga harus menekankan pentingnya menjaga kebersihan genital serta memantau tanda-tanda infeksi yang mungkin timbul setelah hubungan seksual kembali aktif.

2. Edukasi Penggunaan Kontrasepsi Pasca-persalinan

Edukasi mengenai kontrasepsi pasca-persalinan bertujuan untuk membantu ibu dalam merencanakan jarak kehamilan yang aman dan sehat. Menurut WHO (2022), jarak ideal antar kehamilan minimal 24 bulan untuk memastikan ibu pulih sepenuhnya secara fisik dan emosional serta bayi mendapatkan perhatian optimal. Kontrasepsi yang disarankan antara lain IUD (Intra Uterine Device), pil mini (progestin-only pill), implan, atau metode suntikan tiga bulan (Hartati & Yulianti, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa pemberian edukasi intensif tentang kontrasepsi sejak masa kehamilan akhir atau segera setelah persalinan mampu meningkatkan kepatuhan penggunaan kontrasepsi, mencegah kehamilan tidak direncanakan, serta mendukung pemulihan kesehatan ibu secara keseluruhan (Sari & Dewi, 2023). Oleh karena itu, bidan harus memastikan bahwa edukasi yang diberikan mencakup manfaat, efek samping, cara penggunaan, serta akses layanan kontrasepsi yang tepat bagi ibu.

3. Pemahaman Siklus Menstruasi dan Perencanaan Kehamilan Berikutnya

Pemahaman tentang siklus menstruasi pasca-persalinan merupakan bagian penting dari edukasi kesehatan reproduksi, karena banyak ibu mengalami perubahan siklus menstruasi setelah melahirkan, terutama selama periode menyusui eksklusif (laktasi amenore). Secara umum, siklus menstruasi ibu yang menyusui eksklusif dapat tertunda hingga beberapa bulan setelah persalinan (Astuti & Rahmawati, 2021).

Bidan perlu memberikan edukasi mengenai tanda-tanda menstruasi pertama setelah melahirkan, faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan siklus, serta pentingnya mencatat siklus menstruasi untuk membantu perencanaan kehamilan berikutnya (Nisa & Handayani, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu yang memahami siklus menstruasi pasca-persalinan memiliki kemampuan lebih baik dalam merencanakan jarak kehamilan dan mampu mengelola kesehatan reproduksinya dengan optimal (Rahayu & Putri, 2023).

Dengan edukasi yang komprehensif dan tepat waktu, ibu dan keluarga dapat membuat keputusan terbaik terkait kehidupan seksual, kontrasepsi, serta perencanaan kehamilan berikutnya, sehingga kesejahteraan ibu secara fisik dan emosional dapat terus dijaga.

J. Kolaborasi dan Dukungan Sosial

Kolaborasi yang kuat serta dukungan sosial yang optimal dari keluarga dan komunitas sangat esensial dalam masa pemulihan pasca-persalinan. Dukungan sosial yang efektif terbukti mempercepat pemulihan fisik dan psikologis ibu, meningkatkan kualitas menyusui, serta memberikan dampak positif pada perkembangan bayi secara keseluruhan (WHO, 2022). Dalam konteks ini, bidan memiliki peran penting untuk mengintegrasikan dukungan keluarga dan komunitas serta memberikan edukasi secara aktif kepada keluarga tentang peran mereka selama masa pemulihan ibu dan bayi.

1. Peran Bidan dalam Mengintegrasikan Dukungan Keluarga dan Komunitas

Bidan sebagai penyedia layanan kesehatan primer berperan kunci dalam mengintegrasikan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas ke dalam asuhan kebidanan pasca-persalinan. Peran ini mencakup identifikasi sumber-sumber dukungan yang tersedia, seperti keluarga inti, keluarga besar, tokoh masyarakat, serta layanan komunitas seperti Posyandu, kelompok ibu menyusui, dan layanan konseling kesehatan mental komunitas (Wulandari & Susanti, 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ibu yang menerima dukungan sosial terintegrasi memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi postpartum, lebih berhasil dalam pemberian ASI eksklusif, serta memiliki kualitas pemulihan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak menerima dukungan tersebut (Nurhayati & Rahayu, 2022). Oleh sebab itu, bidan perlu aktif membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi komunitas, agar dukungan sosial dapat tersalurkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Mengoptimalkan Dukungan Sosial dari Kelompok Ibu Menyusui dan Komunitas Lokal

Kelompok ibu menyusui dan komunitas lokal menjadi sumber dukungan yang sangat efektif bagi ibu selama masa nifas. Dalam kelompok tersebut, ibu dapat berbagi pengalaman, mendapatkan informasi terkini mengenai praktik terbaik dalam perawatan bayi, serta mendapatkan dukungan emosional yang membantu mereka dalam mengatasi stres dan tantangan baru setelah persalinan (Putri & Handayani, 2021).

Penelitian membuktikan bahwa keikutsertaan ibu dalam kelompok menyusui atau komunitas ibu nifas secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menyusui, mengurangi tingkat kecemasan, serta mempercepat pemulihan fisik dan psikologis (Savitri & Dewi, 2022). Untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, bidan perlu memfasilitasi keterlibatan ibu dalam kelompok lokal ini, termasuk memberikan informasi jelas mengenai jadwal pertemuan rutin dan jenis dukungan yang tersedia.

3. Edukasi Keluarga tentang Peran Pendukung dalam Masa Pemulihan Ibu dan Bayi

Keluarga memiliki peran penting sebagai pendukung utama dalam pemulihan ibu dan bayi pasca-persalinan. Edukasi bidan kepada keluarga tentang pentingnya peran mereka sangat dibutuhkan untuk memastikan ibu mendapat dukungan fisik, emosional, serta sosial secara optimal (Astuti & Susilawati, 2023).

Edukasi tersebut mencakup pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab anggota keluarga dalam mendukung pemulihan ibu seperti membantu merawat bayi, menyediakan waktu istirahat yang cukup bagi ibu, membantu tugas rumah tangga sehari-hari, serta memberikan dukungan emosional yang kontinu.

Penelitian terbaru menyatakan bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi intensif tentang peran dukungan mereka cenderung menunjukkan partisipasi lebih aktif dalam merawat ibu dan bayi, serta berkontribusi positif dalam mengurangi risiko gangguan psikologis pada ibu seperti depresi postpartum (Rahmawati & Saputra, 2022). Bidan harus secara jelas menyampaikan manfaat dari dukungan keluarga ini agar keluarga termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif.

Dengan kolaborasi yang optimal antara bidan, keluarga, dan komunitas lokal, masa pemulihan pasca-persalinan ibu dapat berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan dengan tingkat kepuasan yang tinggi bagi ibu dan keluarganya.

K. Monitoring dan Evaluasi Edukasi Pasca-persalinan

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek esensial dalam program edukasi pasca-persalinan, karena dapat memberikan informasi yang akurat tentang efektivitas intervensi edukasi serta menjadi dasar perbaikan layanan di masa depan. Melalui evaluasi yang efektif, bidan dapat memastikan bahwa edukasi yang diberikan benar-benar membantu ibu dalam mencapai pemulihan optimal serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi (WHO, 2022).

1. Metode Efektif untuk Evaluasi Keberhasilan Edukasi

Evaluasi keberhasilan edukasi pasca-persalinan membutuhkan metode yang efektif dan sesuai konteks pelayanan kebidanan. Metode evaluasi yang umum digunakan mencakup kuesioner sebelum dan sesudah intervensi (pretest-posttest), wawancara mendalam, observasi langsung, serta penggunaan kelompok fokus diskusi (FGD). Metode pretest-posttest menjadi yang paling sering digunakan karena dapat secara jelas menunjukkan peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik ibu setelah menerima edukasi (Hidayati & Utami, 2022).

Selain itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau FGD dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang persepsi ibu terhadap edukasi yang diterima, hambatan yang dialami dalam penerapan pengetahuan, serta saran untuk perbaikan layanan edukasi di masa mendatang (Nugroho & Suryani, 2021). Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif memberikan data yang lebih komprehensif tentang efektivitas edukasi.

2. Indikator Keberhasilan Edukasi dalam Praktik Kebidanan

Indikator keberhasilan edukasi pasca-persalinan merupakan parameter penting yang digunakan untuk menilai apakah tujuan edukasi tercapai atau tidak. Indikator yang umum digunakan dalam evaluasi edukasi pasca-persalinan mencakup peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan diri dan bayi, peningkatan keterampilan praktik perawatan bayi, penurunan angka komplikasi masa nifas, peningkatan angka menyusui eksklusif, serta penurunan prevalensi gangguan psikologis seperti baby blues atau depresi postpartum (Widyaningsih & Handayani, 2022).

Studi terkini menyebutkan bahwa indikator lain yang penting adalah tingkat kepuasan ibu terhadap layanan edukasi yang diberikan oleh bidan, serta tingkat kepercayaan diri ibu dalam menerapkan informasi yang didapat dari edukasi dalam kehidupan sehari-hari (Astuti & Rahmawati, 2023). Oleh karena itu, pemilihan indikator perlu mencakup aspek pengetahuan, sikap, perilaku, serta kepuasan ibu terhadap layanan edukasi.

3. Strategi Pengumpulan Data untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Edukasi Pasca-persalinan

Pengumpulan data yang akurat dan sistematis sangat diperlukan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan edukasi pasca-persalinan secara berkelanjutan. Strategi pengumpulan data mencakup survei rutin dengan kuesioner baku, wawancara mendalam berkala dengan ibu pasca-persalinan, serta pengumpulan data sekunder melalui catatan medis atau rekam kebidanan (Savitri & Handayani, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi kesehatan berbasis digital dan telehealth juga terbukti efektif dalam mengumpulkan data yang cepat, akurat, dan real-time tentang respon ibu terhadap edukasi yang diberikan (Fitriani & Yuliana, 2023). Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengumpulan data mampu meningkatkan efisiensi layanan edukasi serta memberikan basis data yang kuat untuk analisis dan pengambilan keputusan klinis oleh bidan (Kusumawati & Sari, 2023).

Dengan metode evaluasi yang tepat, indikator keberhasilan yang jelas, serta strategi pengumpulan data yang sistematis, bidan dapat memastikan kualitas edukasi pasca-persalinan yang tinggi, sehingga mampu secara nyata meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

L. Penutup

Edukasi pasca-persalinan merupakan bagian integral dari praktik kebidanan yang memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan. Melalui edukasi yang tepat dan komprehensif, bidan dapat secara nyata meningkatkan kualitas hidup ibu serta menjamin tumbuh kembang bayi yang optimal. Meski demikian, berbagai tantangan masih sering ditemukan dalam implementasi edukasi ini, sehingga memerlukan perhatian khusus dan strategi yang tepat guna memastikan efektivitas edukasi secara maksimal di masa depan (WHO, 2022).

1. Tantangan dan Rekomendasi dalam Penerapan Edukasi Pasca-persalinan

Implementasi edukasi pasca-persalinan di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, di antaranya rendahnya tingkat pemahaman ibu tentang pentingnya edukasi, keterbatasan waktu bidan untuk memberikan edukasi secara mendalam akibat tingginya beban kerja, serta keterbatasan sumber daya dalam fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil (Rahmawati & Susilawati, 2022). Selain itu, masih rendahnya dukungan keluarga dan komunitas dalam mendukung pelaksanaan edukasi menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi (Putri & Handayani, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas bidan melalui pelatihan berkelanjutan, integrasi teknologi digital sebagai media edukasi tambahan yang lebih mudah diakses, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor dengan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya (Nurhayati & Rahayu, 2023). Penelitian terbaru menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga secara aktif sebagai strategi efektif dalam mengatasi tantangan ini, sehingga edukasi pasca-persalinan dapat lebih mudah diterima oleh ibu dan keluarga (Astuti & Rahmi, 2022).

2. Prospek Masa Depan Praktik Edukasi dalam Kebidanan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Ibu dan Bayi

Ke depan, praktik edukasi pasca-persalinan memiliki prospek yang sangat menjanjikan, terutama jika didukung oleh kemajuan teknologi dan pendekatan inovatif dalam pelayanan kebidanan. Penggunaan platform digital seperti aplikasi mobile kesehatan, telehealth, serta media sosial akan semakin luas digunakan, memungkinkan edukasi dapat menjangkau lebih banyak ibu di berbagai daerah dengan lebih efisien (Wulandari & Kusumawati, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam edukasi pasca-persalinan telah berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan praktik, serta

kepuasan ibu terhadap layanan kebidanan, terutama dalam situasi keterbatasan akses langsung ke fasilitas kesehatan (Savitri & Dewi, 2022). Selain itu, prospek ke depan juga mencakup peningkatan kolaborasi multidisiplin antara bidan dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, psikolog, serta tokoh masyarakat, yang terbukti efektif dalam memberikan layanan edukasi yang lebih holistik dan komprehensif (Hartati & Yulianti, 2023).

Dengan demikian, prospek praktik edukasi dalam kebidanan ke depan diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup ibu dan bayi. Komitmen berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, hingga pemangku kebijakan, akan menjadi kunci utama dalam memastikan pencapaian tersebut secara berkelanjutan.

Referensi

- Astuti, D., & Rahmawati, L. (2021). Faktor yang mempengaruhi kembalinya siklus menstruasi pada ibu menyusui eksklusif. *Jurnal Kebidanan Prima Nusantara*, 4(3), 115-121.
- Astuti, D., & Rahmi, S. (2022). Pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan efektivitas edukasi pasca-persalinan: tinjauan sistematis. *Jurnal Kebidanan Prima Nusantara*, 4(4), 120-128.
- Astuti, D., & Susanti, H. (2023). Nutrisi penting selama masa nifas untuk meningkatkan produksi ASI: literature review. *Jurnal Gizi dan Pangan Indonesia*, 8(2), 123-130.
- Astuti, D., & Susilawati, H. (2023). Edukasi peran keluarga sebagai pendukung utama pemulihan ibu nifas. *Jurnal Kebidanan Prima Nusantara*, 5(2), 67-74.
- Fitriani, N., & Yuliana, E. (2023). Efektivitas penggunaan aplikasi digital dalam monitoring edukasi ibu postpartum. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 8(1), 35-42.
- Fitriani, R., & Susanti, M. (2022). Edukasi hubungan seksual pasca-persalinan dan hubungannya dengan tingkat kepuasan seksual pasangan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Reproduksi*, 13(2), 145-152.
- Handayani, R., & Rahayu, S. (2023). Pola makan sehat dalam pencegahan konstipasi pada ibu postpartum. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 7(2), 78-85.
- Hartati, E., & Yulianti, R. (2023). Kolaborasi multidisiplin dalam praktik kebidanan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi: literature review. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 8(1), 45-52.
- Hidayati, R., & Utami, S. (2022). Metode evaluasi efektif untuk edukasi kebidanan: tinjauan sistematis. *Jurnal Kebidanan Prima Nusantara*, 4(3), 101-108.
- Kusumawati, E., & Sari, Y. (2023). Penggunaan teknologi telehealth dalam meningkatkan kualitas edukasi pasca-persalinan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 8(1), 24-31.
- Kurniati, N., & Saputra, R. (2021). Hubungan edukasi seksual pasca-persalinan terhadap tingkat kecemasan ibu nifas. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 9(2), 134-141.
- Nurhayati, N., & Pratiwi, R. (2021). Efektivitas suplementasi zat besi dan kalsium dalam mempercepat pemulihan ibu postpartum: systematic review. *Jurnal Kebidanan Prima Nusantara*, 3(2), 45-51.
- Nurhayati, N., & Rahayu, S. (2023). Tantangan dalam implementasi edukasi kebidanan dan rekomendasi solusi: studi kualitatif. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 8(1), 65-72.

- Nugroho, A., & Suryani, T. (2021). Pendekatan kualitatif dalam evaluasi program edukasi ibu nifas: studi literatur. *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Keperawatan*, 13(2), 88-95.
- Putri, A., & Handayani, R. (2021). Faktor penghambat implementasi edukasi pasca-persalinan dan peran dukungan keluarga. *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Keperawatan*, 12(4), 220-227.
- Rahmawati, I., & Susilawati, E. (2022). Identifikasi tantangan dalam praktik edukasi pasca-persalinan di daerah terpencil: studi kasus. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(4), 245-252.
- Rahmi, N., & Utami, P. (2022). Efektivitas daun katuk (*Sauropus androgynus*) dan daun kelor (*Moringa oleifera*) dalam meningkatkan produksi ASI pada ibu postpartum: tinjauan pustaka. *Journal of Maternal and Child Health*, 7(4), 255-262.
- Rahayu, D., & Putri, N. (2023). Pengaruh pemahaman siklus menstruasi terhadap keberhasilan perencanaan jarak kehamilan pada ibu postpartum. *Jurnal Ilmu Kebidanan Indonesia*, 15(1), 33-40.
- Savitri, D., & Dewi, A. (2022). Dampak partisipasi dalam komunitas ibu nifas terhadap percepatan pemulihan fisik dan mental ibu postpartum. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(4), 225-232.
- Savitri, N., & Handayani, R. (2022). Strategi pengumpulan data dalam evaluasi edukasi pasca-persalinan di layanan kebidanan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(3), 180-187.
- Savitri, E., & Rosalia, D. (2022). Hubungan konsumsi nutrisi makro dan mikro ibu menyusui dengan volume ASI. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 8(2), 112-118.
- Widyaningsih, Y., & Handayani, T. (2022). Evaluasi efektivitas edukasi pasca-persalinan terhadap peningkatan angka menyusui eksklusif. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(3), 165-172.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Family Planning and Contraceptive Methods Postpartum: Guidelines*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Guidelines on Postnatal Care for Mothers and Newborns*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Monitoring and Evaluation Framework for Postnatal Care*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Postnatal Care Guidelines for Mothers and Newborns*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Recommendations on Postnatal Care for Mothers and Newborns*. Geneva: WHO Press.

- Wulandari, P., & Kusumawati, E. (2023). Prospek penggunaan telehealth dalam edukasi pasca-persalinan untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(1), 38-45.
- Wulandari, P., & Sari, Y. (2023). Pentingnya konsumsi cairan untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu postpartum. *Jurnal Nutrisi Indonesia*, 9(1), 45-52.

Profil Penulis



Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb.

Lahir di Rumah Sumbul 13 Nopember 1987. Riwayat Pendidikan : D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumatera Utara (2009), Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara (USU) (2011). S2 Kebidanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar (2016). Pendidikan Profesi Bidan di INKES SUMUT (2022). Riwayat Pekerjaan : Bidan Pelaksana di Praktik Bidan Tahun 2009-2011, Dosen di INKES SUMUT (2011-sekarang), Dosen Tamu di Nusantara 2000 Tahun 2017-2018. Penulis dapat di hubungi melalui e-mail : emibarus@gmail.com
Motto : Kuatkan Hatimu, Jangan Lemah Semangatmu, Karna Ada Upah Bagi Usahamu



Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.

Lahir di Jambi, 07 Mei 1977. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Kesdam II/SWJ Cabang Jambi tahun 1996. Penulis melanjutkan Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Poltekkes Jambi tahun 2003. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2006. Dan Lulus Magister Kebidanan Universitas Andalas Padang tahun 2015. Saat ini penulis sebagai Dosen di Prodi Profesi Kebidanan dan aktif mengajar di STIKes Senior Medan. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan. Email: afriwanyanti@gmail.com
Motto "Teruslah Belajar Tak Perduli Berapa Usiamu, Orang Sukses adalah Orang Yang Selalu Ingin Belajar "



Dr. Yeni Fitrianiingsih., SST., MKes

Lahir di Kuningan, 12 Desember 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma 4 Pada Program Studi D4 Kebidanan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Sain Terapan UNDIP lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi DIKK (Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan), Universitas Diponegoro (UNDIP) lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 bekerja sebagai perawat di RS tahun 1990 – 2010 bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Kab Sukabumi dan Kota Cirebon serta Paramedis Teladan TK Jawa Barat Tahun 1997. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus dan bayi, Etika Hukum kesehatan dan Midwifery Entrepreneurship. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, Narasumber seminar dan sebagai Ketua IBI Kota Cirebon (Periode tahun 2018-2023), Sebagai Surveyor KAKP Akreditasi Puskesmas dan Klinik, Reviuwer Penelitian Jurnal Internasional dan nasional, , Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yfitrianiingsih44@gmail.com

Motto: "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."
– Winston Churchill

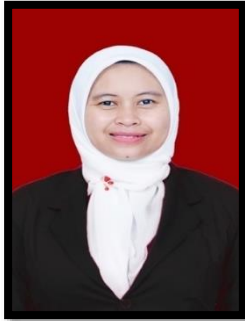


Bd. Zaitun Hilwa, S.Tr.Keb., M.K.M

Lahir di Bireuen, 20 April 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Almuslim tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S1/D4 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia Medan dan lulus tahun pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Institut Kesehatan Helvetia Medan dan lulus tahun pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi bidan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banda Aceh dan lulus tahun pada tahun 2022 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 sebagai dosen tetap pada prodi pendidikan profesi bidan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Al muslim Bireuen-Aceh mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks Etika dan Hukum Kesehatan, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir, Wirausaha/Entrepreneurship, Gawat Darurat Maternal Neonatal, Profesionalisme Kebidanan, Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi, Kegawatdaruratan Neonatal, Bayi dan Balita pada Kebencanaan, Kegawatdaruratan Maternal pada Kebencanaan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Kb dan Pelayanan Kontrasepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zhilwa.hilwa2004@gmail.com

Motto: "Radiate joy, embrace responsibility, and work hard to achieve your dreams"



Sherly Angellina, S.SiT., M.Keb

Penulis merupakan Dosen Program Studi DIII Kebidanan di Stikes Panca Bhakti Pontianak sejak Tahun 2015 hingga sekarang. Lahir di Teluk Air, 26 April 1992. Beliau menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto pada tahun 2012. Melanjutkan DIV kebidanan di Universitas Ngudi Waluyo Semarang pada tahun 2014. Serta melanjutkan pendidikan magister kebidanan di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta lulus pada tahun 2022. Penulis juga telah menulis buku saku : bingung perawatan tali pusat ??? Jangan Panik Momm !! pada tahun 2023, Buku Dear Ukom Kebidanan, I`am Ready!! Pada tahun 2024 dan Bunga Rampai Pendekatan Hipnoterapi pada Asuhan kebidanan pada tahun 2024 serta Buku Saku Kader Siap Cegah Stunting pada Tahun 2025 email : drivesherly@gmail.com



Lasria Simamora, SST., MKM

Lahir pada 25 Juni 1987 di Sibuntuon, Humbang Hasundutan, Medan, Sumatera Utara. Riwayat pendidikan: D III Akademi Kebidanan Dewi Maya Medan (2008), D IV Bidan Pendidik di Universitas Sumatera Utara (2013), S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara (2017), S1 Kebidanan di STIKes Mitra Husada Medan (2023), Profesi Bidan di STIKes Mitra Husada Medan (2024) . Riwayat Pekerjaan: Bidan di Praktek Mandiri Bidan Lasria Simampra (2018 - 2022), Dosen di STIKes Mitra Husada Medan (2017 - sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lasriasimamora@gmail.com
Motto: "Where there is a will, there is a way"

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul "**Peran Bidan dalam Pendampingan Persalinan Alami**" merupakan referensi komprehensif yang menggambarkan peran strategis bidan dalam mendampingi ibu melewati proses persalinan secara fisiologis. Buku ini mengangkat konsep bahwa pendampingan bidan tidak hanya berorientasi pada prosedur medis, tetapi juga pada aspek edukatif, psikologis, dan kolaboratif yang esensial untuk keberhasilan persalinan alami.

Bab pertama membahas pentingnya edukasi bagi ibu hamil mengenai manfaat persalinan alami yang tidak hanya mengurangi risiko intervensi medis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri ibu. Bab kedua dan ketiga menjelaskan strategi manajemen nyeri non-farmakologis serta pentingnya pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan selama proses persalinan.

Dukungan psikologis menjadi sorotan utama pada bab keempat, di mana bidan berperan dalam menciptakan suasana positif yang dapat mengurangi kecemasan ibu. Sementara itu, bab kelima menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi dalam mendukung proses persalinan yang aman dan optimal. Bab terakhir ditutup dengan edukasi pasca persalinan sebagai langkah penting dalam pemulihan dan adaptasi ibu serta perawatan awal bayi.

Melalui pendekatan berbasis bukti, buku ini menjadi panduan praktis sekaligus akademik yang dapat memperkuat peran bidan dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang holistik, humanistik, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Buku Referensi yang berjudul "Peran Bidan dalam Pendampingan Persalinan Alami" merupakan referensi komprehensif yang menggambarkan peran strategis bidan dalam mendampingi ibu melewati proses persalinan secara fisiologis. Buku ini mengangkat konsep bahwa pendampingan bidan tidak hanya berorientasi pada prosedur medis, tetapi juga pada aspek edukatif, psikologis, dan kolaboratif yang esensial untuk keberhasilan persalinan alami.

Bab pertama membahas pentingnya edukasi bagi ibu hamil mengenai manfaat persalinan alami yang tidak hanya mengurangi risiko intervensi medis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri ibu. Bab kedua dan ketiga menjelaskan strategi manajemen nyeri non-farmakologis serta pentingnya pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkelanjutan selama proses persalinan. Dukungan psikologis menjadi sorotan utama pada bab keempat, di mana bidan berperan dalam menciptakan suasana positif yang dapat mengurangi kecemasan ibu. Sementara itu, bab kelima menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi dalam mendukung proses persalinan yang aman dan optimal. Bab terakhir ditutup dengan edukasi pasca persalinan sebagai langkah penting dalam pemulihan dan adaptasi ibu serta perawatan awal bayi.

Melalui pendekatan berbasis bukti, buku ini menjadi panduan praktis sekaligus akademik yang dapat memperkuat peran bidan dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang holistik, humanistik, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96041-7-8



9

786349

604178